



الجمهورية العربية السورية
وزارة الدفاع
وزارة الصحة
دائرة الخدمات الطبية العسكرية
شعبة التدريب والتأهيل

الإسعاف الحربي المتقدم

Advanced Military First Aid



الدورة التمهيدية

الطبعة الثالثة

١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٠ م



وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشْدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

ذَكَرَى الْمَوْلِدَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ ١٤٤٢ هـ

الافتتاحية

سم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى

آله، وبعد؛؛؛؛؛

نظراً لما تواجهه المسيرة القرآنية من حروب مستمرة من أعداء الله اليهود والنصارى وأعدائهم، وانطلاقاً من المسؤولية الكبرى والتي تقع على عاتق المجاهدين في سبيل الله ونصرة الحق والمستضعفين، وإقامة دين الله، ولما يمر به بلدنا في وقتنا الحالي من عدوان أمريكي صهيوني سعودي، فإنّ ثمة مسؤولية هامة تقع على عاتق الفرق الإسعافية والإنعاشية التي تعمل جنباً إلى جنب مع المجاهدين في ميادين القتال في مختلف الظروف لتقدم خدماتها الإسعافية والإنعاشية للمجاهدين الذين قد يصابوا أثناء مواجهة أعداء الأمة (اليهود والنصارى وأتباعهم). وبما أن إرادة الصمود والمواجهة الميدانية تجمع في داخلها عناصر متعددة لا بد لها أن تتكامل مع بعضها البعض، لتتجسد قوة وعزماً يلحق الهزيمة في صفوف الأعداء، ويبعث الروح المعنوية التي تلتقي مع الصبر والإعتماد على الله في صفوف المجاهدين أنفسهم. إن خصوصية منطقة العمليات التي غالباً ما تكون معرقة من النواحي الجغرافية وبعيدة نسبياً عن المراكز والمستشفيات الطبية العامة، تجعل المجاهد الذي قد يصاب بجروح في أرض المعركة أمام تحدٍ صعب مع عامل الوقت الذي يمنعه من الوصول إلى الأيادي الكفوة المتخصصة في المراكز والمستشفيات العامة في الوقت المناسب.

ولهذا فقد تحملنا هذه المسؤولية للحفاظ على حياة الجرحى، وتقليل حالة الخسائر البشرية التي تحدث أثناء المواجهة لأعداء الله، ومن واقع مسؤوليتنا الجهادية التي حُمِّلنا بها في المحافظة على حياة رجال الله وتقديم الخدمات الإسعافية والإنعاشية اللازمة لهم، والتي تعد عنصراً أساسياً من عناصر القوة التي لا بد أن نضع كل طاقاتنا وإمكانياتنا في سبيل تحقيق الأهداف التي ننشدها، والحفاظ على حياة الجرحى إمتثالاً لقول الله تعالى: ((ومن أحيها فكأنما أحيانا جميعاً)). وفي هذا السياق تم إعداد هذا المقرر الذي بين إيديكم (الإسعاف الحربي)، تحت أسس علمية، وواقع ميداني (تجربة عملية) بحيث يستطيع من خلاله المسعف الحربي أن يحافظ ويعالج الحالات الطارئة معالجة مؤقتة ومؤثره تحت أي ظرف ليتم بعدها نقلها إلى المراكز الرئيسية في الوقت المناسب. آملين أن نكون قد وقفنا لتقديم بعض ما هو ملقى على عاتقنا وأن يكون هذه المقرر بالشكل الذي يفي بالمتطلبات الفعلية للأخوة المجاهدين، سائلين المولى عز وجل التوفيق والقبول وحسن الاستفادة إنه نعم المولى ونعم النصير.

شعبة التدريب والتأهيل

الفهرس

رقم الصفحة	محتويات الكتاب
5	الافتتاحية
7	الفهرس
9	الفصل الأول : المبادئ العامة
15	الفصل الثاني : العلامات الحيوية
27	الفصل الثالث: الوفاة
32	الفصل الرابع : الإنعاش الأساسي
41	الفصل الخامس تصنيف المصابين
46	الفصل السادس: الفحص الشامل
52	الفصل السابع : الأختناق والغرق
56	الفصل الثامن: الصدمة
60	الفصل التاسع: التسمم
73	:الفصل العاشر: الإصابات والجروح
118	الفصل الحادي عشر: الحروق
123	الفصل الثاني عشر: الإخلاء للمصابين
132	الفصل الثالث عشر: الحمل والنقل
145	الفصل الرابع عشر: إدارة المهام الإسعافية

GENERAL PRINCIPLES

المبادئ العامة

1



المبادئ العامة General Principles

صفات المسعف الإنعاشي: يجب أن يكون:

- **نبيهاً:** يتوصل إلى معرفة أعراض الإصابة وتاريخها بتوجيه أسئلة محددة وسريعة.
- **ملاحظاً:** يكتشف أسباب وعلامات الإصابات بسرعة ودقة.
- **مدبراً:** يستعين بكل الوسائل الموجودة في المحيط من حوله.
- **بارعاً:** يقدم الإسعافات بدقة ومهارة عالية.
- **مميزاً:** يحدد الإصابة الأكثر خطورة والأولى بالإسعاف.
- **موضحاً:** يوضح للموجودين حقيقة وضع المصاب.
- **مثابراً:** يستمر في عمله دون ملل وإن لم يثمر في البداية.
- **مواثقاً:** يرفع من معنويات المصاب ويطمئنه حيث يشعره بأنه في أيدي أمينة.

أولويات الإسعاف الأولي:

- تقييم الوضع العام للمحيط والمصاب بسرعة وهذوء.
- حماية المصاب من أي إصابات أخرى.
- إتخاذ كافة التدابير الوقائية لحماية المسعف والمصاب.
- منع حدوث أي إنتقال للعدوى بين المصاب والمسعف وبين المصابين أنفسهم.

الإسعاف الحربي:

هو أحد المهام الجهادية التي تُقدم للجرحى في ساحات الجهاد لإنقاذهم، وتفادي المضاعفات التي قد يصابون بها.

الإنعاش:

هو علم يبحث في كيفية السيطرة والمحافظة على الحالات الطارئة التي تحتاج الى معالجة سريعة حسب الأولوية والخطورة وإعادة المصاب الى الحياة بعد ان كان على حافة الموت.

الإنعاشي الهيداني:

هو الشخص المجاهد الذي يستطيع بعد الله على التعامل مع الحالات الطارئة ومعالجتها تحت ظروف معينة وبسرعة زمنية محددة ومن ثم نقلها الى أقرب مركز رئيسي في الوقت المناسب.

المسعف:

هو المجاهد الذي توكل إليه مهام العمل الإسعافي في الموقع، فيقوم بإدارة العملية الإسعافية بشكل كامل وذلك باتخاذ الإجراء المناسب للعناية والحفاظ على حياة المجاهدين والتقليل من أي مضاعفات قد يتعرضوا لها، وإدارة الأدوات والمستلزمات الطبية وكذلك الأفراد والمكان، ولذلك يجب على المسعف أن تكون لديه المعرفة والمهارات المطلوبة بالإضافة إلى الخبرة والإلمام بالمعلومات الأساسية للتعامل مع الحالات الإسعافية بشكل مناسب.

تجنب مخاطبة المصاب بألفاظ علمية قد لا يفهمها.

التوضيح للمصاب بكل ما سيتم اتخاذه من إجراءات علاجية قبل البدء بالتنفيذ.

عند مخاطبتك للمصاب لا تتكلم بسرعة ولا تقاطع المصاب عند حديثه لك.

جمع وتوثيق المعلومات الخاصة بالمصاب وكذلك فصيلة الدم ومكان وطبيعة ووقت الإصابة.

توثيق جميع الإجراءات الإسعافية التي تم تقديمها للمصاب ومدى إستجابة المصاب لتلك الإجراءات.

جمع وتوثيق جميع البيانات الشخصية للمصاب ومكان وطبيعة الإصابة من الشخص الذي نقل المصاب وكذلك ما تم عمله للمصاب قبل الوصول الى المركز.

كتابة تقرير مفصل عند نقل المصاب يتضمن البيانات الشخصية للمصاب وحالته عند الوصول وما تم اتخاذه من تدابير علاجية (العلامات الحيوية - الأدوية - السوائل) وحالته عند النقل بما في ذلك الإجراءات العلاجية أثناء النقل.

توثيق جميع الإصابات الواردة الى المركز في سجل خاص والاحتفاظ به.

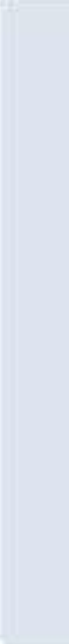
- العمل على عدم تلويث المحيط والبيئة المجاورة.
- توفير بيئة ملائمة لتقديم أفضل الممارسات العلاجية الإسعافية والإنعاشية.

العوامل الأساسية لكي يكون العمل الإسعافي فعال:

- طلب العون الإلهي وتقوى الله سبحانه.
- الإعداد الجيد للمسعف علمياً وعملياً ولوجستياً.
- التحلي بالهدوء في كل الأوقات والظروف.
- التحدث مع المصاب بهدوء وثقة.
- مشاركته المصاب الأمل ومخاوفه.
- التوضيح للمصاب عن طبيعة إصابته والإجراءات التي سيتم إتخاذها لمعالجته.
- البدء بمعالجة الحالات الأكثر خطورة والمهددة للحياة.
- طلب المساعدة عند الحاجة.
- الإعداد للنقل في أقرب وقت ممكن.

كيفية التعامل مع المصاب وأخذ وتوثيق المعلومات:

- إعادة تقييم المصاب بشكل مستمر.
- الإستماع جيداً للمصاب والأخذ بعين الاعتبار لشكواه الأساسية.



واستعداد أكبر، ويتوقع هنا حدوث إصابات خطيرة جداً ووفيات.

أساليب الإسعاف:

Manners of Aid

هناك أسلوبان متبعان في حالات الطوارئ: أسلوب إسعاف الإصابات الفردية، وأسلوب الإسعاف الجماعي للإصابات الجماعية أو الحوادث الكبيرة، والتفريق بين الأسلوبين مهم جداً للاختلاف الجوهرى في التعامل مع كل منهما، ومع الأسف فإن الخلط بينهما لا زال ملاحظاً.

١. أسلوب الإسعاف الفردي:

يستخدم هذا الأسلوب عندما يكون عدد المسعفين والإنعاشيين وإمكاناتهم أكبر من أو يساوي عدد المصابين، ولذلك فإن المسعف يقضى مع المصاب أطول وقت ممكن لمنحه أقصى قدر من الرعاية، ويعتمد الإسعاف هنا على إجراءات محددة يمكن تلخيصها على النحو التالي:

١. المسح الأولي: الغرض منه اكتشاف الإصابات الخطيرة أو القاتلة والتي تتطلب إجراءات سريعة لإنقاذ المصاب وعدم تعريض حياته للخطر.
٢. إجراءات الإنعاش القلبي الرئوي: إن لزم الأمر.
٣. المسح الثانوي: لاكتشاف بقية الإصابات والعمل على عدم تفاقمها، تثبيت حالة المصاب حتى يتم إيصاله إلى مركز أعلى.

الانطباع العام :

(General Impact):

الانطباع العام عن الحادث مهم لأنه يشير من البداية إلى خطورة الحادث وطبيعته، حيث أنه يتولد في ذهن من أول نظرة على مكان الحادث وعلى وضعية المصاب ومحيط وحيثيات الإصابة، ولا يحتاج سوى ثوانٍ معدودة من النظرة الثاقبة لمكان الحادث ومحيطه، حيث من خلالها يمكن استنتاج معلومات هامة تساعد في القيام بالعمل الإسعافي بالشكل المطلوب وبأسرع وقت ممكن، فعلى سبيل المثال:

- * **حوادث السقوط أو ارتطام الدراجة النارية:** تكون الإصابة فيها فردية، ولكنها عنيفة نسبياً، والإصابات المتوقعة قد تشمل كسر في الرقبة أو العمود الفقري، أو إصابات الدماغ، أو إصابات خطيرة في البطن والصدر، إضافة إلى كسور محتملة في الأطراف.
- * **مجاهد ملقى على الأرض ومصاب بطلق ناري (قناصة):** فالانطباع العام هنا ذو شقين، أولهما أن إصابات الطلق الناري تعتبر من الإصابات الخطيرة، وثانياً قد يكون محيط الحدث معرضاً لأعمال قنص أخرى، وبالتالي يلزم أخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة.
- * **حوادث التفجيرات وقصف الطيران:** عادة يكون الحادث كبير، والإصابات جماعية، فيطلب تجهيزات أكبر

النزيف الشديد ومنع حدوث انسداد مجرى الهواء للمصابين الذين هم في حالة غيبوبة.

٢. **الفرز والتصنيف:** ويقصد به تصنيف المصابين وفق نظام محدد ومتبع، لغرض استخلاص وإنقاذ أكبر عدد ممكن من المصابين، حيث يعتمد نظام التصنيف على تقسيم المصابين إلى مجموعات ذات ألوان محددة، والذي سيتم التطرق له بالتفصيل في درس تصنيف المصابين.

٣. **المسح الأولي والإنعاش القلبي الرئوي والمسح الثانوي:** ولا يتم عمل هذه الإجراءات إلا بعد إتمام عملية الفرز.

٢. أسلوب الإسعاف الجماعي (تصنيف المصابين):

هذا الأسلوب يتم اتباعه في حالات الحوادث الكبيرة والإصابات الجماعية والتي يكون فيها عدد المصابين يفوق ويتجاوز بشكل كبير عدد الكادر الإسعافي المتواجد وكذلك امكانياتهم، وبالتالي يهدف هذا الأسلوب إلى إنقاذ أكبر عدد ممكن من المصابين، أي تقديم أفضل الممكن لأكثر الأفراد، مما يجعل من الضرورة ابتكار مبدأ وعلم لتصنيف المصابين وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

وتتلخص الإجراءات المتبعة في هذا الأسلوب وفقاً للتسلسل التالي:

١. عمل جولة سريعة لغرض إيقاف

أسلوب الإسعاف الجماعي	أسلوب الإسعاف الفردي
الإصابات جماعية وعدد الإصابات أكثر من عدد الكادر والإمكانيات	الإصابات فردية ومحدودة وعدد الإصابات يزيد أو يساوي عدد الكادر والإمكانيات
يتجاوز الإمكانيات والموارد الإسعافية المتاحة	يمكن احتواءه بالموارد المتاحة
الغرض منه إنقاذ أكبر عدد منهم	الغرض منه إنقاذ كل المصابين
تبدأ إجراءاته بالفرز	تبدأ إجراءاته بالمسح الأولي

VITAL SIGNS

العلامات الحيوية

2

العلامات الحيوية Vital Signs

بالأكسجين وطررد ثاني أكسيد الكربون منه.

إن جميع خلايا الجسم لا تستطيع ان تستغني عن الأكسجين، ولكن قد تختلف الفترة الزمنية فيما بينها، فخلايا القلب مثلاً لا تستطيع الإستغناء عن الأكسجين نهائياً، بينما خلايا الدماغ بإمكانها البقاء من دون أكسجين لمدة ٥ دقائق، وهذه المدة هي المدة المطلوبة للإنعاش القلبي الرئوي.

المعدل الطبيعي للتنفس:

(Respiratory Rate - RR):

يتراوح ما بين ١٢ إلى ٢٠ نفس في الدقيقة.

العوامل التي ترفع معدل التنفس:

١. المجهود البدني.
٢. إرتفاع درجة الحرارة.
٣. الإختناق.
٤. الرضوض وكدمات الصدر في المراحل المتقدمة.
٥. وجود ألم.
٦. الأمراض القلبية وأمراض الجهاز الدوري.

العوامل التي تقلل من معدل التنفس:

١. الغيبوبة.
٢. التسمم.
٣. زيادة جرعة بعض الأدوية.
٤. الرضوض وكدمات الصدر في المراحل المتأخرة.

تعريف العلامات الحيوية :

(Definition):

هي العلامات التي تستطيع من خلالها معرفة بأن الجسم أو وظائفه في وضعها الطبيعي أم لا.

تشمل العلامات الحيوية ما يلي:

١. التنفس (Respiratory Rate -RR).
٢. النبض (Pulse Rate -PR).
٣. ضغط الدم (Blood Pressure -BP).
٤. الحرارة (Temperature -T).
٥. درجة الوعي (Glasgow Coma Scale -GCS).

أهمية العلامات الحيوية:

١. مؤشرات ومقاييس لوظائف أعضاء الجسم الحيوية كالقلب والرئتين.
٢. تساعدنا في تقييم الوضع العام للمصاب، كما أنها تفيد في متابعة حالته وتساعد على التشخيص.
٣. مؤشرات هامة لمعرفة مدى إستجابة الجسم للإجراءات الإسعافية والعلاجية.
٤. معرفة التغيرات المرضية.

(١) التنفس:

(Respiratory Rate -RR):

التعريف(Defination):

هو عبارة عن عملية إمداد الجسم



(٢) النبض: (The pulse) (P):

التعريف (Defination):

هو عدد دقات القلب المحسوسة في الشرايين في الدقيقة الواحدة.

كيف ينشأ النبض:

ينشأ النبض نتيجة إندفاع الدم داخل الشرايين أثناء إنقباض عضلة القلب.

المعدل الطبيعي للنبض:

المعدل الطبيعي للنبض يتراوح ما بين ٦٠ إلى ١٠٠ نبضة في الدقيقة.

العوامل التي تزيد من نبضات القلب:

١. التمارين والإجهاد البدني.
٢. بعض الأمراض (الحميات) كالمالاريا وحمى الضنك.
٣. فقدان السوائل.
٤. النزيف في مراحله الأولى.
٥. ارتفاع درجة الحرارة.
٦. الإنفعالات النفسية.
٧. نقص الأكسجين.

أنواع التنفس:

التنفس السطحي:

هو الذي يكون فيه التنفس سريع بحيث لا يتحرك جدار القفص الصدري بالشكل المطلوب مثل حالات الربو والإختناق.

التنفس العميق:

وهو تنفس بطيء ويمتاز بزيادة الفترة الزمنية للشهيق والزفير، ويلاحظ حركة القفص الصدري بوضوح، وتظهر في حالات كالنزيف الدماغي، والمتعرضين لغيوبة بسبب نقص السكر في الدم.

كيفية قياسه:

١. النفس الواحد عبارة عن عمليتي الشهيق والزفير معاً.
٢. إحسب التنفس دون معرفة المريض أنك تراقب تنفسه.
٣. انظر إرتفاع وإنخفاض الصدر أو أعلى البطن خلال دقيقة واحدة.
٤. ولمعرفة التنفس في الحالات الطارئة يؤخذ العدد خلال ١٥ ثانية ويضرب في عدد أربعة لتوفير أكبر وقت ممكن.

عند قياس التنفس يجب مراعاة ما يلي:

- (١) سرعة التنفس.
- (٢) العمق.
- (٣) الإنتظام.



2



2



٤. الشريان الفخذي (Femoral Artery):

يمكن الإحساس بنبض الشريان في الناحية الداخلية، أعلى الفخذ.



٥. الشريان المابضي:

(Popliteal Artery):

يمكن جسده خلف الركبة، ما بين أوتار العضلات باتجاه خارج الجسم وأعلى عظمة الشظية من الخلف.



العوامل التي تقلل من نبضات القلب:

١. النزيف في مراحله المتأخرة.
٢. الصدمة.
٣. أمراض القلب.

أماكن قياس النبض:

١. الشريان السباتي:

(Carotid Artery):

وهو الأكثر استعمالاً نظراً لسهولة الشعور به تحت زاوية الفك في الإنخفاض الواقع بين الحنجرة والعضلات المجاورة لها.



٢. الشريان الكعبري:

(Radial Artery):

عند معصم اليد جهة الإبهام.



٣. الشريان العضدي (Brachial Artery):

يتم الشعور به في منتصف العضد ما بين العضلات وعظمة العضد في الناحية المجاورة للجسم.

عدد أربعة لتوفير أكبر وقت ممكن.

ما ينبغي فحصه وتسجيله بالنسبة للنض:

- (١) عدد النبض (كم نبضه في الدقيقة).
- (٢) قوة النبض (قوي أو ضعيف).
- (٣) الانتظام (نبض منتظم أو غير منتظم).

(٣) ضغط الدم الشرياني:

(Blood Pressure - BP)

التعريف:

(Defination):

هو عبارة عن الضغط الناتج عن إندفاع الدم على جدران الأوعية الدموية التي يمر فيها الدم. هو أكبر قوة مقاومة في الشرايين للدم المتدفق من القلب في حالة الانقباض (الضغط الانقباضي) وأقل قوة مقاومة موجودة في الشرايين في حالة الانبساط (الضغط الانبساطي).

المعدل الطبيعي لضغط الدم:

المعدل الطبيعي لضغط الدم ٨٠ / ١٢٠ / ١٠ ملليمتر زئبقي. وتنطق (مئة وعشرون على ثمانين).

العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم:

١. الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
٢. الإفراط في تناول الملح بكثرة خاصة عند كبار السن.
٣. التعرض لبعض المواد السامة.
٤. الإنفعالات والغضب.

٦. الشريان القسبي (الضنوبي) الخلفي:

(Post. Tibialis Artery):

يمكن جس نبضه مباشرة تحت زائدة الكاحل الداخلية.



٧. الشريان الظهراني للقدم:

(DorsiPedis Artery):

يمكن حسه بين الوترين المتصلين بالإصبعين الأولى والثانية في أعلى منطقة مرتفعة من ظهر القدم.



كيفية قياس النبض:

١. توضع رأس أصبعي السبابة والوسطى على مكان النبض فوق الشريان مباشرة ويبدأ العد لمدة دقيقة كاملة.
٢. لا تستخدم إصبع الإبهام في قياس النبض لأن له نبضه الخاص به.
٣. لمعرفة النبض في الحالات الطارئة يؤخذ العدد خلال ١٥ ثانية ويضرب في



2

٤. أغلق ساعة المنفاخ.

٥. قم بالنفخ إلى أعلى حتى يختفي الإحساس بنبض

الشريان ونحفظ الرقم الذي إختفى عنده النبض.

٦. ضع السماعة على الشريان العضدي تحت القماش.



٧. عاود النفخ مره أخرى حتى تصل إلى أعلى من

الرقم الذي سجلناه عند إختفاء النبض بـ ٣٠ درجة.

٨. فرغ الهواء تدريجياً إلى أن تسمع أول نبضة ويسمى الضغط الإنقباضي.

نستمر في إفراغ الهواء تدريجياً إلى أن يختفي سماع النبض ويكون الرقم هو الضغط الانبساطي.

أماكن قياس الضغط:

(Sites of the Blood Pressure Assessment):

١. الذراع: فوق الشريان العضدي.

٢. المعصم: فوق الشريان الكعبري.

موانع أخذ الضغط في الأماكن أعلاه:

١. وجود إصابة أو حرق كبير في أحد الأماكن أعلاه.

٢. مريض أجريت له عملية تحت الإبط.

٣. مريض لديه وصلة من أجل غسيل الكلى في ذلك الطرف.

العوامل التي تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم:

١. النزيف.

٢. نقص السوائل والأملاح: كالإسهال

والطرش.

٣. الحروق.

٤. الإصابة بأمراض الحميات في مراحلها المتأخرة.

الجهاز المستخدم لقياس ضغط الدم:

الجهاز المستخدم لقياس ضغط الدم يسمى جهاز الضغط الزئبقي (sphygmomanometer) والسماعة تسمى (stethoscope)

كيفية قياس ضغط الدم:

١. وضع المريض في وضعية الاستلقاء.

٢. لف القماش على ذراع المريض فوق المرفق.



٣. ضع الإصبع السبابة والوسطى فوق الشريان العضدي.



يُصاحبها ارتفاع في النبض بمقدار ١٣ نبضة.

جهاز قياس درجة الحرارة:

يسمى جهاز قياس درجة الحرارة: الترمومتر (Thermometer).

أنواع أجهزة قياس درجة الحرارة:

١. الترمومتر الزئبقي.



٢. الترمومتر الرقمي.



العوامل التي ترفع درجة الحرارة:

١. الجهد البدني.
٢. الإصابة بأمراض الحميات مثل الملاريا وحمى الضنك.
٣. الإلتهابات.

العوامل التي تخفض درجة الحرارة:

١. النزيف.
٢. الطقس البارد.

أنواع أجهزة قياس ضغط الدم:

- زئبقي.
- الساعة - هوائي.
- إلكتروني (رقمي).



(٤) درجة الحرارة:

(Temperature - T)

التعريف:

(Defination):

هي التوازن بين درجة حرارة الجسم المفقودة والمكتسبة أو هي الحرارة التي يحتفظ بها الجسم.

المعدل الطبيعي:

المعدل الطبيعي: ٣٦,٧ إلى ٣٧,٤ درجة مئوية.

ملاحظة:

عندما ترتفع درجة الحرارة درجة واحدة

الحالة الذهنية للمصاب بإصابة في الرأس وتعتبر من أحد العلامات الحيوية الهامة والتي يجب على كل مسعف القيام بها نظراً لما تعطيه من معلومات هامة يستطيع المسعف من خلالها إتخاذ الإجراء المناسب. ويقاس من خلال تسجيل أفضل استجابة للمصاب لمؤثر الصوت واللمس والألم حيث يتم إعطاء درجة لكل جزء وبعدها تجمع الدرجات وتكون الدرجة النهائية للوعي.

تقييم درجة الوعي:

تقييم درجة الوعي تعتبر من أهم الطرق والوسائل لتقييم ومتابعة المصابين في الرأس أو في الحوادث حيث ينبغي إعادة تقييم درجة الوعي كل ١٠ دقائق ومقارنة النتيجة بما قبلها.

١. درجة الوعي ما بين ١٣ - ١٥. درجة الخطورة خفيفة.
٢. درجة الوعي بين ٩ - ١٢. درجة الخطورة متوسطة.
٣. درجة الوعي أقل من ٩. درجة الخطورة شديدة.

طريقة قياس درجة الوعي:

يتم فحص درجة الوعي من خلال مراقبة وتسجيل إستجابة المصاب للآتي:

١. للتنبيه الصوتي (تكلم بصوت عال في إذنه).
٢. واللمس (حاول إيقاظه وهز كتفه).
٣. والألم (راقب وجهة أثناء قرصك لليد أو الكاحل).

يتم إعطاء درجة لكل جزء وبعدها تجمع الدرجات وتكون الدرجة النهائية للوعي.

أماكن وطريقة قياس درجة الحرارة:

١. الفم:

١. هز الميزان الزئبقي إلى أن يصل الزئبق إلى ٣٥ درجة مئوية ويمسح بالكحول.
٢. ضع الميزان بلطف تحت لسان المريض علي أحد الجانبين وأطلب من المريض قفل فمه.
٣. اترك الميزان لمدة ٣ دقائق.
٤. أخرج الميزان من فم المريض وسجل القراءة.
٥. تقرأ النتيجة في الترمومتر كما هي.

ملاحظة:

تأكد من سلامة وصحة فم المريض.

تأكد أن المريض لم يشرب سائل ساخن قد يؤثر على قراءة درجة الحرارة.

٢. الإبط:

١. هز الميزان الزئبقي إلى أن يصل الزئبق لـ ٣٥ ويمسح بالكحول.
٢. ضع الميزان بلطف تحت إبط المريض في منتصف الإبط وأطلب من المريض ضم يده على الإبط.
٣. اترك الميزان لمدة ٧ - ١٠ دقائق ثم رفعه واقرأ درجة الحرارة.
٤. يتم إضافة نصف درجة على قراءة الترمومتر.

٥) قياس درجة الوعي:

Glasgow Coma Scale - GCS

التعريف:

(Defination):

هو وسيلة بسيطة وفعالة ومؤثره لتقييم

طريقة فحص وتقييم درجة الوعي كالتالي:

A. الحركة:

(Motor response):

١. إستجابة للأوامر = ٦



٢. يركز على مصدر الألم = ٥

٣. يستجيب باتجاه الألم = ٤



٤. إنقباض نحو الداخل = ٣



٥. إنقباض نحو الخارج = ٢



٦. لا توجد استجابة = ١



التكلم (Verbal response):

١. يتكلم بوضوح = ٥

٢. يتكلم بكلمات غير مترابطة = ٤

٣. يتكلم بصورة غير مفهومة = ٣

٤. يصدر أصوات فقط = ٢

٥. لا يتكلم = ١

C. العينين (Eye opening):

١. العينين مفتوحة تلقائياً = ٤

٢. يفتح العينين عند الطلب منه = ٣

٣. يفتح العينين عند الألم = ٢

٤. لا يفتح العينين = ١

٤ مثال على ذلك:

عند تقييمك لمجاهد مصاب بطلق ناري في الرأس، وعند سؤالك للمصاب عن اسمه أجاب بأنات فقط وعند إيجادك ألم في حلمة نديه الأيسر حرك يده مباشرة إلى مصدر الألم، وكذلك مع وجود الألم فتح عينيه.

١. أحسب درجة وعي المصاب؟

٢. ما هو تقييمك لحالة المصاب بناء على درجة وعيه؟

٣. ما هو الإجراء المناسب بعد ذلك؟

الإجابة:

١. حساب درجة وعي المصاب:

• أولاً: نقيس استجابة الحركة، وبما أن المصاب حرك يده مباشرة باتجاه مصدر الألم، نعطي للحركة الدرجة



- ثانياً: نحسب استجابة المصاب للتكلم، وبما أن المصاب أصدر أنات فقط، نعطي لها درجتين.
- ثالثاً: نحسب استجابة العينين، وبما أن المصاب فتح عينيه أثناء الألم نعطي العينين درجتين. إذا مجموع درجة وعي المصاب هي:

$$9 = 2 + 2 + 5$$

٢. تقييم حالة المصاب:

بما أن درجة الخطورة ما بين ٩ - ١٢ درجة. فإن درجة الخطورة هي متوسطة.

٣. الإجراء الذي يجب إتخاذه:

١. مراقبة العلامات الحيوية كل ١٠ دقائق.
٢. إيقاف النزيف إن وجد.
٣. تعويض السوائل المفقودة.
٤. إعطاء المصاب إبرة كزاز إن وجدت.
٥. إعطاء المصاب مضاد حيوي إن وجد.
٦. الأهم من ذلك العمل على الترتيب لنقل المصاب إلى أقرب مركز.



جدول يلخص طريقة فحص وتقييم درجة الوعي:

٤	يفتح عينه تلقائياً	العين Eye opening
٣	يفتح عينه عندما تناديه	
٢	يفتح عينه إستجابة للألم	
١	ليس هناك أي إستجابة (لا يفتح عينيه)	
٥	يتكلم بشكل واضح ومفهوم	الكلام Verbal response
٤	يتكلم بجمل غير مترابطة	
٣	يتكلم بكلمات غير مفهومة	
٢	يصدر أصوات أنين فقط	
١	لا يتكلم	
٦	يستجيب للأوامر (يرفع يده أو رجله إذا طلب منه)	الحركة Motor response
٥	يستجيب لموضع الألم (يركز على مصدر الألم)	
٤	يستجيب باتجاه الألم (يصدر ردة فعل لإبعاد مصدر الألم)	
٣	إنقباض نحو الداخل (إذا أشتير بالألم يقوم بضم أطرافه لجسمه)	
٢	إنقباض نحو الخارج (إذا أشتير بالألم يقوم بإبعاد أطرافه عن جسمه)	
١	لا توجد إستجابة	



2



DEATH

الوفاة

3

الوفاة Death

قد توقف وأن الشخص قد مات أما غياب النبض والتنفس مع بقاء هذه العلامات فذلك يعني أن الشخص بحاجة لإنعاش قلبي رئوي.

علامات الموت: (تشخيص الموت):

علامات الموت الفورية:

١. انعدام الحركة.
٢. توقف القلب والدورة الدموية.
٣. توقف التنفس.

علامة الموت المبكرة:

١. العلامات العينية: (توسع بؤبؤ العين، تعتم القرنية).
٢. فقدان حرارة الجسم.
٣. انعدام مطاطية الجلد.
٤. الترسيب الدموي.
٥. التيبس الجسدي.

علامات الموت المتأخرة:

١. علامات التفسخ والتحلل.
٢. المومياء.
٣. التشمع.

تفصيل علامات الوفاة:



التعريف (Defination):

- هي توقف الدماغ حتى وإن كنا قادرين على إبقاء القلب والرئتين تعمل بالطرق الميكانيكية.



الأهمية الشرعية لتشخيص الوفاة:

١. دفن الجثة.
٢. توقيف أجهزة الإنعاش.
٣. في قضايا الوراثة (بتحديد من مات أولاً).

تشخيص توقف الدماغ :

يشخص توقف الدماغ من خلال غياب منعكسات جذع الدماغ وهي :

- توسع الحدقتين وثبوتهما : عند تسليط الضوء تنضيق الحدقتين .
- منعكس القرنية : عند لمس القرنية بقطنه ينغلق الجفان .
- المنعكس الدهليزي العيني : عند وضع ماء بارد في الأذن تتأرجح العينين.
- منعكس الكعام: عند لمس الحنك تظهر الهوكة (الكعام) على الشخص.

وعند غياب هذه العلامات فذلك يعني أن الدماغ

- يكون الانخفاض أسرع في الأجزاء المكشوفة، وقد يتم الانخفاض على مدى ساعات، وقد تحتفظ الأحشاء الداخلية بحرارتها فترة أطول.



علامات العين:

- الحالة الطبيعية للشخص السليم عند تعريض ضوء مباشر (كشاف) باتجاه العين فإنه ينكمش ويصغر وعند إزالة هذا الضوء المباشر فإنك ستلاحظ بؤبؤ العين يكبر ويتسع.
- أما في حالة الوفاة فإنك تلاحظ بؤبؤ العين ثابت ولا يتحرك.



انعدام الحركة:

- إن عدم الحركة تعتبر أولى علامات الوفاة الظاهرة.
- ترى بالعين المجردة، إلا أنها خادعة، فقد يكون هناك عدم حركة بدون وفاة، كما يحدث في بعض حالات السموم والصدمات العصبية الشديدة.

توقف القلب والتنفس:

هو توقف القلب والتنفس معاً.

التأكد من توقف القلب:

١. قم بجس النبض وخاصة في الشريان السباتي (في حالة الشخص المتوفي فلن تشعر به).
٢. قم بسماع دقات القلب في منطقة الصدر سوءاً بالسماعة أو بوضع إحدى الأذنين على صدر المصاب (في حالة الشخص المتوفي فلن تسمع بدقات القلب).
٣. اختبار الاحتقان الدموي (قم بربط أصبع المصاب وفي حالة الشخص المتوفي فلن تلاحظ أي احتقان دموي).

التأكد من توقف التنفس:

١. قم بمشاهد حركة صدر المصاب (فلن تشاهد أي ارتفاع أو انخفاض في الصدر في حالة الشخص المتوفي).
٢. قم بسماع صوت دخول وخروج الهواء في منتصف الصدر بالسماعة (في حالة الشخص المتوفي فلن تسمعه).
٣. قم بوضع مرآة صغيرة على الأنف والفم (في حالة الشخص مازال يتنفس فإنك تشاهد بخار الماء على المرآة بينما الشخص المتوفي فلن تشاهد ذلك).

فقدان الحرارة:

- تبدأ درجة حرارة الجسم بالانخفاض تدريجياً حتى تصل إلى درجة حرارة الجو المحيط بالجثة.

أهمية علامات الترسيب الدموي:

١. علامة أكيدة على الوفاة.
٢. تحدد وضعية الجثة عند الوفاة.
٣. قد تساعد في تحديد سبب الوفاة وتكون قرمزية في حالات الوفاة من غاز أول أكسيد الكربون والبرد الشديد تكون زرقاء في حالات الاختناق، تكون حمراء في حالات النزيف والصدمة.

التيبس الجثي:

هو تصلب للعضلات يحدث بعد الوفاة نتيجة للتغيرات الكيميائية بالعضلات. يبدأ التيبس بعضلات الوجه والفك والأطراف العليا، ثم الجذع والأطراف السفلى، ويكتمل في حوالي ٦ ساعات، ويبدأ في الاختفاء بعد حوالي ١٢ ساعة أو أكثر وبالتدرج وبانتظام من الوجه والفك والأطراف العليا وينتهي بالأطراف السفلى.



الترسيب الدموي:

وهي حالة ترسيب الدم بالأوعية الدموية بفعل قوة الجاذبية لتصل إلى الأجزاء المنخفضة من الجثة، فتظهر بلون أزرق مائل إلى البنفسجي، عكس الأجزاء العليا التي تظهر بلون باهت.

- إن موضع الزرقعة يحدد وضع الجثة عند الوفاة.
- تبدأ الزرقعة بعد حوالي ساعة من الوفاة وتكتمل بعد ١٢ ساعة.



ملاحظة:

مايزال الكثير من الصحيون يشخص الموت من خلال غياب النبض في الشريان السباتي أو عدم سماع ضربات القلب وهذا لا يعني أنه قد مات إذ لا بد من غياب منعكسات جذع الدماغ التي تدل على توقف الدماغ أما إذا توقف القلب وما زالت منعكسات جذع الدماغ موجودة فذلك يعني أنه بحاجة للأنعاش الأساسي فيعود القلب للعمل.

BASIC LIFE SUPPORT

الإنعاش الأساسي

4

الإنعاش الأساسي

Basic Life Support (BLS)

التعريف:

(Definition):

هو مجموعة من الإجراءات والتدابير الطارئة التي تهدف إلى إنقاذ حياة المصاب وعودته إلى حياته الطبيعية.

آلية إجراء الإنعاش الأساسي:

بعد التأكد من أن المصاب لا يستجيب قم بعمل الآتي:

✍ اطلب المساعدة من فريق الإنعاش المتقدم.

✍ ثم ابدأ بإجراء A و B و C بالترتيب.

افتح المجاري الهوائية (A)

(A) (Air way):

تبدأ المجاري الهوائية من بداية الفم والأنف وحتى القصيبات الهوائية، افتح المجاري الهوائية وذلك بعمل التالي:

١. حرر وأزل أي ملابس قد تعيق مجرى الهواء.

٢. اخرج الأجسام الغريبة من الفم (مثل القات) أن وجد: أدخل إصبعك من طرف الفم، بحيث تلف إصبعك حول الفم من الداخل ثم إسحب إصبعك وأخرج الجسم الغريب.



ندخل الإصبع من طرف الفم وليس من وسطه حتى نتجنب دفع الجسم الغريب إلى الداخل أكثر.

٣. ضع إحدى يديك على جبهة المصاب، وإصبعين من اليد الأخرى تحت الذقن وذلك لإمالة الرأس إلى الخلف ورفع الذقن بغرض توسيع مجرى الهواء عند الحلق.



٤ إذا كان المصاب لا يتنفس ← قم بإعطاء المصاب نفس إنقاذي وذلك كالتالي:

١. إرفع الفك السفلي إلى الأعلى وأمل رأس إلى الأسفل ثم سد الأنف وضع راحة يدك على جبين المصاب.
٢. أمسك الفك الأسفل باليد الأخرى ثم طبق فمك على فم المصاب.
٣. إعطي المصاب نفساً مدته ثانية واسمح للهواء بالخروج من فمه ثم طبق فمك على فمه مرة أخرى وأعطه نفساً مدته ثانية وفي كل نفس يجب أن تشاهد الصدر يرتفع حتى تتأكد من فعالية التنفس، وكل نفس يسمى تنفس إنقاذي.



٤. إذا عاد التنفس إلى المصاب فضعه في الوضعية الجانبية (الوضعية الآمنة).

التنفس الإنقاذي :

هو إعطاء المصاب نفسين مؤثرين عن طريق الفم بالفم أو من خلال قناع الوجه حتى تشاهد ارتفاع الصدر ثم اترك الهواء يخرج بالكامل وكل نفس خلال ثانية واحدة.



فحص التنفس (B) (Breathing):

إفحص طريقة التنفس ويتم ذلك خلال ١٠ ثواني قم بعمل التالي:

١. شاهد: حركة الصدر والبطن
٢. إسمع: صوت دخول وخروج الهواء.
٣. حس: خروج الهواء من الفم أو الأنف.



٤ إذا كان المصاب غير واع ولكن يتنفس ← ضعه في الوضعية الآمنة.





4



الدورة الدموية (C) Circulation

إفحص النبض خلال مدة لا تزيد عن ١٠ ثواني في الشريان السباتي وفي حال كانت هناك إصابة في منطقة العنق، يمكنك فحص الشريان الفخذي، ومنه:



لا؛ لا يوجد نبض :

- إبدأ بالضغط على الصدر لمدة ١٠ ثواني وبعدها قم بفحص النبض مرة أخرى وعندها.
- إذا عاد النبض فقط عليك مواصلة إعطاء التنفس الإنعاشي مرة كل ٥ إلى ٦ ثواني.
- إذا لم يعد النبض بعد العشر الثواني من الضغط على الصدر ابدأ بتنفيذ عملية الإنعاش القلبي - الرئوي (CPR).

لا نعم؛ يوجد نبض: ولكن المصاب لا يتنفس :

- إعطاء المصاب تنفس إنعاشي واحد كل ٥ إلى ٦ ثواني بصورة مستمرة وبدون



النبض مرة أخرى وعليه..
 ✎ فإن عاد النبض توقف عن تنفيذ (CPR) عليك مواصلة التنفس الإنعاشي مرة كل ٥ إلى ٦ ثواني إلى أن يستطيع المصاب التنفس تلقائياً بدون مساعدة.
 ✎ عند الأطفال والرضع: في حالة وجود نبض ولكنه أقل من ٦٠ نبضه في الدقيقة أو توجد علامات نقص التروية الدموية ابدأ مباشرة بتنفيذ عملية الإنعاش القلبي الرئوي (CPR).

ملاحظات هامة :

- على المسعفين تبديل أماكنهم لتجنب التعب والإنهاك كل ٥ دورات أو كل دقيقتين، وفي حالة تعرض المسعف الذي يقوم بالضغط على الصدر للتعيب والإنهاك يجب تبديل الأماكن فوراً وإن لم تنتهي المدة المحددة لذلك.
- المدة الزمنية لتبديل الأماكن لا بد أن تكون أقل من ٥ ثواني.

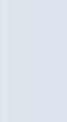
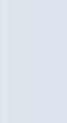
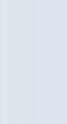
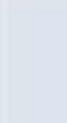
الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)

:(Cardiopulmonary resuscitation)

✎ إن عملية الإنعاش القلبي - الرئوي (CPR) تتكون من ٥ دورات متتالية وكل دورة تتكون من ٣٠ مرة ضغط على الصدر مع ٢ تنفس ومجموع المدة الزمنية لعملية الإنعاش القلبي - الرئوي (CPR) دقيقتان.



✎ بعد الإنتهاء من تنفيذ عملية الإنعاش القلبي - الرئوي (CPR) قم بفحص



خلاصة الإسعاف الأساسي BLS - A, B, C

العمالية	البالغين أكبر من ٨ سنوات	الأطفال من ١ - ٨ سنوات	الرضع أقل من سنة
A: المجاري الهوائية	إمالة الرأس - رفع اللسان مع وجود إصابة: رفع الفك السفلي للأمام		
B: التنفس في البداية: تنفس إنقاذ	عدد ٢ تنفس بمعدل تنفس واحد كل ثانيتين بحيث يجعل الصدر يرتفع		
تنفس إنعاشي بدون الضغط على الصدر	تنفس واحد كل ٥ إلى ٦ ثواني	تنفس واحد كل ٣ إلى ٥ ثواني	
تنفس إنعاشي مع وجود عملية (CPR) أو النبوية الرغاسي	تنفس واحد كل ٦ إلى ٨ ثواني		
C: الدورة الدموية مكان فحص النبض خلال أقل من ١٠ ثواني	الشريان السباتي	الشريان الفخذي أو شريان الساعد	
مكان الضغط على الصدر	النصف التحتاني من عظمة القص ما بين حلمتي الثدي	تقريباً تحت الخط الواصل بين حلمتي الثدي	
طريقة الضغط: ضغط بقوة، بسرعة وترك الصدر يعود إلى مكانه	كعب اليد لأحد اليدين والأخرى فوقها		
مقدار الضغط	من ٢.٥ سم إلى ٣ سم	من نصف إلى ثلث عمق الصدر	
سرعة الضغط	تقريباً ١٠٠ ضغطة في الدقيقة		
نسبة الضغط إلى التنفس	٣٠ ضغطة إلى ٢ تنفس سواء مسعف واحد أو اثنين	مسعف واحد: ٣٠ إلى ٢ مسعفين: ١٥ إلى ٢	

الإسعاف الحرجي

مخطط الإنعاش الأساسي (BLS)



4

٤. قم بقلب المصاب نحوك، وأسندته على فخذيك وهو مستلق على جانبه.
٥. أثنى ذراعه العليا بشكل زاوية قائمة، لكي تسند الجزء العلوي من جسمه.
٦. إثنى ركبته العليا من جسمه بشكل زاوية قائمة، فتتقدم الفخذ، وتسند الجزء السفلي من الجسم.



٧. تحقق من أن الوضع النهائي ثابت وأن المصاب لا يمكن أن ينقلب وأن يبقى رأسه مائلاً إلى الخلف وفكه متجهاً إلى الأمام.



الغرض من هذه الوضعية:

١. تبقي مسلك الهواء مفتوحاً، فلا يتراجع اللسان إلى الوراء فيسد البلعوم.
٢. تبقي الرأس والعنق مسطحين فيتسع ممر الهواء.
٣. تتيح هذه الوضعية الفرصة للسوائل والطرش أن يخرج من فم المصاب بسهولة للخارج.

الوضع الآمن

(Position of Security):

هي الوضعية التي تبقي المجاري الهوائية مفتوحة، بحيث تكون مناسبة ومريحة للمصاب ونوع الإصابة.

الوضعية:

أولاً: وضعية الإفاقة [وضعية فاقد الوعي]:

(Recovery Position):

هذه الوضعية تخص فاقد الوعي الذين يتنفسون ولديهم نبض (في حال عدم الشك بإصابة الحبل الشوكي).

تطبق هذه الوضعية على النحو التالي:

١. إركع إلى جانب المصاب مواجهاً صدره، ثم أدر رأسه ناحيتك مع إمالة للخلف والإبقاء على الفك مرفوعاً بحيث يكون مسلك الهواء مفتوح.
٢. ضع ذراعه القريبة منك إلى جانب رأسه، ارفع رأسه وضع يده تحتها وأصابعه منبسطة.



٣. إمسك بساقه البعيدة من أسفل القدم واسحبها نحوك بحيث تتقاطع مع الساق الأخرى، واسحب ذراعه الأخرى وضعها فوق صدره.

طرش المصاب فقم بالخطوات التالية:
١. قم بفتح مجرى الهواء وإزالة أي عائق كاللسان أو القات بدون تحريك الرقبة وذلك بوضع يديك على جانبي الوجه، وبلطف قم بفتح الفك السفلي بأطراف أصابعك إلى الأسفل.
٢. في حالة كان ولا بد من قلب المصاب على بطنه لسبب الخوف عليه من الاختناق بطرشه أو الدم قم بطلب مساعدة ممن حولك وأتبع الخطوات التالية:

أ- يقوم الشخص الأول بإمساك المصاب بالرأس والرقبة والشخص الثاني يركع بجانب المصاب ومواجهاً الصدر والبطن، والشخص الثالث مواجهاً منطقة الحوض والأطراف.
ب- يتم قلب المصاب بحيث يكون رأسه ورقبته وظهره والحوض والأطراف على استقامة واحدة وكوحدة واحدة، بحيث لا يتمايل جسم المصاب.

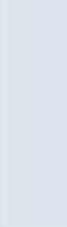
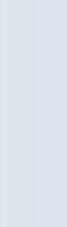
ثانياً: وضعية الأمان الجانبي:

Lateral Position of Security :

هذه الوضعية تكون مناسبة للذين لديهم إصابات في منطقة الصدر وخاصة مع وجود كسر موج في الأضلاع، بحيث يكون مائلاً باتجاه الجهة المصابة لإراحة الجهة السليمة.

ثالثاً: وضعية الأمان للإصابات العمود الفقري:

لا يجب تحريك المصاب بالعمود الفقري أبداً فقد تعرضه للشلل الدائم.
في حال كان ولا بد من تحريكه لسبب أو لآخر، كانسداد مجرى الهواء أو لسبب



CLASSIFICATION
OF INJURED - TRIAGE

تصنيف المصابين

5

تصنيف المصابين

Classification of injured (Triage)

تعريف الفرز:

(Definition of Triage):

هي إجراءات يقوم بها المسعف في حال وجود عدد من الجرحى، حيث يقوم بفرزهم وتصنيفهم إلى مجموعات حسب خطورة الإصابة والأولية في الإسعاف.

الهدف من الفرز :

(objectives of Triage):

هو إسعاف أكبر عدد من المصابين (العمل الأفضل للعدد الأكبر في الزمن الأقصر).

ملاحظات هامة :

- يتولى عملية التصنيف المسؤول الإسعافي، وفي حال وجود أكثر من مسعف فيقوم به أعلاهم رتبة.
- يجب إنهاء عملية التصنيف قبل البدء بإسعاف المصابين.
- قد لا تحتاج سوى ١٥ ثانية لتقييم كل مصاب، حسب المهارة التي لديك.

الإصابات الجماعية:

:(Collectivism injuries)

قد يبدو المشهد مربكاً مع وجود عدد كبير من المصابين ينزفون ويتألمون، فمن الممكن عدم رؤية مصاب صامت يعاني من مشاكل في التنفس، أو مصاب انسدت الطرق التنفسية لديه جزيئاً.

❖ غالباً لا ينتبه المسعفون إلى وجود مصاب يعاني من انسداد جزئي للطرق التنفسية جرّاء إصابة في الرأس، أو مصاب يعاني من نزيف حاد وضغط دم منخفض.

❖ - في حالة الإرباك هذه، يجب أن تبقى هادئاً وتفكر بوضوح، فمن السهل عدم الانتباه إلى جرح خطير في حال لم تتبع خطة واضحة معينة لإسعاف المصابين.

تصنيف المصابين:

Determine Triage Category Types :

يصنف المصابين إلى أربع فئات:

١. الفئة الأولى: حالة طارئة
قصوى وفوري (أحمر) [مشكلات
تهدد الحياة]:

❖ تشمل هذه الفئة المصابين بإصابات خطيرة تهدد حياتهم، مثل:

- حروق في المجرى الهوائي العلوي (حروق التنفس).
- جروح الصدر النازفة والمفتوحة والبليلة.
- جروح البطن النازفة والمفتوحة والبليلة.
- النزيف غير المسيطر عليه.
- الإصابات الوجهية الفكية الحادة مع إمكانية مضاعفات في المجرى الهوائي.



5

٤. الفئة الرابعة: حالة متوقع إستشهادها (أسود):

وهي الحالة التي يكون الأمل ضعيف لشفاء المصاب، وتشمل هذه الفئة المصابين الأحياء ولكن الأمل في إنقاذه ضعيف، بغض النظر عن أي إجراء إسعافي يقدم لهم في الموقع، مثل:

- حروق رئيسية شاملة.
- جروح بليغة مع تعرض للإشعاعات.
- توقف التنفس لكن الدماغ حي لأن أغلبهم لا يستفيدون من الانعاش.

خطوات عملية التصنيف:

(Steps of Triage):

- عندما تصل إلى مكان الحادث، أوضح فوراً للجميع أنك المسؤول الإسعافي، ليقدموا لك المعلومات ويطرحوا عليك الأسئلة.
- إبحث عن مساعدين: قد تحتاج إلى مساعدة، أطلب من أحد المجاهدين مساعدتك، أو اصرخ «يا أنصار الله» أو أي رمز متعارف عليه (كلمة سر)، وقم بتحديد الخطوات التي سيقومون بها، وإعطاء التوجيهات لهم.
- إعمل ضمن ثلاث جولات: لا تهمل أي جرح، وانتقل برفقة مساعديك من مصاب إلى آخر دون أن تستغرق أكثر من دقيقة في كل جولة لمعاينة المصابين.

٢. الفئة الثانية: حالة طارئة مستعجل (أصفر) [مشكلات لا تهدد الحياة]:

تشمل هذه الفئة المصابين بإصابات لا تعرض حياتهم للخطر المباشر، ولكنهم بحاجة إلى الإسعاف الميداني قبل نقلهم إلى أقرب مركز إسعاف، حيث وأن معظم المصابين من هذه الفئة، مثل:

- كسور رئيسية في الفخذ أو الحوض بدون علامات الصدمة.
- إصابات العمود الفقري.
- الجروح المتوسطة.
- جروح الصدر بدون مشاكل في المجرى الهوائي أو التنفس أو الجهاز الدوري.
- جروح البطن المفتوحة بدون نزيف.

٣. الفئة الثالثة: حالة طارئة متأخر (أخضر) [الإصابات البسيطة]:

تشمل هذه الفئة المصابين بإصابات بسيطة غير خطيرة، حيث يلزم تأخير إسعاف هذه الفئة إلى حين الانتهاء من إسعاف الفئات الأخرى (الحمراء والصفراء) الأكثر خطراً ونقلهم إلى أقرب مركز إسعاف، مثل:

- الكسور والحروق والجروح البسيطة.

الإسعاف الحربي

جميع الجروح وإعطاء السوائل ومسكن الألم وتثبيت الكسور لجميع المصابين، قم بالجولة الثالثة.

في حال وجدت مصاب من الفئة الرابعة (السوداء)، فلا تضيع الوقت في عملية إسعافه، اتركه جانباً مؤقتاً، حتى الإنتهاء من إسعاف حالات الفئة الأولى (الحمراء) والثانية (الصفراء).

✂ الجولة الثالثة (The third round)

قبل عملية النقل:

(before the transfer)

- قم بإعطاء أولية النقل من خلال تقييمك للمصابين في الجولات السابقة.
- تأكد من أن المجاري التنفسية مفتوحة.
- تأكد من أن جميع الجروح قد ضمدت بشكل سليم.
- تأكد من وضعية المصاب.
- قم بملء الاستمارة الخاصة بالمصابين.
- تأكد من الإجراءات التي قمت بها سابقاً، وأنت لم تغفل عن أي شيء يمكن القيام به.
- قم بإعطاء أوامر النقل لفريق النقل وأرسل المصاب رقم واحد إلى المركز الإسعافي.
- كرر خطوات الجولة الثالثة مع المصاب رقم اثنين.. وهكذا.

تذكر أن التصنيف ليست عملية وحيدة، ولكن يجب تكرارها كلما سحت الفرصة، لأنه قد تدهور حاله ما كانت في الفئة الخضراء، والآن لا بد من نقلها إلى الفئة الحمراء.

✂ الجولة الأولى (The first round):

فتح الطرق التنفسية وإيقاف النزيف الحاد:

- تكلم إلى المصابين، وفي حال أن المصاب يتكلم أو يصرخ فأعلم أن المجاري التنفسية مفتوحة.
- في حال أن المصاب لم يتكلم أو يصرخ (قد يكون الهادئ هو الأخطر)، فقم بإتخاذ الإجراءات اللازمة.
- وأنت تقوم بتأمين مجرى الهواء، تأمل المصاب بشكل سريع، وتأكد من عدم وجود أي نزيف حاد: كبت لطرف أو نزيف شرياني، وفي حال وجوده قم بإيقافه.
- بعد تأمين مجرى الهواء لجميع المصابين، وإيقاف النزيف الحاد، قم بالجولة الثانية.

✂ الجولة الثانية (Second round)

الفحص الشامل:

(general examination):

- قم بعملية الفحص الشامل للتأكد من عدم وجود أي إصابات أخرى، واتخذ الإجراءات الإسعافية الكاملة لكل مصاب مع عدم إغفال المصابين الآخرين.
- أعط المصاب مغذية رينجر مع تدفئة المصاب.
- أعط المصاب مسكن للألم.
- قم بتثبيت الكسور إن وجدت.
- ضع المصاب في الوضعية المناسبة.
- استمر بهذه الطريقة حتى الإنتهاء من جميع الحالات.
- بعد تأمين مجرى الهواء، وتضميد

GENERAL EXAMINATION
الفحص العام

6

الفحص الشامل

General Examination

٢. فتح الممر (الهجري) الهوائي:

(Airway maintenance):

- ومن خلال فحص الإستجابة، إن كان المصاب مستجيب لك ويتكلم فالممرات الهوائية بالتأكد مفتوحة.
- أما إن كان غير مستجيب ولم يتكلم، فقم بفتح المجاري الهوائية وأزل أي عائق مع مراعاة تثبيت الفقرات العنقية.

٣. فحص التنفس:

(Breathing examination):

- للإجابة على سؤال هل الشخص المصاب يتنفس تلقائياً أولاً يتنفس.
- ويتم تطبيقها للمصاب الغير مستجيب بعد فتح مجرى الهواء.
- ويكون فحص التنفس عن طريق تطبيق قاعدة أسمع وأنظر وتحسس.

٤. فحص الدورة الدموية:

(Circulation examination):

- إن كان المصاب مستجيب، تحقق من وجود نزيف شديد بالنظر إلى كل جسم المصاب بحثاً عن ثياب مبللة بالدم، وخاصة في منطقة الحوض والأفخاذ فالكثير يغفل عنها، وقم بالسيطرة عليه من خلال الضغط المباشر أو الأربطة.
- إن كان المصاب غير مستجيب قم أولاً بإبشتعار النبض بالضغط على الشريان السباتي بجانب الحنجرة أو الشريان الكعبري في الزند وذلك للإجابة على

التعريف:

(Definition):

هو الخطوات أو الإجراءات التي يقوم بها المسعف عند فحص أي مصاب.

أهمية الفحص الشامل:

Important of general examination:

١. البحث عن وجود إصابات مخفية.
٢. التقييم الواقعي للإصابات الموجودة.
٣. إعطاء المصاب حقه من الرعاية الصحية المطلوبة.
٤. يعطي المسعف القدرة على تقسيم الحالات إلى مجموعات بحسب خطورتها (تصنيف المصابين).

مراحل الفحص الشامل:

Stages of general examination

A. الفحص الأولي: (الفحص السريع)

(Initial examination):

هو الإجراء العام الإنقاذي والذي يستغرق أقل من دقيقة واحدة، وهو كالآتي:

١. فحص استجابة (وعي) المصاب:

Examine the response of the patient

- للإجابة على سؤال مهم هل هذا الشخص مستجيب أو غير مستجيب.
- تحدث إلى المصاب، أسأله عن اسمه وأضربه ضرباً خفيفاً على كتفه، فإن أجابك وتكلم فهو مستجيب وإن لم يجبك فالمصاب غير مستجيب.

فحص الرأس (Head) ويشمل:

عملية إجراء الفحص الشامل:

The procedure of conducting the examination



١. الفم (Mouth):

تحقق مرة أخرى من التنفس (عمقه سهلاً أم صعباً أم مصحوباً بصوت) ولاحظ وجود رائحة في الفم أو وجود مواد غريبة كالقيء والدم والأطعمة الأسنان المكسورة التي قد تسبب اختناق. افحص الشفتين ولاحظ تغير لونهما فزرقتهما يدل على إختناق، وفتش عن آثار حروق بالفم من المواد الكيميائية.

٢. العينان (Eyes):

افحص الحدقتين ولاحظ إن كانت سعتهما واحدة، وافحص بياض العين للبحث عن وجود بقع دموية فيه، أو تغير في اللون.

٣. الأنف (Nose):

افحص الأنف للبحث عن آثار للدم أو السائل النخاعي (أبيض اللون) والذي يأتي من الجمجمة، أو مزيج من الاثنين.

سؤال هام هل القلب يعمل أو لا يعمل، ثم تحقق من وجود نزيف وسيطر عليه.

B. الفحص الثانوي الشامل:

General Secondary examination

بدءاً من شعر الرأس وحتى أخمص القدمين.

إن عملية الفحص تتطلب أموراً تؤخذ بعين الاعتبار، وهي قصة الإصابة (كيفية حدوث الإصابة)، الأعراض، والعلامات الحيوية وتشمل مدى الاستجابة (درجة الوعي):

١. القصة (History): وهي أخذ وصف كامل بقصة وقوع الحادث من الشخص المصاب مباشرة، أو من شاهد عيان زميل له.

٢. العلامات الحيوية (Vital signs): هي علامات ودلائل ظاهرية يمكن أن تميزها وتراها من خلال المشاهدة أو السماع أو اللمس، وهي معدل التنفس، معدل النبض، ضغط الدم، درجة الحرارة، ودرجة الوعي.

٣. الأعراض (Symptoms): وهي الأحاسيس التي يشعر بها المصاب ويصفها لك (وأكثرها فائدة الألم).

٤. كيفية إجراء الفحص: يجب إجراء فحص عام بسرعة سواء كان المصاب واعياً أو فاقد الوعي، متبعاً بعض القواعد الآتية:

- أ- لا تحرك المصاب كثيراً تجنباً لتفاقم الإصابة.
- ب- أبداً فحصك من الرأس ومنتهياً بالقدمين.
- ت- استعمل حواسك.
- ث- قارن دائماً بين جانب من جسم المصاب والجانب الآخر لأن ذلك يسهل عليك إكتشاف أي تورم أو تشوه يحتاج إلى إسعاف أولي.
- ج- إذا أصبح تنفس المصاب مصحوباً بأصوات وصعباً في أي مرحلة من مراحل فحصه ضعه في وضع الأمان.



6

يمكن أن يدل على وجود كسر، وفحص الجزء السفلي منه، مرر يديك تحت تقعر الظهر دون تحريك المصاب من الأعلى بطول العمود الفقري إلى أدنى نقطة تصل إليها يديك.



فحص الجذع (Trunk):

افحص الصدر للتأكد من إنضباط حركة الأضلاع أثناء التنفس، ولاحظ وجود سحجات أو كدمات أو أي جرح يمتص الهواء، فتش في الأضلاع عن أي بروز أو إنخفاض يمكن أن يدل على كسور. إفحص عظمتي الترقوة والكتفين ولا حظ عدم الإنتظام فيها.



٤. الوجه (Face):

أنظر إلى لون المصاب فقد يكون شحباً أو متورداً أو مائلاً للزرقة تبعاً للتنفس متأثراً بالإصابة.

٥. الأذنين (Ears):

أفحص الأذنين بحثاً عن الأجسام الغريبة وأثار الدم والسائل الدماغي الشوكي الرائق الذي قد يدل على كسر في عظام الجمجمة، وتكلم معه أو اهمس في أذنه لاختبار سمعه.

٦. الجمجمة (Skull):

مرر يديك بلطف فوق فروة الرأس بحثاً عن أي جرح نازف أو تورم أو أي أثر يدل على وجود كسر.

فحص العنق والعمود الفقري

(Cervical Spine and Neck):



يفك الملابس حول العنق، تحسس بأصابعك العمود الفقري من قاعدة الجمجمة إلى أقصى ما يمكن أن تصل إليه بين الكتفين بحثاً عن عدم إنتظام في الفقرات حيث

والكاحلين والقدمين وأصابعهما بنفس طريقة فحص الذراعين.



فحص مدى الاستجابة:

✎ يمر المصاب بمراحل مختلفة أثناء تحوله من الوعي إلى فقدان الوعي، فإذا استجاب بشكل جيد للتنبيه كان فقدته للوعي بسيطاً ولكن يظل الخطر قائماً. ✎ أما إذا كانت الاستجابة ضعيفة أو معدومة كان فقدان الوعي كبيراً والخطر عظيماً وعلى المسعف أن يعيد الفحص كل عشر دقائق ويلاحظ استجابته للتنبيه:

١. الصوتي (تكلم بصوت عال في أذنه).
٢. اللمس (حاول إيقاظه بهز كتفه).
٣. الألم (راقب وجهه وحركة الأطراف أثناء قرصك لليد أو الكاحل).

فحص البطن (Abdomen):

هل يوجد به سجات، أو كدمات، أو تصلب جدار البطن، أو جروح، تحسس الحوض واضغط برفق على عظمتي الحوض بحثاً عن وجود كسر ولاحظ أي علامة تدل على وجود دم في مجرى البول.



فحص الذراعين (Arms):

إفحص عظام العضدين ثم عظام الساعدين والرسغين واليدين والأصابع، افحص بعناية عن وجود أي تشوه في الشكل أو تورم يدل على كسور.



فحص الساقين (legs):

افحص الوركين والفخذين وعظمتي كل ساق

تهيئة أسباب الشفاء:

Creation of causes of healing

١. التخفيف من قلقه ومعاملته بلطف.
٢. تسكين ألم المصاب.
٣. حماية المصاب من البرد والبلل.
٤. وبعد قيامك بالإجراءات اللازمة ابدأ في تدبير أمر نقله إلى أقرب مركز إسعافي، ويجب أن يصاحب المصاب تقريراً موجزاً عما تم إتخاذه وعمله، كما يجب عليك الإحتفاظ بمقتنيات المصاب وتسليمها إلى المركز الإسعافي عند نقله، أو بحسب التعليمات المتبعة في منطقتك.

الإجراء الإسعافي العام:

(General emergency measure)

يجب على المسعف القيام بالإجراءات اللازمة لكل حالة بلطف ولكن بسرعة، ومن الأهمية بمكان أن تظمن المصاب وتشجعه باستمرار.
لا تنسى كمسعف أن أهدافك هي:

الحفاظ على الحياة:

(Maintain life):

١. وضع المصاب في الوضع الآمن.
٢. أبدأ في الإنعاش إذا كان المصاب لا يتنفس وقلبه لا ينبض.
٣. سيطر على النزيف.

منع تدهور الحالة:

(Prevent deterioration of the situation):

١. تضميد الجروح.
٢. تثبيت الكسور الكبيرة بالطرق المناسبة.
٣. وضع المصاب في وضعية مريحة.



ASPHYXIA - SINKING

الاختناق والغرق

7

الإختناق

Asphyxia

ملاحظة:

إن أي من الأسباب المذكورة قد تؤدي إلى اختناق جزئي أو كلي.

الأعراض والعلامات العامة:

General Signs and symptom

١. صعوبة في التنفس.
٢. التنفس بصوت عالي مصحوب بصوت الشخير.
٣. ظهور رغبة على الفم.
٤. إزرقاق لون الشفتين والأصابع.
٥. انخفاض وعي المصاب واحتمال فقدان الوعي.
٦. توقف التنفس.

آلية حدوث الاختناق:

(Mechanism of Asphyxia):

١. إنسداد مجرى الهواء بجسم غريب.
٢. تضيق الحلق والحنجرة والشعب الهوائية لأحد الأسباب التالية:
- ✍ إستنشاق الغازات السامة ومسيلات الدموع.
- ✍ إستنشاق أول أكسيد الكربون الناتج عن الحرائق.
- ✍ التحسس من بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية كالبنسلين.
- ✍ بعض الأمراض كالربو.

التعريف:

(Defination):

هو عملية إنسداد مجرى الهواء.

أنواع الإختناق:

(Type of Asphyxia) :

١. الإختناق الجزئي: إنسداد جزئي لمجرى الهواء (الشرعة).
٢. الإختناق الكلي: إنسداد كامل لمجرى الهواء.

الأسباب:

(Causes):

١. إنسداد مجرى الهواء.
٢. تعرض الصدر للضغط «جدار وزحام».
٣. الملابس المعيقة للتنفس.
٤. تورم أنسجة الحلق نتيجة الحروق أو الصدمة التحسسية.
٥. إرتجاع اللسان وتقلص الحنجرة.
٦. عدم إحتواء الهواء على قدر كاف من الأكسجين.
٧. الغازات الناجمة عن الحرائق وخاصة أول أكسيد الكربون.
٨. التسمم بغازات سامة.
٩. الشنق.

٢. الاختناق الكلي:

ستلاحظ أن المصاب لم يعد بمقدوره الكلام أو التنفس أو السعال وقد يمسك بعنقه.

١. ضع قبضة يدك على بطن المصاب مباشرة فوق السرة مناوره هيملخ.
٢. أمسك القبضة بيدك الأخرى واضغط بطن المصاب إلى الداخل وإلى أعلى.
٣. تابع الضغط حتى يخرج الجسم الغريب.

٤. وفي حال أن المصاب فقد الوعي، طبق إجراء الإنعاش القلبي الرئوي.

٣. تضيق الحنجرة:

- ✎ قم بإجراءات التنفس الصناعي في حال كان قد فقد الوعي.
- ✎ طبق إجراء الإنعاش القلبي الرئوي.

الإسعاف الأولي:

(First aid) :

١. الاختناق الجزئي: (شرغة القات):

- قم بتشجيع المصاب على السعال وعدم الكلام.
- قم بإخراج أي مواد من الفم. كالقات مثلاً.
- قم بالضرب خمس مرات على ظهره.



7

الغرق

Sinking

التعريف:

(Defination):

هو انسداد مجرى الهواء بسبب تضيق الحنجرة نتيجة تهيجاً من دخول سائل كالماء.

آلية حدوث الغرق:

(Mechanism of Sinking):

يحدث كردة فعل لإنقباض الحنجرة وإغلاق مجرى التنفس مؤدياً بذلك إلى الإختناق ولا يحدث تسرب للمياه بشكل كبير إلى الممرات التنفسية.

الأعراض والعلاجات:

Signs and symptoms:

١. أعراض ودلالات الاختناق.
٢. تظهر رغبة حول شفتي المصاب بالإضافة إلى سوائل حول فتحتي الأنف.

٣. قد يصبح الشخص مهدداً بالركود الحراري إذا سقط في الماء البارد.
٤. السعال الشديد.
٥. ألم في الصدر.

الإسعاف الأولي:

(First aid) :

١. إعمل على إزالة أي عوائق تمنع المصاب من التنفس.
٢. إجعل المصاب في وضعية السجود وقم بالضغط على بطنه لإخراج السائل.
٣. في حال أن المصاب لم يتنفس فابدأ بإجراءات الإنعاش القلبي الرئوي فوراً.
٤. بمجرد أن يبدأ المصاب في التنفس اجعله في وضعية الأمان.
٥. أنزع عنه الملابس المبللة وأمن له الدفء.
٦. أرسله إلى أقرب مركز إسعاف بسرعة.

SHOCK

الصدمة

8

الصدمة shock

التعريف:

(Defination):

هي قصور أجهزة الجسم في القيام بعملها، مما يؤدي إلى نقص كمية الأكسجين عن الأعضاء الحيوية وخاصة الدماغ.

أنواع الصدمة:

(Types of shock):

١. الصدمة النزفية (الحجمية):

(Hemorrhagic shock):

هي الصدمة الناتجة عن فقدان كمية كبيرة من الدم.

أسباب الصدمة:

(Causes of the shock) :

١. النزيف الداخلي.

٢. النزيف الخارجي.

الأعراض والعلامات:

(Signs and symptoms):

١. شحوب في الوجه والشفاه.

٢. إنهاك وتعب جسدي عام.

٣. التنفس سريع وسطحي وغير منتظم.

٤. هبوط في ضغط الدم.
٥. انخفاض في درجة الحرارة.
٦. غياب عن الوعي.

الإجراء الإسعافي:

(Emergency measure):

١. وضعية المصاب: رفع الطرف المصاب للأعلى وخفض الرأس، وفي حال بدأ يطرش أو يتغير وعيه فضعه في الوضعية الآمنة.



٢. إبدأ بالإنعاش الأساسي إذا احتاج المصاب لذلك.
٣. أوقف النزيف بالأربطة أو الضغط المباشر على الشرايين الرئيسية.
٤. تأكد من تدفئة المصاب.
٥. عوض الدم المفقود بالسوائل.
٦. راقب العلامات الحيوية باستمرار.

٣. الصدمة النفسية:

(psychiatric shock):

هي الصدمة الناتجة عن خلل مفاجئ ومؤقت في الجهاز العصبي.

الأسباب:

(Causes):

١. سماع الأخبار السيئة.
٢. رؤية مصاب أو رؤية الدم لأول مرة عند بعض الناس.

العرض والعلامات:

Signs and symptoms:

١. هبوط في ضغط الدم.
٢. تعب ووهن وتعرق وبرودة.
٣. إتساع حدقة العين وتشوش الرؤية.
٤. قد يحدث له إغماء ويفقد الوعي.

الإجراء الإسعافي:

(Emergency measure):

١. تدارك المصاب قبل الوقوع على أداة جراحة.
٢. وضعية المصاب: مستلقي على ظهره ورفع رجليه للأعلى.
٣. عادة ما يحضو المصاب بشكل سريع.

٢. الصدمة التنفسية:

(hypoxia Shock):

هي الصدمة الناتجة عن نقص كمية الأكسجين في الدم.

الأسباب:

(Causes):

١. إنسداد مسالك الهواء.
٢. وجود جروح نافذة في الصدر (الاسترواح).
٣. عدم قدرة المصاب على التنفس نتيجة لبعض الأمراض مثل الإصابة بأزمة ربو.

العرض والعلامات:

Signs and symptoms:

١. ضيق وتسارع بالنفس.
٢. تسارع في ضربات القلب.
٣. إنخفاض في ضغط الدم.
٤. ألم في الصدر.
٥. إنعدام أصوات التنفس في الجانب المصاب.

الإجراء الإسعافي:

(Emergency measure):

١. فتح المجاري الهوائية.
٢. قم بالإجراء الإسعافي في حالة الجروح النافذة.
٣. قم بإنعاشه إن لزم الأمر.
٤. وضعية المصاب: على الجانب المصاب.



٥. الصدمة العصبية:

(Neurogenic shock):

عدم قدرة الجهاز العصبي على أداء وظيفته الطبيعية نتيجة لتعرض الحبل الشوكي لإصابة مباشرة أو غير مباشرة.

النسباب:

(Causes):

١. إصابة في العمود الفقري بسبب:
 ١. حوادث السيارات.
 ٢. السقوط من المرتفعات.
 ٣. طلق ناري مباشر.

الأعراض والعلامات:

Signs and symptoms:

١. عدم قدرة المصاب على تحريك أطرافه.
٢. إنعدام حاسة الألم في الأطراف التي لا يحركها.
٣. إحتباس في البول.
٤. هبوط ضغط الدم مع وجود دقات قلب طبيعية أو تحت الطبيعية (الصدمة الرحيمة التي ينخفض فيها النبض).

الإجراء الإسعافي:

(Emergency measure):

١. التأكد من سلامة مجرى الهواء.
٢. تأمين خطين وريدين.
١. عدم تحريك المصاب مطلقاً إلا للضرورة القصوى.
٤. تثبيت العمود الفقري بمساعدة الآخرين.
٥. نقل المصاب بأسرع وقت ممكن.

٤. الصدمة التحسسية:

(Anaphylactic shock):

هي الصدمة الناتجة عن دخول مادة يتحسس الجسم منها.

الأسباب:

(Causes):

التحسس من علاج أو مادة معينة: كالبنسلين، لسع الحشرات أو استنشاق غبار.. الخ.

الأعراض والعلامات:

Signs and symptoms:

١. احمرار وحكة في الجسم.
٢. تورم الحلق.
٣. تورم الجسم وخاصة الوجه والرقبة.
٤. سعال أو عطاس.
٥. ضيق في التنفس.

الإجراء الإسعافي:

(Emergency measure):

١. تأمين المجاري التنفسية.
٢. إفتح خط وريدي واعطه سوائل.
٣. قم بإعطاء المصاب إبرة مضاد للتحسس إن وجدت.
٤. وضعية المصاب: وضعية الأمان الجانبي.
٥. أزل سبب التحسس إن كان واضحاً.
٦. أرسل المصاب إلى أقرب مركز إسعاف مع المادة التي تحسس منها (إن أمكن).
٧. راقب العلامات الحيوية باستمرار.

TOXICATION

التسمم

9

التسمم Toxication

تشخيص حالات التسمم :

إذا رأينا أو علمنا أن شخصاً تناول مادة سامة، أو إذا أخبرنا هو بذلك، وعرفنا نوع المادة والكمية المأخوذة والفترة التي مضت على تناولها فإن ذلك يساعد كثيراً في تقديم الإسعاف ويعتبر عاملاً مساعداً على إنجازه.

أمّا إذا واجهتنا حالة مرضية غير طبيعية، أو إذا كان المصاب فاقداً للوعي فكيف لنا أن نعرف أن هذا الشخص قد تناول سمّاً؟؟

علامات التسمم :

أولى العلامات التي تثير الشك حول حدوث التسمم عند شخص ما هو تردّي حالته بشكل مفاجئ وغير مفهوم.

وأهم العلامات التي تثير الشك لحدوث حالة تسمم هي:

١. إقياءات (قد تكون شديدة).
٢. إسهالات (قد تكون شديدة).
٣. آلام بطنية.
٤. الإصابة بالوهن والخمول.
٥. تبدلات في حدقة العين.
٦. اضطرابات في الضغط والنبض.
٧. حدوث صعوبة في التنفس.
٨. خروج سائل رغوي من الأنف والفم.
٩. تصاعد روائح خاصّة من فم المصاب.
١٠. حدوث نوبات تشنّج .

التعريف:

(Defination):

السم هو كل مادة ضارة إذا دخلت إلى جسم الإنسان أحدثت تخریباً في خلاياه وأدت إلى مظاهر مرضية تختلف شدّتها ونتائجها بين سم وآخر، فمنها ما يؤدي إلى الموت ومنها ما دون ذلك، ومنها ما يؤثر مباشرة على مراكز التنفس والقلب والدوران ومنها ما يسبّب الاختناق ومنها ما يخرّب الكبد والكلّى وغير ذلك.

أشكال التسمم :

تظهر آثار التسمم على الإنسان بعد دخول السم إلى جسمه بشكلين :

أ- الشكل الأول :

وهو ما ينتج عن دخول كميات كبيرة من السم دفعة واحدة، أو دخول كمية قليلة من مادة شديدة السميّة، فتسبب ظهور الأعراض بشكل فجائي وعنيف قد يؤدي إلى الموت، وهذا ما نسميه «التسمم الحاد» .

ب- الشكل الثاني :

وهو ما ينتج عن دخول كميات قليلة من المادة السامة وعلى فترات متعددة تؤدي إلى ظهور الأعراض بالتدرج، وبمرور الزمن، وهذا ما نسميه «التسمم المزمن» ، وسيكون مجال عملنا على التسمم الحاد فقط إذ إن التسمم المزمن يخرج عن نطاق الإسعاف.

طرق دخول السم إلى جسم الإنسان :

تدخل السموم إلى جسم الإنسان عن طريق :

١. الجهاز الهضمي : عبر الفم

٢. الجهاز التنفسي : عبر الاستنشاق

٣. الجلد : عبر المحافن ، لسع الحشرات

أولاً : التسمم عن طريق الجهاز الهضمي :

١. التسمم الغذائي :

ينتج عن اللحوم والمعلبات والحليب ومشتقاته، الأغذية التي تباع مكشوفة خاصة الحلويات، وعادة تظهر علامات التسمم الغذائي على شخص واحد أو على مجموعة من الناس بعد تناولهم طعاماً مشتركاً حيث تبدأ الأعراض بعد عدة ساعات.

أ- الأعراض :

✍ غثيان و إقياء

✍ إسهال

✍ التشنجات البطنية المؤلمة

✍ ارتفاع حرارة مع تعرّق غزير

✍ إعياء وانحطاط عام في الجسم

✍ آلام مفصلية متعددة

✍ اضطرابات بصرية كالشفع (رؤية مزدوجة)

✍ تبدلات في حدقة العين

ب- الإسعافات الأولية :

عند الشك في حالات التسمم الغذائي يجب تطبيق الإجراءات التالية :

١. اعمل على تأمين ال ABC .

٢. اجعل المصاب في وضعية الجلوس مع الانحناء للأمام قليلاً (في حال كان المريض واعياً)، وذلك لمنع حدوث أي استنشاق بمفرزات المعدة الناجمة عن الإقياء.

٣. حث المصاب على التقيؤ عبر دغدغة نهاية الحلق بالإصبع أو بالطرف الخلفي لملعقة الطعام في حال مرور أقل من ٢ ساعات على تناول الطعام الفاسد.

٤. يعطى المصاب الماء الممزوج مع الملح (لتحريض التقيؤ).

٥. اعطاء سوائل وريدية للمصاب المتسمم (إقياءات وإسهالات شديدة)

٦. نقله بسرعة للمستشفى في الحالات التي تستدعي النقل .

انتبه !!

تظهر الأعراض في حالات التسمم بالجراثيم التي تتكاثر بالحليب ومشتقاته بعد الى ١-٦ ساعات من إستهلاك الطعام (الذيفان: سم الجراثيم متواجد في الأطعمة) أو بعد ٦-١٢ ساعة (يتشكل الذيفان بعد دخول الجراثيم للجسم) ، أما في حالات التسمم بالمعلبات وحوادث الإصابة (بالذيفان) فتظهر الأعراض بعد ٢١ ساعة من استهلاك الطعام.

الإسعافات الحربية

✚ قد تنتهي المسألة بموت المصاب بالتسمم.

ب- الإسعافات الأولية :

إذا كان المتسمم فاقداً للوعي :

- ✚ اعمل على تأمين ال ABC .
- ✚ وضع المصاب بوضعية الأمان الجانبي
- ✚ الإسراع في نقل المصاب إلى المراكز الإنعاشية المتقدم القريب منك لأن المريض يحتاج الي غسيل للمعدة .
- ✚ في حال حدوث نوبات تكرر يجب وضع قطعة بلاستيكية Airway ضمن فم المتسمم لكي لا يعض لسانه ويسد الطريق الهوائي.

إذا كان المتسمم واعياً :

- ✚ تحديد نوع السم الذي تناوله المصاب بسرعة
- ✚ وضع المصاب بوضعية نصف جلوس مع الانحناء للأمام قليلاً.
- ✚ الإسراع في نقل المصاب إلى المراكز الإنعاشية المتقدم القريب منك لأن المريض يحتاج الي غسيل للمعدة .
- ✚ يجب ألا ننسى دائماً ضرورة تدفئة المصاب وهو في طريقه إلى المركز الإنعاشي.

٢. التسمم بابتلاع مادة سامة :

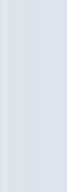
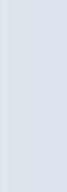
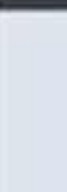
يمكن أن يبتلع الإنسان المادة السامة عمداً بقصد الانتحار، أو سهواً دون علم منه بسميتها أو عبثاً كما يفعل ذلك بعض الأطفال، أو قد تقدم له دساً بقصد القتل. وهنا يختلف تأثير السم حسب مقدار الكمية التي تناولها الشخص ودرجة سميتها، وحسب عمره وصحته، ومقدرة جسمه على التحمل.

أ- الأعراض :

- ✚ صدور رائحة غريبة من فم المتسمم صادرة عن المادة السامة التي تناولها
- ✚ شعور بالغثيان وقد تحدث الإقياءات
- ✚ ظهور رغبة أو ما شابه داخل فم المتسمم
- ✚ وخز وتنميل حول الفم والوجه
- ✚ الشعور بالإعياء العام والضعف العضلي
- ✚ حدوث تشنجات وآلام بطنية متزايدة
- ✚ ضيق في التنفس وضعف في النبض
- ✚ تبدل في قدرة المتسمم على الإدراك
- ✚ تبدل في حدقتي العينين اتساعاً أو تضيقاً
- ✚ اضطراب بالوعي، فقد الوعي التام والسبات العميق
- ✚ حدوث الاختلاجات المتكررة
- ✚ ينخفض الضغط الدموي الشرياني عند المتسمم ويصاب بالصدمة



9



٣. التسمم بالندوية :

تحدث بعض الأدوية تسمّات قد تكون خطيرة، خاصة عند تناول كميات تفوق المقادير المسموح بها أو عند وجود حساسية مفرطة اتجاهها و أهم هذه الأدوية: المنومات، مضادات الحساسية، الأسبرين.

أ- الأعراض :

- ✖ الدوخة والصداع
- ✖ انحطاط القوى وعدم القدرة على الوقوف أو السير
- ✖ ضعف النبض والتنفس، ازرقاق الوجه وبرودة الأطراف
- ✖ النعاس الذي يتلوّه النوم ثمّ الدخول في مرحلة الغيبوبة الكاملة إذا كانت الكمية كبيرة
- ✖ قد يتوقّف التنفس نهائياً ويحدث الموت
- ✖ يحدث تناول الأسبرين الزائد غثائاً وطنيناً بالأذنين وإقياءاً ممزوجاً بالدم وتعرّقاً غزيراً.

ب- الإسعافات الأولية :

- ✖ اعمل على تأمين ال ABC .
- ✖ الإسراع في نقل المصاب إلى المراكز الإنعاشية المتقدم القريب منك لأن المريض يحتاج الي غسيل للمعدة .
- ✖ وضع المصاب بوضعية الأمان الجانبي .

ثانياً : التسمم عن طريق الجهاز التنفسي :

يحدث هذا التسمم لدى الإنسان إذا استنشق غازات سامّة، أو إذا استنشق سموماً حملها الهواء بشكل رذاذ. إن أهم غازين سامين يحدثان التسمم عند الإنسان هما غاز أول أكسيد الكربون وغاز الاحتراق المنزلي. وإن أهمّ مادة تتطاير مع الهواء وتسبّب تسمماً للإنسان هي المبيدات الزراعية التي تستعمل رشاً.

١. التسمم بغاز أول أكسيد الكربون CO :

يشكل هذا الغاز واحداً من أهم الغازات المسيّبة للتسمم عند الإنسان، والمصدر الشائع له عادة هو ما ينطلق من محركات السيارات (خاصة في مكان مغلق) أو ما ينطلق من موقد فحم أو غيره في غرفة مغلقة أو قليلة التهوية، أو أثناء الحرائق.

الأعراض:

- ✖ طنين في الأذنين مع الدوخة
- ✖ ثقل في الرأس مع ألم نابض
- ✖ ضعف ووهن عام
- ✖ تبدلات لون الجلد من شحوب إلى إزرقاق أو ظهور لون أحمر قرمزي في المستويات العالية
- ✖ تشنجات عضلية مع تهيج المريض
- ✖ ألم صدري مع صعوبة بالتنفس وتسرع النبض
- ✖ الميل للنوم، فقدان الوعي، السبات ومن ثمّ الموت

لدى استعمالها لرش المحصولات الزراعية أو إذا تناثرت فوق جسمه وثيابه حيث يمتصها الجلد باللامسة.

أ- الأعراض :

١. فرط اللعاب والعرق والدموع
٢. الغثيان، الإقياء والإسهالات
٣. ضيق نفس مع تسرع في التنفس وألم صدري
٤. سعال متزايد منتج لمفرزات قصبية كثيرة مع سيلان أنفي غزير
٥. التعب و الإنهاك
٦. ضعف عضلي تشنجي حتى الشلل
٧. صداع و دوخة
٨. اختلاجات (تشنجات).
٩. ضعف في الرؤية (تضيق شديد في الحدقتين).
١٠. تباطؤ قلبي مع اضطراب بالنظم وقد يحدث توقف قلب
١١. زيادة تبول مع تعدد بيلات

ب- الإسعافات الأولية :

- ✍ قم بتأمين ال ABC .
- ✍ نقل المصاب إلى أقرب مركز إنعاشي أو المستشفى بأسرع ما يمكن

الإسعافات الأولية :

١. إخراج المصاب من المكان بسرعة إلى الهواء الطلق (يجب على المسعف ارتداء أجهزة الوقاية التنفسية قبل دخوله إلى الأماكن المغلقة).
٢. تأمين ال ABC .
٣. إعطاء الأكسجين بتركيز مرتفع حتى إلى ١٠٠ %.
٤. فك أربطة العنق والأحزمة والألبسة المشدودة
٥. وضع المريض بوضعية نصف جلوس
٦. معالجة الصدمة عند الحاجة
٧. نقله إلى المستشفى بسرعة مع الإبلاغ المسبق.

٣. التسمم بالفسفور العضوي (المبيدات الحشرية) :

ومن أهمها ما ينتج عن استنشاق الرذاذ المتطاير في الهواء عند رش المزروعات بالمبيدات الحشرية (مركبات الفوسفور العضوية) حيث أن بعض هذه المبيدات تكون خطيرة على الإنسان، ليس إذا ابتلعها فحسب، بل إذا استنشق ذراتها المتطايرة (الرذاذ) الغير مرئية



9

٣: التسمم عن طريق استخدام الأسلحة الكيميائية:

تعريف الأسلحة الكيميائية :

Definition of chemical War

❖ هي عبارة عن استخدام المواد الكيميائية السامة في الحروب لغرض قتل أو تعطيل الإنسان أو الحيوان ويتم ذلك عن طريق دخولها الجسم بالاستنشاق أو الملامسة أو البلع.

❖ وهذه المواد قد تكون غازية أو سائلة سريعة التبخر ونادراً ما تكون صلبة، تطلق في الفضاء أو ترسل بواسطة الطائرات أو توضع في ذخائر على شكل قنابل أو قذائف بحيث تكون مغلفة بالرصاص الذي لا يتفاعل معها.

الآثار النفسية والاجتماعية للاستخدام الأسلحة الكيميائية:

❖ إن الآثار النفسية والاجتماعية للحرب الكيميائية لا تقل أهمية عن آثارها الفسيولوجية والجسدية فهناك آثار مرتبة على التهديد باستخدام هذه الأسلحة وآثار مرتقبة نتيجة للإستخدام الفعلي لها.

❖ فالتهديد باستخدام الأسلحة الكيميائية يخلق حالة من الخوف والرعب في المجتمع المهدد تتناسب مع وعي أفرادها بأخطار هذه الأسلحة وأثرها وقد يؤدي ذلك إلى لجوء الأفراد إلى الهرب والنزوح من أماكنهم أو تؤدي إلى العجز والشلل وعدم القدرة على التصرف السليم أو أداء الأعمال المطلوبة. أما الإستخدام الفعلي فيؤدي إلى الذعر المفاجئ والخوف من الأقتراب من الأشخاص المصابين وتغيير التركيب الاجتماعي نتيجة لوفاة عدد كبير من المجتمع أو إعاقتهم والدمار الاقتصادي الذي يصيب المحصولات الزراعية والمنشآت ومصادر المياه وغير ذلك.

❖ لذلك فإن التهديد باستخدام الأسلحة الكيميائية وهو ما يقع ضمن دائرة الحرب النفسية التي تشنها الدول على بعضها البعض وكذلك الإستخدام الفعلي لهذه الأسلحة يولدان آثاراً إجتماعية ونفسية سيئة لدى أفراد المجتمع المهتم بهذا الأمر.



بعض نماذج الغازات المستخدمة في الأسلحة الكيميائية:

(Gases used in chemical weapons):

خواصه الطبيعية والكيميائية	اسم الغاز
أبيض اللون له رائحة طلاء الخشب، يذوب في الماء وهو غير ثابت «طيار» سهل التصنيع.	كلورو أسيتون (Chloroacetophenone CN)
عديم اللون ورائحته كرائحة التفاح وأثقل من الهواء لذلك يبقى قريباً من سطح الأرض وهو غير ثابت «متطاير»، ويزوب في الماء.	الفوسجين (Phosgen CG)
سائل سام قاتل لا لون له ولكن له رائحة تشبه رائحة الخوخ سريع الانتشار ويتطاير بدرجة كبيرة يحدث إحمرار للجلد مع تهيجه وزيادة معدل التنفس ثم الموت.	السيانيد Cyanide
سائل أو غاز كثافته عالية لا يمتزج بالماء تساعد إرتفاع حرارة الجو على سرعة نفاذه له رائحة الخردل لا لون له أما إذا كان تركيزه شديداً فله رائحة الثوم.	الخردل Mustard gas
عامل كيميائي سريع المفعول سام يعتمد على الظروف الجوية في فترة بقاءه في الجو لا لون له وله رائحة الكافور ويتم التطهير منه بالماء والصابون.	سارين Sarin GB



9

والأطراف ثم ينهك المصاب وتزرق الأذنان والشفتان ومن ثم هبوط الدورة الدموية وقد ينتهي الحال بالمصاب إلى الوفاة ما لم يحدث الإسعاف السريع.

مسمات الدم كالسيانيد:

(Blood Agents) :

تنتشر هذه المواد في الجسم بسرعة بواسطة الدم ولهذا فإن الموت يحصل بعد دقائق من التعرض إذا كانت الجرعة عالية وهي تمتص عن طريق الاستنشاق ثم تنتقل بسرعة إلى الدورة الدموية التي توصلها إلى الخلايا مما يؤدي إلى تعطيل استخدام الأكسجين من قبل الخلية وإذا حدث هذا للخلايا الواقعة في مركز التنفس تحدث الوفاة بعد تشنجات عنيفة واختناق وتوسع في حدقة العين.

مسميات القروح :مثل غاز الخردل:

(Blister Agents)

هذه المواد سواء على شكل سوائل أو غازات فإنها تسبب فقاعات وقروح صدرية على أي جز من أجزاء الجسم حين تلامسه ويتم دخولها إلى الجسم عبر جهاز التنفس أو الجلد أو الأغشية المخاطية فتعطل الأنسجة الحية لتوقف تكاثر الخلايا وخطورتها تكمن في تأثيرها ومضاعفتها المتأخرة فيه لا تحدث ألم إلا بعد مرور عدة ساعات من الإمتصاص وابتلاعها ينتج عنه تلف خطير للأنسجة الموجودة في

أنواع الأسلحة الكيميائية:

Types of the chemical War :

غازات مسيلة للدموع :مثل غاز الكلور وأسيون:

(Tear Agents) :

وتستخدم لإحداث الذعر والإزعاج في صفوف الآخرين وخفض معنوياتهم فهذه الغازات تأثيرها ضعيف في إحداث الضرر بالمصاب وتستخدم من قبل رجال الأمن الآن لتفريق جموع المشاغبين أو مباغطة مجرم متحصن في مكان مغلق، فهي تحدث تهيج للعين وإحداث ألم بها وإسالة الدموع وتقلص الجفن مع عدم الإبصار وتأثيرها وقتي لا يتجاوز اثني عشر ساعة ثم يزول ولا تؤدي لفقد البصر.

الغازات الخانقة: مثل غاز الفوسجين:

(Chocking agents)

جميع هذه المواد مهيجة للرئتين وتعطي أعراضاً متشابهة، فهي تؤثر بشكل رئيسي على الجهاز التنفسي، إذ يتلف أنسجة الرئة ويجعلها تفيض بالسائل إضافة إلى ما يحصل من تهيج واحتقان يسبب نقصاً في تبادل الأكسجين مع الأنسجة مما يؤدي إلى اختناقها وتعطيل وظيفتها وتأثير هذا الغاز خاصة يظهر بمجرد التعرض كتهيج في التنفس وألم في العين يعقبه إعاقة في التنفس وإحساس بألم في الصدر وسعال وقىء وألم بالرأس

غازات الأعصاب مثل سارين- سومان:

هي مواد كيميائية سامة إذا دخلت الجسم بالإستنشاق أو الملامسة أو البلع تؤثر على الجسم وخاصة الجهاز العصبي لأنها تؤثر على عمل الإنزيمات الموجودة بنهاية الأعصاب فتحدث تقيؤ وتقلصات عضلية وعدم تحكم بالبول والبراز وضيق في الصدر مع هبوط النبض والتنفس والدوخة والغيبوبة ثم الوفاة.

وسائل الوقاية من الأسلحة الكيميائية

(Means of chemical weapons protection):

1. الكثير من الأسلحة الكيميائية لها رائحة تميزها لذلك يكون هناك فرصة للإبتعاد عن منطقة التلوث.
2. إرتداء الأقنعة والملابس الواقية.

الإجراء الإسعافي:

(Emergency measures):

1. خلع الملابس الملوثة.
2. تطهير المنطقة التي تلوثت بالماء.
3. إجراء التنفس الاصطناعي لمن يحتاج.
4. استخدام مضادات المواد الكيميائية إن أمكن.
5. معالجة الأعراض.
6. أرسل المصاب إلى أقرب مركز إسعافي وبسرعة.

ثالثا - التسمم عن طريق الجلد :

الفم والأنف والحلق والرئتين أما الجلد فالتعرض يسبب ألم مع إحمرار وطفح وحكة مع إرتفاع درجة الحرارة ثم ظهور الفقاع وهي عبارة عن حويصلات مليئة بسائل مائي تنفجر بعد ثلاثة أيام تقريباً مخلفة القروح. ويعتبر الخردل أحد هذه المواد حيث يذوب بسرعة في المواد الدهنية للخلايا الجلدية وهو ثابت لا يمتزج بالماء ولذلك ينفذ في معظم المواد ما عدا المعادن والزجاج ويؤثر على الجهاز التنفسي والعين والجلد والجهاز الهضمي.

غازات شل القدرة (الهلوسة) : مثل الميسكالين:

(Incapacitating Agents)

ويتركز تأثير هذه المواد في الجهاز العصبي المركزي على النشاطات التالي:

1. الذاكرة: إذ يحدث فيها اضطراباً وخللاً.
2. القدرة على حل المشاكل: إذ يعطلها.
3. الإنتباه والتركيز والفهم: إذ يشوش هذه القدرات.

وبعد زوال أثر الغاز هذا تزول كل هذه الأعراض، دون أن تترك تعطيلاً دائماً لا جسمى ولا عقلياً وقد تراجع العسكريون عن إنتاج هذه المواد قليل لأنهم عرفوا أنه ليس من الممكن التكهن بالسلوك الإنساني تحت تأثير هذه المركبات وحولوا أبحاثهم لجهة ثانية محاولين إيجاد مواد مخدرة لتعطيل بعض وظائف الجسم يمكن التحكم بها.



9

هو دون ذلك، وحوادث عضات الحيات لا تحدث إلا في النهار بشكل عام لأن الأفاعي لا تتجول ليلاً.

آلية انتقال السم من فم الأفعى للإنسان:

تخزن الأفعى السم في غدة خاصة موجودة في سقف الفم، وتتصل هذه الغدة مع نابيين مجوفين موجودين في فكها العلوي بواسطة قناة خاصة ناقلة للسم

وعند العض تنغرس تلك الأنياب في جسم الضحية، وهنا تنقل السم في الغدة اللعابية للحية بقوة فيندفع السم إلى داخل جسم الضحية، لذلك تترك عضّة الأفعى السامة علامات تدل على انغراس أنيابها، في حين لا تترك عضّة الأفعى الغير سامة أثراً لتلك الأنياب.

تأثير سم الأفعى على الإنسان :

إن لدغ الأفعى للإنسان لا يسبب الوفاة إلا في حالات قليلة فقط إذ لا تتجاوز نسبة الموت للمدوغين واحد من كل خمسة، ويتعلق ذلك بكمية السم الذي دخل الجسم وبمقدار فعاليته وبعمر المدوغ وصحته، ومقدار تحمّله لذلك السم، وسرعة الإسعاف، خاصة وأن مفعول سم الأفاعي، بشكل عام، لا يبدأ بعد العض مباشرة بل يتأخر لبعض الوقت مع ملاحظة أن عضات الأفاعي التي تعيش في الماء أكثر خطورة.

إن عضّ أو لسع بعض الحشرات والزواحف للإنسان وإفرازها السم داخل جسمه تسبّب له أعراضاً سميّة قد تكون شديدة الوطأة عليه، وقد تسبّب له الموت أحياناً وفيما يلي ندرس أهم تلك الحالات:

التسمم بسموم الثعابين والعقارب



الأفاعي نوعان منها السامة ومنها الغير سامة ويكون رأس الأفعى السامة دقيق عادةً وتتميز هذه الأفعى ببطء حركتها وعدم خوفها من الإنسان عندما تراه بل

تهرب منه بهدوء أو لا تهرب أبداً، أما الأفعى الغير سامة فتتهرب بسرعة مذعورة بمجرد رؤيتها للإنسان، وهي ذات رأس كبير نسبياً.

ويمكن تمييز اللدغة السامة بوجود ثقبين النابين للفك العلوي للأفعى .

ب- سمية الأفاعي :

تختلف سمية الأفاعي كثيراً حسب نوعها، فمنها ما هو شديد السمية، ومنها ما

الإسعاف الحربي

٤. التقليل من حركته , وعدم استخدام أو تحريك العضو المصاب .
٥. ترك المصاب بوضعية مناسبة بحيث يكون العضو المصاب أسفل منطقة في الجسم (عكس إسعاف النزيف) لكي يخرج الدم الملوث بالسموم.
٦. لا تنسى مسح الدم النازف بقطعة شاش بلطف من سطح فتحات الجروح لكي لا يتجلط الدم فيعيق خروج الدم الملوث بالسم .
٧. حاول تبريد الطرف المصاب بكمادات باردة أو بتبلييل قطعة قماش خفيف ووضعها عليه , وذلك للتخفيف من جريان الدم في الأوعية.
٨. نقل المصاب إلى أقرب موقع إسعافي للمعالجة .
٩. إذا لم تستطع نقل المصاب بسرعة وتأخر ما يقارب من ساعة , قم بإرخاء الرباط الثاني (الأعلى) والانتظار لمدة ٥ دقائق مع ملاحظة ازدياد أي أعراض تظهر على المصاب مثل (الغثيان , ضيق التنفس , انتشار الألم) .
١٠. إذا لم تظهر أي أعراض فهذا يشير إلى أن الحالة مستقرة ومطمئنة وبالتالي يمكن إزالة الرباط الثاني (الأعلى) بعد ساعتين من الإصابة .

تنبيه

لا تقم بالضغط على مكان اللدغة لمحاولة إخراج السم لأن ذلك يؤدي إلى انتشار السم

ماذا يحدث للشخص عند لدغه بواسطة أفعى أو عقرب ؟

تحدث بعض الأعراض التي تختلف في شدتها حسب نوع وكمية السم وهي على الأغلب :

١. ألم شديد في مكان اللدغة.
٢. احمرار وتورم في مكان اللدغة.
٣. احمراراً واضحاً ينتشر حول موضع العض، فينتفخ العضو المعضوض ويحدث نزف داخلي تحت الجلد مكان العض.
٤. يشعر المصاب بعطش شديد ويرتجف جسمه
٥. يشعر المصاب بتشنجات عضلية عامة
٦. يفقد المصاب وعيه ويهذي
٧. ينزف المصاب من فمه وأنفه ومعدته ومثانته
٨. يضعف النبض وتهبط الحرارة وتتسع الحدقتان

الخطوات الإسعافية :

١. اربط أعلى الإصابة بمسافة (١٠سم) , والربطة الثانية في أعلى الطرف المصاب (منتصف العضد في حال إصابة اليد أو منتصف الفخذ في حالة إصابة القدم) .
٢. إذا كان لديك مشرط قم بعمل عدة فتحات حول الإصابة وكذلك عدة فتحات متتالية باتجاه أعلى إلى قرب الرباط الأول لكي يخرج الدم الملوث بالسم.
٣. تهدئة المصاب وتطمينه .

٣. عضّة الكلب :

إذا عضّ كلب مصاب بداء السعار إنساناً فإنه يلوّث مكان العضّة. وينتقل الفيروس إلى الإنسان مسبباً مرضاً خطيراً يؤدي إلى الوفاة ما لم يتمّ إعطاء العلاج في الوقت المناسب .

أ- الإسعافات الأولية :

١. غسل الجرح جيداً بالماء والصابون أو المطهرات.
٢. تخفيف السائل بالشاش المعقم م أو النظيف.
٣. تغطية الجرح ونقل المصاب إلى أقرب مركز طبّي حيث يعطى مصلاً مضاداً للكلب.

٢. لدغة العنكبوت والحشرات :

أ- الأعراض :

- تظهر الأعراض خلال ١٠ دقائق وتكون على الشكل التالي :
- ☐ ألم بسيط يشتدّ تدريجياً.
 - ☐ إبيضاض وتورّم مكان اللدغة.
 - ☐ ألم في البطن والظهر والمفاصل.
 - ☐ غثيان، ازدياد اللعاب.
 - ☐ عرق، ضيق في التنفس، تقلصات عضلية.

ب- الإسعافات الأولية :

- إجراءات عامّة (راجع إسعاف لسعة العقارب والثعابين)



WOUNDS & INJURIES
الإصابات والجروح

10

النزيف

Bleeding

التعريف:

(Defination):

هو خروج الدم وتدفقه خارج الأوعية الدموية نتيجة لتمزق في جدار الوعاء الدموي، بسبب إصابة رضية أو قاطعة أو مرضية.



إن رؤية الدم أو رائحته في حالات النزيف يترك عند كثير من الناس بما فيهم الجنود أثراً نفسياً، مما يعطي انطباعاً بأن النزيف غزيراً، بينما في الواقع يكون بسيطاً.

تصنيف النزيف:

(Classification of bleeding):

أ- بحسب مصدر النزيف:

(According bleeding sources):

١. نزيف شرياني (arterial bleeding):
يكون ناتجاً عن إصابة أحد الشرايين، ويكون النزيف سريعاً وناصباً، ولونه أحمر فاتح.

٢. نزيف وريدي (venous bleeding):
يكون ناتج عن إصابة أحد الأوردة، ويكون النزيف بطيئاً وغير نابض، ولونه أحمر قاتم.

٣. نزيف شعيري (capillary bleeding):
هو خروج الدم الناتج عن تمزق الأنسجة، مثل العضلات أو الجلد، ولا يكون النزيف فيه غزير.

ب- بحسب مكان النزيف:

(According bleeding sites):

١. نزيف خارجي (External bleeding):
- وهو تدفق الدم من الأوعية الدموية إلى خارج الجسم.
- ينتج عن إختراق أنسجة الجسم بجسم غريب كالأعيرة النارية والشظايا أو كسور مفتوحة.

شرب كمية قليلة جداً تسد الرمق).
٥. إستخدام بعض الأدوية مثل الورفارين والأسبرين.

تحديد خطورة النزيف:

Determining the risk of bleeding

٤. يمكن تقييم حدة النزيف بعدة اعتبارات:

١. مكان الإصابة (place of injury):
الرأس والرقبة، ثم الصدر والبطن، ثم الأطراف.

٢. نوع الوعاء الدموي المصاب:

Type of infected blood vessel

تزداد الخطورة إذا كان شرياني، وأقل خطورة إذا كان وريدي.

٣. كمية الدم النازف:

The amount of bleeding blood

كلما زادت كمية الدم النازف كلما كانت الإصابة أشد خطورة.

٤. نوع النزيف (Type of bleeding):

النزيف الداخلي أكثر خطورة من النزيف الخارجي، لصعوبة السيطرة عليه.

٥. حجم الإصابة (Size of injury):

كلما كان مساحة الإصابة وعمق اختراقها كبيراً، كلما كانت أشد خطورة.

٢. نزيف داخلي (Internal bleeding):

- وهو تدفق الدم من الأوعية الدموية إلى داخل أنسجة وتجاويف الجسم.
- غالباً ما تكون في: إصابات الفخذ، إصابات الصدر، إصابات البطن، إصابات الرأس.



عوامل تزيد من نسبة النزيف:

Factors that increase the rate of bleeding

١. النشاط البدني الزائد (الجري مثلاً).
٢. القلق والاضطراب.
٣. إرتفاع درجة حرارة الجو، والتعرض لحرارة الشمس المباشرة.
٤. شرب الماء الكثير. (لا مانع من

ملاحظة:

عند وجود مصاب ينزف، يجب على المسعف التعامل مع الموقف بهدوء تام، على الرغم من أن بعض الإصابات يكون فيها النزيف خطيراً، ولكن يبقى هناك وقت كافٍ لإنقاذه.

ينتج عنها فتحة صغيرة، ولا تحدث تمزق كبير، مثل إصابات الطلقات النارية والشظايا الصغيرة.



٤. قاطعه (Incised):

تقطع الجلد والأنسجة، التي تمر منها.



أنواع الإصابات الناتجة عن الأسلحة النارية والمقذوفات:

Types injuries by firearms and projectiles:

١. إصابات سطحية:

(Surface injuries):

قد تؤدي إلى كشط الجلد أو تكوّن سحجات أو إزالة جزء من الجلد.



٢. إصابات راضة:

(Abrasion injuries):

تؤدي إلى حدوث كدمات ورضوض في الجلد.



٣. إصابات خارقة (ثاقبة):

(Punctured injuries):



١٠. إصابات ضاغطة:

(Pressurized injuries):

تشكل ضغط عالي مما يؤثر على الأنسجة الرخوة (الرئتان، الدماغ، الأحشاء) مثل الضغط الناجم عن ضرب الطيران والمدفعية والإصطدام أو ربطة الحنفية لأكثر من اللازم.



٥. إصابات حارقة:

(Burning injuries):

تتحرق الأنسجة التي تصل إليها أو تدخل فيها كما الإصابات بشظايا كبيرة أو عيارات ثقيلة.

٦. إصابات حارقة مستمرة:

Continuous burning injuries:

مثل إصابة قنابل الفوسفور : حيث يستمر التفاعل مع الأكسجين في الهواء الجوي.

٧. إصابات متفجرة:

(Explosive injuries):

في الإصابات المتفجرة يدخل المقذوف ويتفجر داخل الجسم ويؤدي إلى تمزق في الأنسجة في منطقة متسعة وضياح الشظية أو خروجها من الجسم.

٨. إصابات متشظية:

(Fragmented injuries):

في الإصابات المتشظية يدخل المقذوف ويتفجر داخل الجسم ويؤدي إلى إصابات عديدة في منطقة واحدة أو في مناطق متقاربة.

٩. إصابات باترة:

(Amputation injuries):

تزيل العضو أو جزء من العضو (كلي أو جزئي) وتفصله عن الجسم.



10

الآثار الناتجة عن الإصابة بالأعيرة

النارية أو الشظايا:

(Effects of gunshot wounds or shrapnel):

١. تمزق في الأنسجة.
٢. تمزق الأوعية الدموية.
٣. كسور العظام.
٤. بتر الأطراف (كلي أو جزئي).

أعراض وعلامات النزيف العامة:

(Symptom & Signs of general bleeding):

↪ انظر ولاحظ (See Note):

١. الدم على ثياب المصاب والأرض.
٢. اكشف على الجروح النازفة المستترة بالثياب عبر إزالتها أو قطعها (الفحص السريع).
٣. الشحوب في الوجه والشفاه وباطنها والأظافر.
٤. إنهاك وتعب جسدي عام والتعرق

نقاط وقف النزيف الرئيسية:

(Main bleeding stops):

تستخدم هذه النقاط للسيطرة على حالات النزيف

الشديد. وهي التالي:

١. الشريان السباتي.
٢. الشريان الإبطيني.
٣. الشريان العضدي.
٤. الشريان الكعبري.
٥. الشريان الفخذي.
٦. الشريان المابضي.
٧. الشريان القصبي الخلفي.
٨. شريان ظهر القدم.

الشديد.

٥. غياب عن الوعي (في حال فقد المصاب كمية كبيرة من الدم).

✍ اسمع وانصت (Hear & Listen):

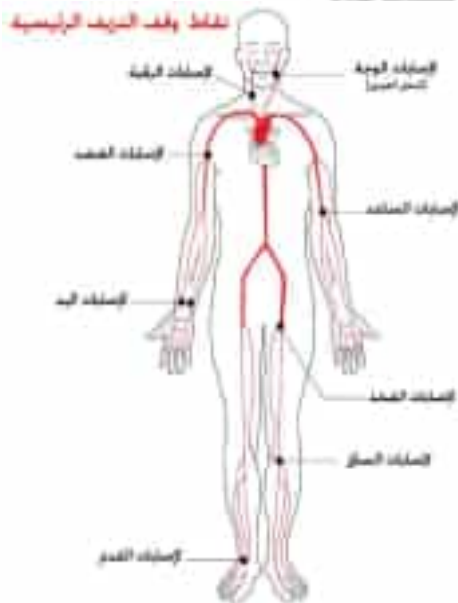
١. شكوى المصاب من العطش والبرد.
٢. شكوى المصاب من الألم.

✍ **تکلم مع المصاب (Talk to the injured):**

- قد يكون المصاب واعى بشكل تام، مستجيب أو غير مستجيب أو متشنجا، وقد يصبح بعدها غير واعى. (درجة الوعي).

المس وتفحص (Touch & Check):
(العلامات الحيوية):

١. النبض: سرعة النبض، وقوته، وانتظامه.
٢. التنفس: سرعة التنفس، وعمقه، وانتظامه.
٣. ضغط الدم.
٤. درجة الحرارة.



٢. الرباط الضاغط (Compress Bandage):

التعريف:

(Defination):

هو عبارة عن لفة من مواد قماشية ومطاطية، وغالبا ما تكون معقمة، ولها عدة أهداف:

١. تثبيت الضمادة.
٢. لملمة وتثبيت العضلات الممزقة.
٣. توقيف النزيف.
٤. تثبيت الجبائر.



في حال عدم توفر الرباط الضاغط يمكن استخدام الملابس (شال، معوز، جزء من الثوب).

أنواع الأربطة

:(Types of the Bandages)

١. الضمادات (Bandages):

التعريف:

(Defination):

هي مواد قماشية (شاش) تستخدم لتغطية الإصابات المختلفة، ولها عدة أهداف:

١. المساهمة بإيقاف النزيف.
٢. حماية الجروح من التلوث.
٣. تغطية الجروح وعزلها عن المحيط، (يكون حجم الضمادة أكبر من حجم الإصابة مرتين أو ثلاث مرات).

أنواعها:

(Types):

١. الشاش المربع (Square Gauze):

عبارة عن قطعة شاش مربعة توضع على الجرح مباشرة لتكوين الخثرة فيها.



٢. لفة الشاش العادية (Gauze):

عبارة شاش ملفوف مختلف الأحجام لتغطية الجروح.

ربطة الحنفية Tourniquet

التعريف:

(Defination):

وهي ربطة خاصة تستعمل في حالة النزيف الشرياني الشديد في الأطراف، وتربط إما أعلى الذراع أو الفخذ.

يمكن إستخدام جميع الوسائل التي تلبي الطلب (بإستثناء الحبال والأسلاك، أو أي شيء عرضه أقل من ٦ سم لأنه قد يؤدي إلى قطع الجلد).

كتابة ورقة تبين ساعة وتاريخ وضع ربطة الحنفية.



عند وضع ربطة الحنفية على الطرف يجب التأكد من الشد الجيد، وبشكل يؤثر على التروية.

الحالات التي تستخدم فيها ربطة الحنفية:

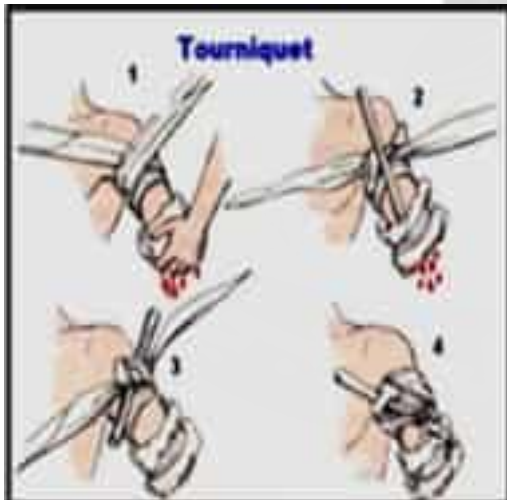
إن ربطة الحنفية لا تستخدم إلا كحل أخير للسيطرة على النزيف الحاد، وفي حالة فشل الوسائل الأخرى (كالحشو أو الربط)، كما أن هذه الوسيلة لا تستخدم إلا على الأطراف، ولا يكون الرباط فعالاً إلا عند ربطه في القسم العلوي من الطرف (في الفخذ أو العضد)، أما في القسم السفلي من الطرف فيكون غير فعال، وذلك

لمرور الشرايين بين العظام، مما يجعل إستخدامه في القسم السفلي عملاً خاطئاً ويؤدي إلى تلف الطرف أو فقدانه. ومن هذه الحالات:

١. حالات الأطراف المبتورة.
 ٢. تستخدم بصورة مؤقتة في حالات:
- الإصابات المتعددة النازفة حتى يتم إيقاف النزيف بالطرق الأخرى (الخيطة، التضميد بالشاش).
 - قد تستخدم بشكل مؤقت في حالات الإخلاء.

خطوات عمل الربطة الحنفية:

١. قم بالربط أعلى الطرف المصاب.
٢. قم بشد الرباط بواسطة جسم صلب ثم قم بتثبيتته.
٣. قم بتسجيل زمن الربط.
٤. يتم إرخاء ربطة الحنفية كل ١٥ دقيقة لمدة دقيقة - دقيقتين ثم يعاد الربط وتكرر الإجراء حتى وصول المصاب إلى المركز.



الكسور

fractures

التعريف:

(Defination):

هو عبارة عن إنقسام العظم الواحد إلى قسمين أو أكثر نتيجة تعرضه « لضربة مباشرة، صدمة قوية، طلق ناري، الخ...» مما يؤدي إلى تمزق الأنسجة والأوعية الدموية المحيطة به.



تصنيف الكسور:

(Kinds of Fractures):

بحسب إصابة الأنسجة المجاورة:

١. الكسر المفتوح (Open fractures):

هو الكسر المصاحب لجرح في الجلد ويسمى كذلك الكسر المركب.

قد يحدث نتيجة النهايات الحادة للعظام المكسورة، أو بسبب جسم خارجي يخترق الجلد كالطلق الناري أو شظايا الانفجارات.

هذا النوع من الكسور يكون عادة أخطر من الكسور المغلقة، لأنه يترافق مع إصابة في الأنسجة المجاورة.



٢. الكسر المغلق (Close fractures):

هو الذي لا يترافق مع جرح في الجلد ويسمى كذلك بالكسر البسيط.

قد يترافق مع إصابة أخرى في الأنسجة أو الأوعية الدموية.

إذا لم يتم التعامل مع الكسر بعناية، وتثبيتته بشكل جيد، أو نقل المصاب بصورة سيئة، فإنه من الممكن أن يتحول من كسر مغلق إلى كسر مفتوح.





٥. التشوه في إستقامة العضو المصاب.

٦. سماع الفرقة العظمية.

٧. إختلاف شكل مكان الكسر عند مقارنة بالطرف المقابل (في كسور الأطراف والترقوة).

انتبه!

من المحتمل حدوث الصدمة بسبب الألم والنزيف.

القاعدة العامة للإسعاف الكسور:

General rule for fracture aid

١. القيام بالإجراءات الأولية (A,B,C) والفحص السريع.
٢. في حال وجود جروح، طبق القاعدة العامة لإيقاف النزيف.
٣. أزل الملابس والأدوات من مكان الإصابة بلطف، ودون تحريك الجزء المصاب.
٤. التأكد من وجود النبض في الشرايين بعد موضع الإصابة، وفي حال غيابه يحرك الجزء المصاب بلطف (شد محوري) ثم إعادة الفحص.
٥. تثبيت الكسر حسب القاعدة العامة لتثبيت الجبائر: وضع جبيرة خلفية بحيث تلائم مكان الإصابة لتثبيت المفصل الأعلى والمفصل الأسفل للإصابة.
٦. أعط المصاب مسكن للألم.
٧. أعط المصاب إبرة ضد الكزاز (إن وجدت).
٨. أعط المصاب مضاد حيوي (إن وجد).
٩. نقل المصاب إلى أقرب مركز إسعافي.

بحسب حالة العظم المكسور:

١. كسر مائل:

(Oblique Fractures):

وهو أبسطها حيث يكون الجزء المكسور على شكل خط مائل.

٢. كسر متهتك (متهشم):

(Comminuted Fractures):

عندما يتكسر العظم إلى أجزاء صغيرة.

٣. كسر حلزوني:

(Spiral Fractures):

يكون الجزء المكسور على شكل خط حلزوني.



علامات الكسور العامة:

Signs and Symptoms of Fractures

١. الألم الشديد.
٢. التورم والانتفاخ.
٣. تغير لون الجلد (تقدم واحمرار أو إسوداد).
٤. صعوبة أو عدم القدرة على تحريك الطرف المكسور.

البنادق، العصي، ألواح خشبيه أو معدنية، وسادات، وغيرها. كما يمكن تثبيت الساق المكسورة بالساق السليمة.



كيفية استخدامها :

(How used):

1. ضع قطعة قطن أو قماش حول الطرف المصاب بشكل يمنع الملامسة المباشرة بين الجبيرة والجلد.
2. اختر جبيرة مناسبة من حيث طولها، وسماكتها وقوتها، ووزنها.
3. ثبت الجبيرة من المفصل الأول قبل الإصابة حتى المفصل الثاني بعد الإصابة.
4. ثبت الجبيرة بالأربطة الضاغطة، أو الثياب، أو أي وسيلة مناسبة أخرى.
5. شد الرباط على الجبيرة بحيث لا تكون مرتخية (راخية، تتحرك أو تنزلق) وبشكل غير ضاغط لكيلا يؤثر على حركة الدورة الدموية أو تسبب ألم للمصاب.
6. عند وضع الجبيرة على الساق أو الساعد، يجب ترك الأصابع مكشوفة، وفي حال تغير لون الأصابع إلى الأزرق، أو وجود تنميل وخدر (خضة) أو أصبحت باردة، فيجب تخفيف الشد فوراً على الجبيرة.

الجبائر المؤقتة

:(Temporary Splints)

التعريف (Defination):

عبارة عن مواد صلبة أو شبه صلبة تُستخدم بشكل مؤقت لتثبيت الكسور، وتدعيم العضو المكسور. وتستخدم في كسور الأطراف العليا والسفلى.

انتبه!!

في حالة وجود إصابة بالأنسجة والعضلات أو جروح في الطرف، ثبت الكسر بوضع الجبيرة تحت أو جنب العضو المكسور (وليس فوق الإصابة) ونفها برباط ضاغط بشكل عادي وغير مشدود.

الغرض من الجبائر المؤقتة:

Purposes of Temporary Splints :

1. تثبيت الإصابة والعظم ومنعه من التحرك. (لتجنب المضاعفات التي قد تؤثر على الأنسجة المجاورة).
2. عدم تدهور الإصابة.
3. تخفيف الألم.
4. التقليل من النزيف.
5. نقل المصاب.

أنواع الجبائر المؤقتة:

(Types of Temporary Splints):

1. بلاستيكية.
2. هوائية.
3. معدنية.
4. خشبية.
5. الجبائر المبتكرة: مثل أغصان الأشجار،



10

إصابات الأطراف

Limbs Injuries



١. العضلات (Muscles):

وفيها العضلات التي تعمل على قبض الساعد وبسطه.

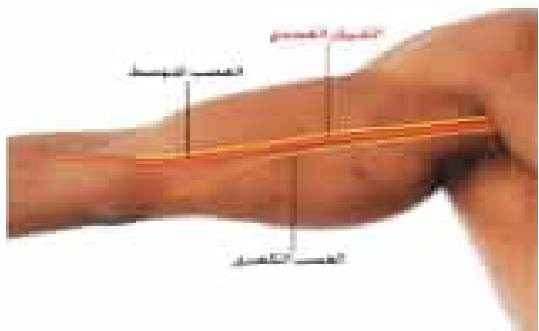
٢. الأوعية الدموية الرئيسية:

(Main Vascular):

ويمر منها الشريان العضدي والوريد العضدي.

٣. الأعصاب الرئيسية (Main Nerves):

ويمر منها العصب المتوسط والعصب الكعبري.



٤ جميع الأوعية الدموية وأعصاب الطرف العلوي تمر من الناحية الأمامية (الداخلية) للعضد.

علامات الإصابة:

(Signs of the injury):

١. النزيف يكون شديداً (في حال إصابة الشريان العضدي أو الوريد العضدي).
٢. فقدان الإحساس أو عدم القدرة على تحريك اليد (في حال إصابة العصب المتوسط أو العصب الكعبري).
٣. تمزق للعضلات.

تصنف إصابات الأطراف إلى:

(limbs injuries are classified)

١. إصابات مفتوحة (النزيف الخارجي): وتترافق مع جروح، بتر.. الخ.
٢. إصابات مغلقة (النزيف الداخلي): نتيجة ضربة مباشرة، هرس، تمزق داخلي، كسور.
٣. الكسور.

يمكن تقسيم الأطراف إلى:

The limbs can be divided into:

١. الأطراف العلوية: وتشمل: العضد، الساعد، اليد.
٢. الأطراف السفلية: وتشمل: الفخذ، الركبة، الساق، القدم.

الأطراف العلوية:

(Upper Limbs):

العضد:

(Arm):

يمكن تقسيم منطقة العضد إلى الناحية الأمامية والناحية الخلفية.

ناحية العضد الأمامية (الداخلية):

(The inner arm area):

هي الجهة التي تسير الإبط وما تحته إلى المرفق. وتحتوي على:

١. ألم شديد.
٢. فقدان الإحساس بالنبض في اليد المصابة. (في حال إصابة الشريان العضدي).
٣. ألم متوسط إلى شديد.
٤. ثلاثية الرؤوس.

الإجراء الإسعافي:

(Emergency measures):

١. قم بسحب أو نقل المصاب إلى مكان آمن.
٢. طبق مبدأ الـ A,B,C. والفحص السريع.
٣. طبق القاعدة العامة لإيقاف النزيف.
٤. في حال تمزق العضلات قم بالآتي:
 - ✗ حافظ على الأجزاء المتصلة بالجسد ولا تقم بقطع أي أنسجة مازالت متصلة بالجسم، وإن كان جزءاً صغيراً.
 - ✗ لملم الأطراف الممزقة، وثبتها بخياطة مؤقتة، أو برباط ضاغط في حال كان حجم العضلات الممزقة كبير.
 - ✗ في حال وجود طرف مبتور بشكل كامل، قم بحشو الفتحة بالشاش، وضع الجزء المبتور في كيس نايلون (بلاستيكي).
٥. طبق القاعدة العامة لإسعاف الكسور إن تطلب ذلك.
٦. ارسل المصاب إلى أقرب مركز إسعافي.

ملاحظات هامة:

- ✗ إن بقاء ولو جزء صغير من الأنسجة المتمزقة متصلاً بالجسم يساعد على مرور الدم إلى كامل الطرف الممزق، وذلك يحافظ على العضو من الموت.

- ✗ لا ينصح بشد الرباط بقوة في منطقة العضد كونه يؤثر على الدورة الدموية (ضغط مباشر على الشريان) إلا في حالات النزيف الشرياني.

١. ألم شديد.
٢. فقدان الإحساس بالنبض في اليد المصابة. (في حال إصابة الشريان العضدي).



ناحية العضد الخلفية (الخارجية):

External arm area)

وتحتوي:

١. العضلات (Muscles):

وفيهما عضلة واحدة، هي عضلة ثلاثية الرؤوس العضدية.

٢. الأوعية الدموية الرئيسية:

(Main Vascular) :

لا توجد أوعية دموية رئيسية في هذه الناحية.

٣. الأعصاب الرئيسية (Main Nerves):

ويمر منها العصب الكعبري.

علامات الإصابة:

(Signs of the injury):

١. النزيف يكون غير شديد، وذلك لعدم مرور أوعية دموية رئيسية.
٢. تمزق للعضلات، ويكون التمزق فيها بشكل كبير وذلك لكبر حجم العضلة

الإجراء الإسعافي العام:

(Emergency measures):

١. قم بسحب أو نقل المصاب إلى مكان آمن.
٢. طبق مبدأ الـ A,B,C. والفحص السريع.
٣. طبق القاعدة العامة لإيقاف النزيف إن تطلب ذلك.
٤. أعط المصاب مسكن للألم.
٥. طبق القاعدة العامة لإسعاف الكسور.
٦. **ثبت الجبيرة على النحو التالي:**
 - ✗ ضع جبيرة خلفية وأمامية بحيث تلائم مكان الإصابة، لتثبيت المفصل الأعلى والمفصل الأسفل للإصابة.
 - ✗ لف الذراع المصابة، بحيث تصبح راحة اليد على الصدر.
 - ✗ علق الذراع برباط ضاغط أو شال بلفه حول الرقبة.
 - ✗ ثبت الذراع نحو الجسم باستخدام رباط عريض.



٧. في حال عدم وجود جبيرة:

- ✗ لف الذراع المصابة، بحيث تصبح راحة اليد على الصدر.
- ✗ ثبت الذراع برباط ضاغط أو شال حول الرقبة.
- ✗ ثبت الذراع نحو الجسم باستخدام رباط عريض.

٨. أرسل المصاب إلى أقرب مركز إسعافي.

كسور العضد (Arm Fracture):



العلامات والأعراض:

(signs and symptoms):

١. الألم الشديد.
٢. التورم والانتفاخ.
٣. تكون اليد متدلية، وتفقد توازنها.
٤. تغير لون الجلد (تكدم واحمرار أو إسوداد).
٥. صعوبة أو عدم القدرة على تحريك الطرف المكسور.
٦. التشوه باستقامة العضو المصاب.
٧. سماع فرقعة عظمية.
٨. احتمال حصول نقص في التروية الدموية للطرف.
٩. احتمال حدوث الصدمة بسبب الألم والنزيف.



ناحية الساعد الخلفية:

(Posterior forearm area):

١. العضلات (Muscles):

توجد فيها عضلات وأوتار باسطة الكف.

٢. الأوعية الدموية الرئيسية:

لا يمر في هذه الناحية أوعية دموية رئيسية.

٣. الأعصاب الرئيسية:

لا يوجد فيها أعصاب رئيسية.

علامات الإصابة:

(Signs of the injury):

١. النزيف يكون غير شديد، وذلك لعدم مرور أوعية دموية رئيسية.
٢. تمزق للعضلات.
٣. ألم شديد.



الساعد (Forearm):

ويمكن تقسيم هذه المنطقة إلى ناحيتين:

١. الناحية الأمامية.

٢. الناحية الخلفية.

ناحية الساعد الأمامية:

(Anterior forearm area):

التشريح (Anatomy):

١. العضلات (Muscles):

توجد فيها عضلات وأوتار قابضة الكف.

٢. الأوعية الدموية الرئيسية:

(Main Vascular):

- الشرايين: وينقسم فيها الشريان العضدي إلى الشريان الكعبري والشريان الزندي، حيث يمران بين عظمي الساعد.
- الأوردة: ويسير في هذه الناحية الوريد القاعدي والوريد الرأسي.

٣. الأعصاب الرئيسية (Main Nerves):

يمر فيها العصب المتوسط والعصب الكعبري والعصب الزندي.

علامات الإصابة:

(Signs of the injury):

١. النزيف يكون شديد وذلك في حال إصابة أحد الشرايين (الكعبري أو الزندي).
٢. فقدان الإحساس أو عدم القدرة على تحريك اليد.
٣. تمزق للعضلات.
٤. ألم شديد.
٥. فقدان الإحساس بالنقبض في اليد المصابة، (في حال إصابة أحد الشرايين).

تطلب ذلك.

٧. أرسل المصاب إلى أقرب مركز إسعافي.

كسر عظمي الساعد:

(Broken bones of the forearm):

العلامات والأعراض:

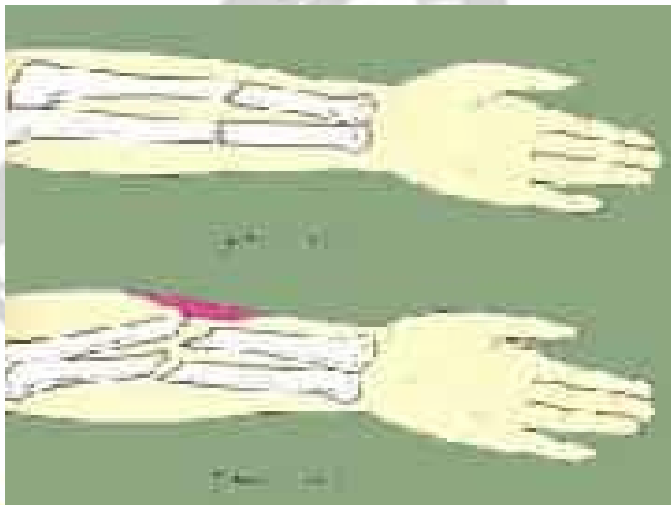
(signs and symptoms):

١. الألم الشديد.
٢. التورم والانتفاخ.
٣. عدم القدرة على تحريك أو تدوير الكف.
٤. تغير لون الجلد (تقدم وإحمرار أو إسوداد).
٥. صعوبة أو عدم القدرة على تحريك الطرف المكسور.
٦. التشوه في إستقامة العضو المصاب.
٧. سماع الفرقعة العظمية.
٨. إحتمال حصول نقص في التروية الدموية للطرف.
٩. إحتمال حدوث الصدمة بسبب الألم والنزيف.

الإجراء الإسعافي:

(Emergency measures):

١. قم بسحب أو نقل المصاب إلى مكان آمن.
٢. طبق مبدأ الـ A,B,C. والفحص السريع.
٣. طبق القاعدة العامة لإيقاف النزيف.
٤. إن تطلب الأمر، فلا بأس في شد الرباط في هذه المنطقة لأن الشرايين بعيدة، بين العظمتين وأما في حال كان هناك كسر، فيخفف الشد.
٥. في حال تمزق العضلات قم بالآتي:
- حافظ على الأجزاء المتصلة بالجسد ولا تقم بقطع أي أنسجة مازالت متصلة بالجسم، وإن كان جزءاً صغيراً.
- لملم الأطراف الممزقة، وثبتها بخياطة مؤقتة، أو برباط ضاغط في حال كان حجم العضلات الممزقة كبير.
- في حال وجود طرف مبتور بشكل كامل، قم بحشو الفتحة بالشاش، وضع الجزء المبتور في كيس نايلون (بلاستيكي).
٦. طبق القاعدة العامة لإسعاف الكسور إن

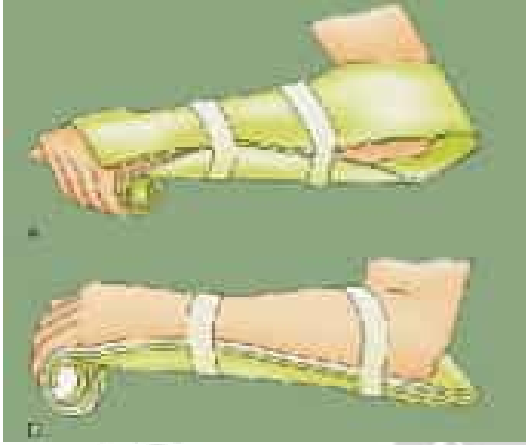


الإجراء الإسعافي:

(Emergency measures):

١. إسحب أو انقل المصاب إلى مكان آمن.
٢. طبق مبدأ الـ A,B,C. والفحص السريع.
٣. طبق القاعدة العامة لإيقاف النزيف إن تطلب ذلك.
٤. أعط المصاب مسكن للألام.
٥. طبق القاعدة العامة لإسعاف الكسور.

٦. ثبت الجبيرة على النحو التالي:
 ✗ لف الذراع المصابة، بحيث تصبح الذراع وراحة اليد على الصدر.
 ✗ ضع جبيرة خلفية بحيث تمتد من قاعدة الأصابع حتى مستوى أعلى من المرفق.
 ✗ ثبت الجبيرة على الساعد بالرباط الضاغط.
 ✗ علق الذراع برباط ضاغط أو شال بلفه حول الرقبة.
٧. أرسل المصاب إلى أقرب مركز إسعافي.





10

٤. ثبت الجبيرة على النحو التالي:
 ✎ ثبت الإصبع المصابة إما بجبيرة على طول الإصبع، أو بالإصبع المجاور السليم برباط غير مشدود.
 ✎ في حال كسور في أكثر من إصبع تثبت اليد بجبيرة عريضة فوق الأصابع وذلك بعد لف الأصابع المكسورة كل على حدة.
 ٥. ارسل المصاب إلى أقرب مركز إسعافي.



كسور أصابع اليد:

(Fracture of the Fingers of the hand):

العلامات والأعراض:

(signs and symptoms):

١. الألم الشديد.
٢. التورم والانتفاخ.
٣. تغير لون الجلد (تكدم وإحمرار أو إسوداد).
٤. صعوبة أو عدم القدرة على تحريك الطرف المكسور.
٥. التشوه في إستقامة العضو المصاب.
٦. سماع الفرقعة العظمية.



الإجراء الإسعافي:

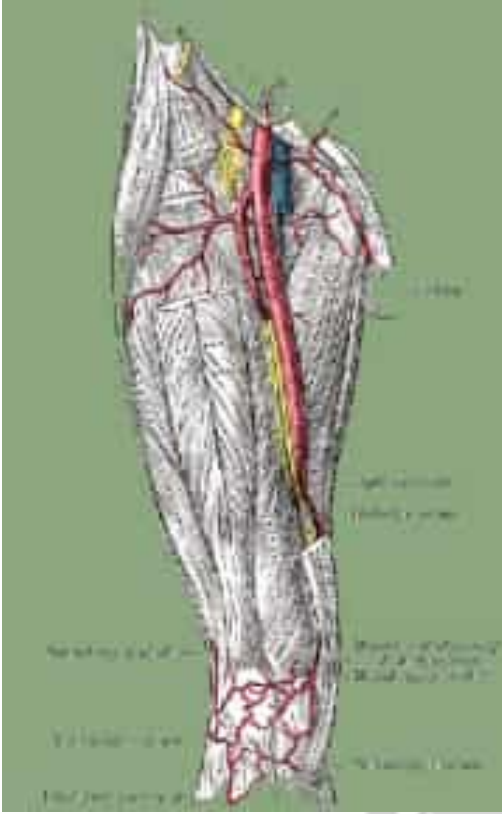
(Emergency measures) :

١. طبق القاعدة العامة لإيقاف النزيف إن تطلب ذلك.
٢. أعط المصاب مسكن للألام.
٣. طبق القاعدة العامة لإسعاف الكسور.



٣. الأعصاب الرئيسية (Main Nerves):

- يمر في هذه الناحية العصب الفخذي.



علامات الإصابة:

(Signs of the injury):

١. تمزق للعضلات.
٢. فقدان الإحساس أو عدم القدرة على تحريك الساق والقدم.
٣. النزيف يكون شديداً، (في حال إصابة الشريان الفخذي).
٤. ألم شديد.
٥. فقدان الإحساس بالنبض في الساق المصابة، (في حال إصابة الشريان الفخذي).

الأطراف السفلية:

(Lower Limbs)

الفخذ:

(Femur):

- ✗ الفخذ هو الجزء الذي يصل بين جذع الإنسان وركبته.
- ✗ فيه عدد كبير من العضلات حيث تعتبر أكبر منطقة عضليه.
- ✗ يوجد بالفخذ عظمة واحدة وهي عظمة الفخذ، وهي أكبر وأقوى عظمة في الهيكل العظمي للإنسان.
- ✗ تنقسم منطقة الفخذ إلى الناحية الأمامية (الداخلية) وناحية الإلية (الورك) والناحية الخلفية (الخارجية).
- ✗ في حال الإصابة في منطقة الفخذ، قد يصاحب ذلك نزيف داخلي (بين العضلات)، حيث بالإمكان أن تمتلئ بأكثر من ٢ لتر دم.

ناحية الفخذ الأمامية (الداخلية):

(Anterior Femur area):

التشريح:

(Anatomy):

١. العضلات (Muscles):

- توجد فيها عضلات رافعة الركبة، ومثبتة الورك.

٢. الأوعية الدموية الرئيسية:

(Main Vascular):

- يمر في هذه الناحية الشريان الفخذي والوريد الفخذي.



فتحة الإصابة صغيرة، ولذلك يتجه نزيف الشريان بين العضلات، فلا ترى أثر النزيف خارجياً، وتلاحظ تورم وتصلب وقساوة الفخذ وإزرقاقها، خصوصاً المنطقة الداخلية للفخذ.

الناحية الإلية (الورك):

(Hip Area):

التشريح (Anatomy):

١. العضلات (Muscles):

- توجد فيها العضلات المحركة والمثبتة للورك.

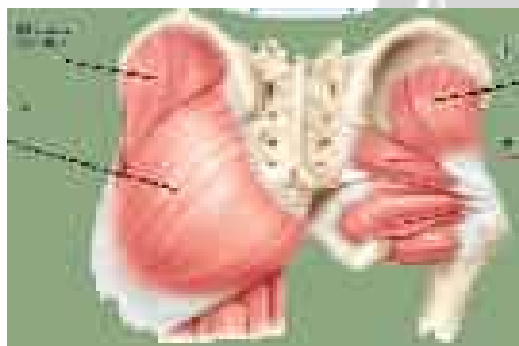
٢. الأوعية الدموية الرئيسية:

(Main Vascular):

- لا توجد أوعية دموية رئيسية في هذه الناحية.

٣. الأعصاب الرئيسية (Main Nerves):

- يمر في هذه الناحية العصب الوركي.



١. علامات إصابة الشريان الفخذي:

- ✗ نزيف شديد ومتواصل مع صعوبة توقفه لآلية الربط العادية.
- ✗ لون الدم أحمر فاتح.
- ✗ علامات الصدمة (إصفرار، تنفس سريع، نبض سريع، دوخة ودوار، هلوسة، وقد يفقد الوعي).
- ✗ في بعض الإصابات التي تكون فيها

الإسعاف الحربي



الإجراء الإسعافي:

(Emergency measures):

١. اسحب أو انقل المصاب إلى مكان آمن.
٢. طبق مبدأ الـ A,B,C. والفحص السريع.
٣. طبق القاعدة العامة لإيقاف النزيف.
٤. في حال تمزق العضلات قم بالآتي:
 - حافظ على الأجزاء المتصلة بالجسد ولا تقطع أو تفصل أي أنسجة مازالت متصلة بالجسم، وإن كان جزءاً صغيراً.
 - لملم الأطراف الممزقة، وثبتها بالخياطة المؤقتة، أو بالرباط الضاغط في حال كان حجم العضلات الممزقة كبير.
 - في حال وجود طرف مبتور بشكل كامل، قم بحشو الفتحة بالشاش، وضع الجزء المبتور في كيس نايلون (بلاستيكي).
٥. طبق القاعدة العامة لإسعاف الكسور إن تطلب ذلك.
٦. أرسل المصاب إلى أقرب مركز إسعافي.

ناحية الفخذ الخلفية (الخارجية):

(Posterior Femur area):

التشريح (Anatomy):

١. العضلات (Muscles):

توجد فيها عضلات خافضة الركبة.

٢. الأوعية الدموية الرئيسية:

(Main Vascular):

توجد أوعية دموية غير رئيسية (فرعية) فقط.

٣. الأعصاب الرئيسية:

(Main Nerves):

يمر في هذه الناحية العصب الوركي والذي ينزل من منطقة الإلية (الورك).

علامات الإصابة: (الناحية الخلفية وناحية الإلية):

١. النزيف يكون غير شديد، وذلك لعدم مرور أوعية دموية رئيسية.
٢. تمزق للعضلات، ويكون التمزق فيها بشكل كبير وذلك لكبر حجم وعدد العضلات فيها.
٣. ألم شديد.





10

٥. الحوض إلى أسفل الركبة.
في حال عدم وجود جبيرة:

- ✎ إربط الرجل المكسورة مع الأخرى من منطقة الركبة.
- ✎ يكون المصاب نائماً على جنب، بحيث تكون الرجل المكسورة للأعلى، مع ثني الركبتين قليلاً وينقل بنفس الوضعية.
- ٦. أرسل المصاب إلى أقرب مركز إسعافي.

الركبة:

(Patella):

- هي ذلك النتوء الكبير في وسط رجل الإنسان، والذي يفصل بين الساق والخذ.
- تتكون من إلتقاء ثلاث عظام، عظمة الفخذ والقصبة والصابونة (القرش)، وهي أكبر مفصل في الجسم.
- يمر الشريان المابضي من الجهة الخلفية للركبة.

علامات الإصابة:

(Signs of the injury):

- ١. النزيف يكون شديد في حال إصابة الشريان المابضي، ويتجه ضغطه إلى خارج الرجل، أو إلى داخل عضلة الساق الخلفية، ويمكن معرفة ذلك بتصلب العضلة وقساوتها.
- ٢. فقدان الإحساس أو عدم القدرة على تحريك الساق والقدم.
- ٣. تمزق للأوتار والأربطة المحيطة بالركبة.
- ٤. ألم شديد.
- ٥. فقدان الإحساس بالنبض في القدم المصابة (في حال إصابة الشريان المابضي).

كسر الفخذ:

(Femur Fracture):

يتألف الفخذ من عظمة طويلة واحدة تمتد من الحوض إلى الركبة، وهذا العظم محاط بالعضلات من كل إتجاه.

علامات كسر الفخذ:

(Signs of Femur Fracture):

- ١. ألم شديد يزداد عند تحريك الطرف.
- ٢. يفقد السيطرة على الجزء أسفل الكسر من الفخذ.
- ٣. يأخذ الفخذ وضعية مشوهة، يكون الطرف السفلي بوضعية التباعد الخارجي «الإبهام يتجه نحو الخارج».
- ٤. تلاحظ قصر الطرف المصاب مقارنة مع السليم.

الإجراء الإسعافي:

(Emergency measures):

- ١. طبق القاعدة العامة لإيقاف النزيف إن تطلب ذلك.
- ٢. أعط المصاب مسكن للألام.
- ٣. طبق القاعدة العامة لإسعاف الكسور.
- ٤. ثبت الجبيرة على النحو التالي:
- ✎ ضع جبيرة في الجهة الداخلية للفخذ، بحيث تمتد من جذر الفخذ إلى الكاحل الداخلي.
- ✎ ضع جبيرة في الجهة الخارجية، بحيث تمتد من منطقة تحت الإبط (الزغن) إلى الكاحل الخارجي، وينقل بنفس الوضعية.
- ✎ أو ضع جبيرة واحدة خلفية تمتد من

١. النزيف يكون شديد (في حال أصيب الشريان الضنبوي الأمامي).
٢. فقدان الإحساس أو عدم القدرة على تحريك القدم.
٣. تمزق للعضلات.
٤. ألم شديد.
٥. فقدان الإحساس بالنبض في القدم المصابة في حال إصابة الشريان.



ناحية الساق الخلفية:

(Posterior Leg area):

التشريح:

(Anatomy):

١. العضلات (Muscles): تتوزع عضلات هذه الناحية في ثلاث طبقات وفيها عضلات الخافضة ومثبتة القدم.
٢. الأوعية الدموية الرئيسية: (Main Vascular): يسير بين العظمتين الشريان الضنبوي الخلفي.
٣. الأعصاب الرئيسية (Main Nerves): ويسير بين العظمتين العصب الضنبوي.

الإجراء الإسعافي:

(Emergency measures):

١. طبق القاعدة العامة لإيقاف النزيف إن تطلب ذلك.
٢. أعط المصاب مسكن للألام.
٣. طبق القاعدة العامة لإسعاف الكسور.
٤. ثبت الجبيرة على النحو التالي:
 ٤.1 ضع جبيرة خشبية تحت الركبة، وتمتد من أعلى الفخذ حتى القدم.
 ٤.2 ضع وسادة تحت الركبة.
٥. أرسل المصاب إلى أقرب مركز إسعافي.
٦. وضعية المصاب أثناء النقل:
 يكون المصاب نائماً على جنب، بحيث تكون الركبة المكسورة فوق السليمة.

الساق (Leg):

وتنقسم منطقة الساق إلى الناحية الأمامية والناحية الخلفية.

الناحية الأمامية للساق:

(Anterior Leg area):

التشريح (Anatomy):

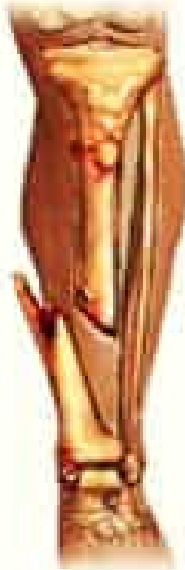
١. العضلات (Muscles): في هذه الناحية العضلات الرافعة للأصابع ومثبتة القدم.
٢. الأوعية الدموية الرئيسية: (Main Vascular): ويمر فيها أحد أفرع الشريان الضنبوي الأمامي.
٣. الأعصاب الرئيسية (Main Nerves): ويمر فيها أعصاب رافعة القدم والأصابع.

علامات الإصابة:

(Signs of the injury):

كسور عظمي الساق (Bone fractures of the leg):

يتألف الساق من عظمتين طويلين يرتبطان مع بعضها بأربطة ومفاصل عند النهايات العلوية والسفلية.



العلامات والأعراض:

(signs and symptoms):

١. الألم الشديد.
٢. التورم والانتفاخ.
٣. تغير لون الجلد (تقدم وإحمرار أو إسوداد).
٤. صعوبة أو عدم القدرة على تحريك الطرف المكسور.
٥. التشوه في إستقامة العضو المصاب في حال كسر العظمين معاً، وميول القدم إلى الخارج.
٦. سماع الفرقة العظمية.
٧. احتمال حصول نقص في التروية الدموية للطرف.
٨. احتمال حدوث الصدمة بسبب الألم والنزيف.

علامات الإصابة:

(Signs of the injury):

١. النزيف يكون شديداً، (في حال إصابة الشريان الضنوبي).
٢. فقدان الإحساس أو عدم القدرة على تحريك القدم (في حال إصابة العصب الضنوبي).
٣. تمزق للعضلات.
٤. ألم شديد.
٥. فقدان الإحساس بالنبض في القدم المصابة (في حال أصيب الشريان الضنوبي).

الإجراء الإسعافي:

(Emergency measures)

١. إسحب أو انقل المصاب إلى مكان آمنة.
٢. طبق مبدأ الـ A, B, C. والفحص السريع.
٣. طبق القاعدة العامة لإيقاف النزيف.
٤. لا بأس من شد الرباط في الساق، كون الشرايين تمر بين عظمتي الساق.
٥. في حال تمزق العضلات قم بالآتي:
- حافظ على الأجزاء المتصلة بالجسد ولا تقطع أو تفصل أي أنسجة مازالت متصلة بالجسم، وإن كان جزءاً صغيراً.
- لملم الأطراف الممزقة، وثبتها بالخياطة المؤقتة، أو بالرباط الضاغط في حال كان حجم العضلات الممزقة كبير.
- في حال وجود طرف مبتور بشكل كامل، قم بحشو الفتحة بالشاش، وضع الجزء المبتور في كيس نايلون (بلاستيكي).
٦. طبق القاعدة العامة لإسعاف الكسور إن تطلب ذلك.
٧. أرسل المصاب إلى أقرب مركز إسعافي.

الإجراء الإسعافي:

(Emergency measures)

١. طبق القاعدة العامة لإيقاف النزيف إن تطلب ذلك.
٢. أعط المصاب مسكن للألام.
٣. طبق القاعدة العامة لإسعاف الكسور.

٤. ثبت الجبيرة على النحو التالي:
- تمتد من منتصف الفخذ إلى أسفل القدم.
- يمكن وضع وسادة بين الساقين وثبتت الساق المصابة بالساق السليمة.
٥. أرسل المصاب إلى أقرب مركز إسعافي.





أعراض التواء المفاصل :
انتفاخ وتورم المنطقة المصابة
الآلام عند اللمس أو عند الحركة
تغير لون الجلد



الإجراء الإسعافي:

(Emergency measures)

١. ضع جبيرة لتثبيت المفصل المصاب، أو أربطه رباط مطاطي مشدوداً بشكل معتدل.
٢. ضع الأربطة المفصالية بوضعية الراحة، وعلى المصاب تجنب استعماله.
٣. تثبت المفاصل الكبيرة مثل الركبة، لمدة تتراوح ما بين أسبوع إلى أسبوعين، بحسب التمزق.
٤. وضع كمادات ماء مثلج (إن أمكن) على المفصل لمدة ٥ دقائق فقط، وذلك في اليوم الأول.
٥. أعط المصاب مسكن للألم.

الالتواءات (Sprains):

- هو خروج الأوجه المفصالية من مرابطها، ثم عودتها إلى حالتها الأولى، مما يؤدي إلى إصابة ألياف المفصل بالتمزق الجزئي، وتمزق الأوعية الدموية المفصالية، وهذا يؤدي إلى انصباب الدم في مكان الإصابة.

- يحدث غالباً في مفاصل الكاحل، المعصم، الركبة، الأصابع.



العلامات والأعراض:

(signs and symptoms):

١. عدم القدرة على تحريك المفصل المصاب بسبب الألم الشديد.
٢. تورم المفصل، مع ظهور كدمات سوداء أو حمراء قرمزية.

الإسعاف الحربي



الإسعاف الحربي

١. تلاحظ إختلاف شكل ومظهر المفصل المخلوع عن السليم.
٢. عدم القدرة على تحريك المفصل.
٣. ألم شديد



الإجراء الإسعافي:

(Emergency measures):

١. تخفيف الثياب الضيقة عن مكان الإصابة.
٢. جعل المفصل المخلوع في أفضل وضعية بالنسبة للمصاب.
٣. تثبيت المفصل المصاب بجبيرة ورباط ضاغط مع تجنب الشد قوي.
٤. إذا كان الخلع مترافقاً بجروح أو كسور، فإنه يتوجب إسعاف الجروح والتعامل مع الخلع على أنه كسر.
٥. لا تحاول رد الخلع، لأن الرد بغير اليد الخبيرة قد يؤدي إلى زيادة الإصابة.
٦. أعط المصاب مسكن للألام

الخلع (Dislocation):

- الخلع هو خروج وإبتعاد الأوجه المفصليّة عن مكانها، وعدم عودتها إلى وضعها السابق، مما يؤدي إلى تمزق الألياف العضلية والأربطة والمحفظة المفصليّة، وقد تتمزق العضلات التي تحيط بالمفصل أيضاً.
- أكثر المفاصل إصابة هي الكتف، الحوض، الأصابع والفك السفلي.



الأسباب:

(Causes):

١. المبالغة في حركة المفصل.
٢. تلقى المفصل صدمة سقوط وغيرها من الأسباب.

العلامات والأعراض:

(signs and symptoms):



إصابات الرأس

Head injuries

الإثنين قد يأتي من الجمجمة.

٥. الفم (Mouth):

- تحقق مرة أخرى من التنفس (عمقه، سهلاً أم صعباً، أم مصحوباً بصوت).
- لاحظ وجود رائحة في الفم أو وجود مواد غريبة كالطرش والدم والأطعمة والقنات وأطقم الأسنان، والتي قد تسبب اختناق.
- إفحص الشفتين ولاحظ تغير لونهما، فزرقتهما يدل على اختناق.
- فتش عن آثار حروق بالفم من المواد الكيميائية.

٦. الأذنين (Ears):

- إبحث عن الأجسام الغريبة وأثار الدم والسائل الدماغي، الذي قد يدل على كسر في الجمجمة، وتكلم في أذنه لاختبار سمعه.
- ٧. قم بتقييم درجة وعي المصاب.

الإجراءات العامة لإصابات الرأس:

(General procedures for head injuries):

- ١. طبق مبدأ الـ A, B, C. والفحص السريع.
- ٢. حافظ على ثبات الرأس والعنق، واستخدم طوق الرقبة، أو جبيرة مبتكرة لتثبيت الرقبة.
- ٣. ضع المصاب على وضعية الأمان الجانبي مع الحفاظ على ثبات الرأس والعنق.
- ٤. مراقبة الوعي وتقييم درجة الوعي كل ١٥ دقيقة.
- ٥. أسعف الإصابات النافذة (جروح) بوضع

العلامات والأعراض العامة :

(General signs and symptoms):

- ١. جروح في فروة الرأس.
- ٢. اضطراب الوعي أو غيابه.
- ٣. صداع شديد، غثيان وطرش.
- ٤. الشعور بعدم الراحة، الإرتباك، عدم التركيز.
- ٥. عدم تساوي الحدقتين، أو عدم تجاوب الحدقتين مع الضوء.
- ٦. سيلان دم أو سائل من الفم أو الأذن أو الأنف.
- ٧. تكدم (إسوداد) خلف الأذن، تحت وحول العينين مع عدم وجود إصابة على الأذن أو العينين.

التقييم وفحص الرأس:

Evaluation and head examination

عند القيام بفحص الرأس يجب ملاحظة الأمور التالية:

١. الجمجمة (Skull):

مرر يديك بلطف فوق فروة الرأس بحثاً عن أي نزيف أو تورم أو كسور.

٢. الوجه (Face):

انظر إلى لون المصاب فقد يكون شاحباً أو مائلاً للزرقة.

٣. العينان (Eyes):

افحص الحدقتين، ولاحظ إن كانت سعتهما واحدة، وافحص بياض العين للبحث عن وجود بقع دموية فيه.

٤. الأنف (Nose):

إبحث عن آثار للدم أو سائل أو مزيج من



10

على الشكل التالي:

١. مراقبة الوعي.
٢. يجب إيقاظ المصاب كل ساعة والتأكد من أن إستيقاظه طبيعي.
٣. راحة كامله لمدة ٢٤ ساعة قدر الإمكان.
٤. المسكن الوحيد المسموح به خلال ٢٤ ساعة الأولى هو paracetamol (باراسيتامول).



١. ضماد خارجي من الشاش المعقم.
٢. أرسل المصاب إلى أقرب مركز إسعافي.

تنبيه

لا تعطي المصاب الطعام أو الشراب لأي سبب كان.

الجمجمة (Skull):

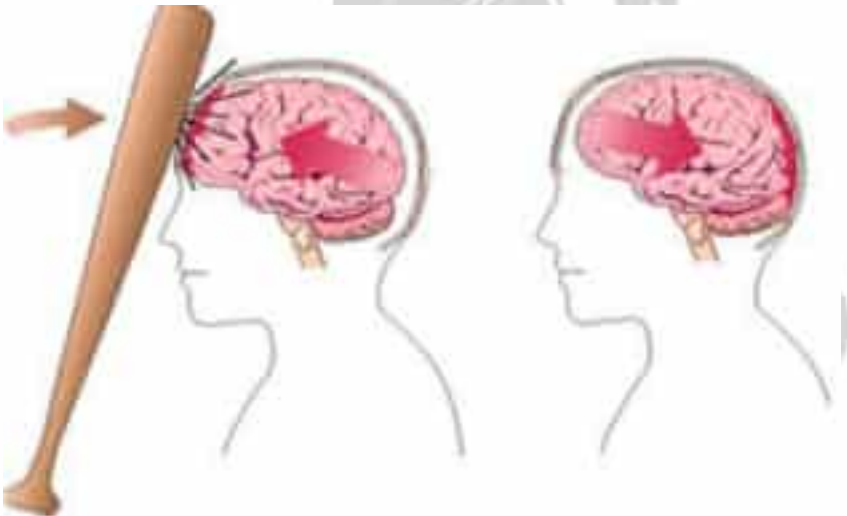
وتشمل فروة الرأس وعظم القحف.

فروة الرأس:

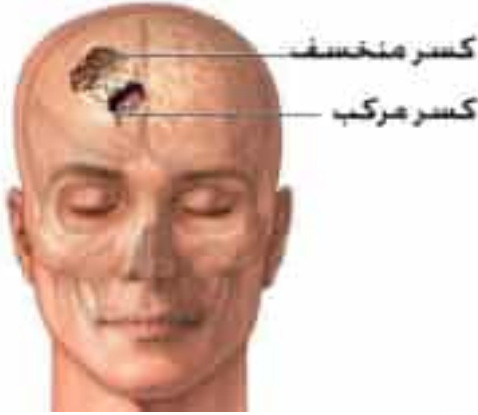
(Scalp):

التعرض لضربة في الرأس (لا يوجد أي جروح أو نزيف):

بالرغم من عدم ظهور دليل على وجود مضاعفات خطره من جراء حادث ألم بالمصاب، إلا أنه من الممكن أن تظهر أعراض غير موجودة في لحظة الحادث خلال ال ٢٤ ساعة الأولى، لأجل ذلك لابد من مراقبة المصاب من قبل المسعف



صعوبته).



٤ النزيف من فروة الرأس:

١. قد يكون النزيف غزيراً نظراً للتروية الدموية الغزيرة في فروة الرأس.
٢. طبق القاعدة العامة لإيقاف النزيف.
٣. لا تدفع الشظايا لداخل الدماغ عند عمل الرباط.



الإجراء الإسعافي:

(Emergency measures):

- ٤ طبق مبدأ الـ A,B,C. والفحص السريع.
- ٤ في حال كان المصاب فاقد للوعي قم بتركيب (مجرى هوائي) عبر الخطوات التالية:

- يمكن تقدير القياس المطلوب باختيار مسلك هوائي بطول مساو للمسافة بين الأسنان القاطعة وزاوية الفك السفلي، (كما في الصورة)، وأكثر المقاسات استخداماً هي ٣ للمتوسطي الحجم و٤ للكبار.



عظام القحف (Cranium bones):

العلامات والأعراض :

(signs and symptoms):

- تلاحظ اختلاف قوام العظم أو فقدان صلابة عظام القحف عند اللمس (هبوط أو انخساف).
- ظهور علامات إختلال وظائف الدماغ (فقدان الوعي، شلل نصفي، شلل جزئي، عدم القدرة على الكلام أو

٢. إصابات سطحية (جروح في العين أو الجفن).



- ✚ ضمد العين بشاش ورباط ضاغط.
- ✚ أنقل المصاب إلى أقرب مركز إسعافي.
- ✚ ضع المصاب في وضعية نصف جالس، ويمنع من الركوع والسجود في الصلاة، وكذلك الجري والقفز.



الأنف (Nose):

الإجراء الإسعافي للإصابات الأنف (الرعاف):

(Emergency measures):

- وضع المصاب بوضعية جلوس مع الانحناء إلى الأمام قليلاً.
- أطلب من المصاب أن يتنفس من فمه وامنعه من التمخيط.
- إضغط فوق الأنف لمدة ١٠ دقائق.
- في حال عدم توقف النزيف، أرسل المصاب إلى أقرب مركز إسعافي.

أدخل الأنبوب بشكل معاكس لشكل الفم وذلك لتفادي اللسان.

- اقلب الأنبوب حتى يصبح رأسه متجه للأسفل، ثم ثبته بالشاش.

- ✚ قم بمليء مكان الإصابة بالشاش المعقم بهدف الإمتصاص.
- ✚ لف الرأس برباط ضاغط، ابدأ من الأسفل والخلف، إلى الأعلى والأمام والعكس، لغرض تثبيت العظام والذي يخشى تفككها عند النقل.
- ✚ حافظ على ثبات الرأس والعنق، وإستخدم مثبت الرقبة.
- ✚ ضع المصاب على جانبه بوضعية الأمان الجانبي مع الحفاظ على ثبات الرأس والعنق.
- ✚ مراقبة الوعي وتقييم درجة الوعي كل ١٥ دقيقة.
- ✚ أرسل المصاب إلى أقرب مركز إسعافي.

العينان (Eyes):

الإجراء الإسعافي:

(Emergency measures)

١. إصابات متغلطة (دخول جسم غريب مثل شظية، حجار متكسرة، ..).
١. غطي العين بحيث لا تشكل ضغط على العين حتى لا تزيد الإصابة سوءاً.
٢. يستحسن تغطية العين الأخرى الغير متضرره للحيلولة دون حركة العين المتجانسة.
٣. أرسل المصاب إلى أقرب مركز إسعافي.

علامات كسور الفك السفلي:

Signs of fractures of the mandible:

١. إنخلاع بعض الأسنان، وتشوه أو انعدام صف الأسنان.
٢. صعوبة التكلم.
٣. وجود لعاب ممزوج بالدم.
٤. صعوبة المضغ والبلع.
٥. صعوبة التنفس.
٦. الألم.

الإجراء الإسعافي لكسور الفك السفلي:

(Emergency measures of fractures of the mandible):

١. ضع رباط تحت الذقن وأربطه أعلى الرأس، ثم لفه على جبهة المصاب لتثبيتته.
٢. عند نقل المصاب يجب أن يكون منحنيًا إلى الأمام أو في وضعية الأمان الجانبي، تفادياً لنزول الدم والسوائل للمجاري التنفسية.



الأنف (Nose):

الإجراء الإسعافي لحالات النزيف من الأنف:

(Emergency measures):

- ✗ لا تسد الأنف أبداً.
- ✗ اترك الدم يسيل إلى الخارج، بجعل المصاب يتمدد على جانب الأنف المصابة.
- ✗ ضع شاش معقم ماص أو نظيف فوق الأنف من الخارج، لإمتصاص الدم.
- ✗ في حال لم يتوقف النزيف، أرسل المصاب إلى أقرب مركز إسعافي.

الفم (Mouth):



إصابات الصدر Chest Injuries

الإسترواح المفتوح (النافذ) والإسترواح المغلق (الضاغط).



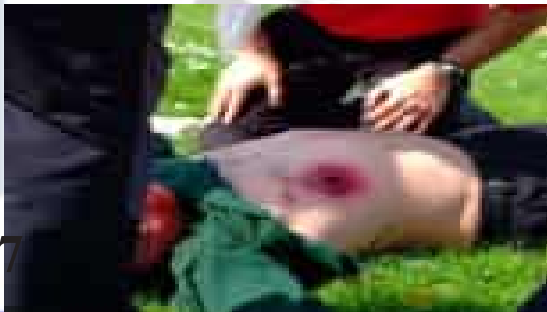
موجة الضغط الناجم عن الانفجار:

قد تؤدي إلى إصابة الرئتين والأوعية الدموية الخاصة بالرئة والقلب، فتسبب نزفا بين القفص الصدري والرئة، فيضغط الدم على الرئة مما يؤدي إلى عدم القدرة على التنفس.

الإسترواح المفتوح (النافذ):

Simple Pneumothorax(open)

ينتج عن جرح نافذ في الصدر، فيدخل الهواء من فتحة جدار الصدر إلى الفضاء البلوري بالإضافة إلى دخوله عن طريق الأنف أو الفم (يدخل الهواء ويخرج من الجرح النافذ أما إذا دخل الهواء ولم يخرج فيسمى بالإسترواح المضغوط حيث يعمل الغشاء البلوري عمل الصمام..



أسباب إصابات الصدر:

(Causes for Chest Injuries):

- ✍ الجروح النافذة: بسبب الأعيرة النارية والشظايا أو الطعن بألة حادة...الخ.
- ✍ الجروح المغلقة: تحدث نتيجة موجة الضغط الناجم عن انفجار، أو حوادث السير، أو السقوط، أو ضربه مباشرة على الصدر.



أنواع إصابات الصدر:

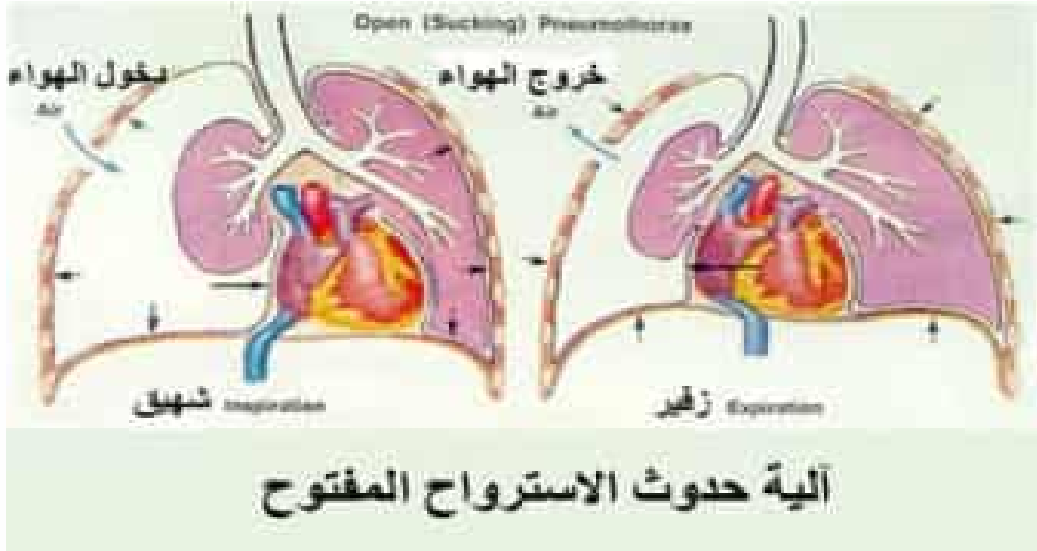
(Chest Injuries):

- ويمكن تقسيمها على النحو التالي:
- ١. إسترواح الصدر: وهو نوعان (المفتوح والمغلق).
- ٢. كسور الأضلاع (الصدر المَوْاج).

إسترواح الصدر:

(Pneumothorax):

هو مصطلح يطلق عندما يتجمع فيها الهواء بين الرئة والغشاء البلوري الذي يبطنها، ويحدث عندما يتسرب الهواء إلى المسافة التي توجد بين الرئتين وجدار الصدر، مسببا حدوث ضغط على الرئتين. وهو نوعان



٤. ألم في الصدر أثناء التنفس.
٥. خفوت أو إنعدام أصوات التنفس في الجانب المصاب.
٦. عدم ارتفاع الصدر بشكل متساوي أثناء التنفس.
٧. إمكانية وجود كسور في الأضلاع.
٨. وجود جرح يخرج منه الهواء عملية التنفس (الاسترواح المفتوح).
٩. إنحراف الرغامى باتجاه الرئة السليمة (الاسترواح الضاغط).
١٠. إنتفاخ وتمدد أوردة الرقبة (الاسترواح الضاغط).

الإجراء الإسعافي:

(Emergency measures)

١. الاسترواح المفتوح (النافذ):

(Pneumothorax(open)):

١. طبق مبدأ الـ A,B,C. والفحص السريع.
٢. أغلق جرح الصدر بوضع قطعة من النايلون (مشمع) عليه، ثبته بلاصق (لصقه) من ثلاث جهات، بحيث تكون

الإسترواح المغلق (الضاغط):

(Tension Pneumothorax):

هو عبارة عن تجمع الهواء في الفضاء البلوري (الفضاء المحيط بالرئة) ويكون نتيجة للتعرض لإصابة غير نافذة للصدر كالارتطام الشديد أو التعرض لموجة ضغط أو إصابة رضية بجرح على الصدر مسببه كسور في الأضلاع رغم ملامسة الجلد فتتقرب حافة الضلع المكسور للرئة فيخرج الهواء من الرئة الى الفضاء البلوري.



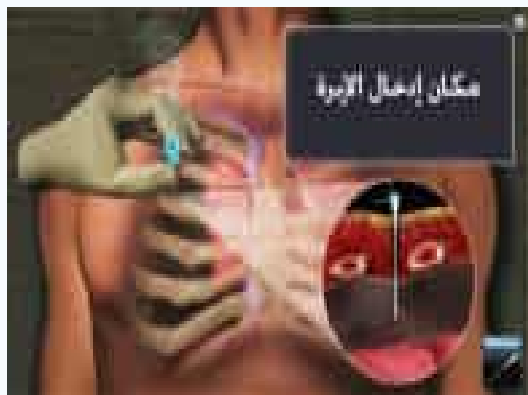
أعراض وعلامات الإسترواح:

١. ضيق وتسارع في التنفس.
٢. تسارع في دقات القلب.
٣. انخفاض في ضغط الدم.

٢. الاسترواح الهفلق (الضاغط) والاسترواح الهضفوط:

(Tension Pneumothorax):

١. طبق مبدأ الـ A,B,C. والفحص السريع.
٢. ادخل إبرة معدنية (كانيولا مقاس ١٤ أو ١٦ مثبت في ذيلها صمام «إصبع قفاز») إلى جوف الصدر في الجهة المصابة، في خط منتصف الترقوة تحت الضلع الثاني وفوق الضلع الثالث، ليسمح بخروج الهواء من جوف الصدر.



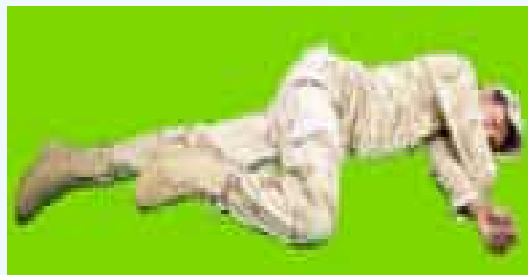
٣. يجب سماع خروج الهواء من الكانيولا.
٤. ثبت الكانيولا بلاصق.
٥. وضعية المصاب: وضعية نصف جلوس.
٦. راقب المصاب، وأعد فحص (العلامات الحيوية) كل ١٠ دقائق.
٧. أعط المصاب مسكن للألم.
٨. أرسل المصاب إلى أقرب مركز إسعافي.

١. النصف العرضي لها في الجلد والآخر في المشمع، وأما الجهة الرابعة (السفلى) اتركها مفتوحة، وذلك للسماح بخروجه الهواء ومنع دخوله.
٢. وضعية المصاب: على جنب، مائلاً ناحية الجهة المصابة من أجل إراحة الرئة والضلوع.
٣. معالجة الصدمة: راقب المصاب وأعد فحص (العلامات الحيوية) كل ١٠ دقائق.
٤. طبق قاعدة إيقاف النزيف العامة (شاش ورباط ضاغط) مع مكان خروج المقذوف.



٥. في حال كان هناك أكثر من إصابة في نفس الرئة، تعامل مع أكبرها بقطعة النايلون (مشمع)، أما بقية الفتحات فيتم التعامل معها كنزيف (شاش ورباط).
٦. في حال كان هناك إصابتان في كلا الرئتين، فيتم التعامل مع كل منها على حده، (إجراء الخطوات السابقة لكل رئة بشكل منفصل).
٧. أعط المصاب مسكن للألم.
٨. أرسل المصاب إلى أقرب مركز إسعافي.





كسر عظم الترقوة:

(Clavicle Fracture):

من الكسور الشائعة في حوادث السير والسقوط والأرطام والإصابات النارية المباشرة.

علامات كسر الترقوة:

(Signs of Clavicle Fracture):

١. الكتف المصاب يكون منخفض أكثر من السليم.
٢. عدم القدرة على رفع الذراع.
٣. يحمل المصاب ذراعه من المرفق.
٤. يمكن رؤية مكان الكسر عبر الجلد على شكل تشوه مغاير للجهة الأخرى.

الإجراء الإسعافي:

(Emergency measures)

١. تأكد من وجود نبض وإحساس في الطرف المكسور.
٢. ضع شال على كتف المصاب (مثلما يُلبس للزينة) وطرفيه للأمام.
٣. إسحب طرفي الشال من تحت إبطي المصاب.
٤. قم بربط الطرفين من جهة ظهر المصاب بقوة.
٥. أعط المصاب مسكن للألام.
٦. أرسل المصاب بسرعة خاصة في حال عدم وجود نبض أو خلل في الإحساس.

كسور الأضلاع (الصدر المَوَّاج):

(Ribs Fracture (Flail Chest)):



العلامات والأعراض:

(signs and symptoms):

١. الألم في مكان الضلع المكسور.
٢. إزدیاد الألم عند التنفس أو السعال أو الحركة.
٣. ضيق حاد في التنفس.
٤. عدم إرتفاع الصدر بشكل متساوي أثناء التنفس.
٥. سماع فرقعة العظام.

الإجراء الإسعافي:

(Emergency measures)

١. طبق مبدأ الـ A,B,C. والفحص السريع.
٢. أعط المصاب مسكن للألم فقط، ولا تقم بالربط أو التثبيت.
٣. في حال كان هناك إسترواح صدري، قم بالإجراء الإسعافي الخاص به.
٤. وضعية المصاب: إمالة المصاب للجهة المصابة من أجل إراحة الرئة، أو على ظهره.
٥. أرسل المصاب إلى أقرب مركز إسعافي.

إصابات البطن

Abdominal Injuries

قد تؤدي إصابات البطن لنزيف داخلي شديد يهدد الحياة، إن لم يكتشف ويعالج بشكل عاجل.

جروح البطن وخروج الأحشاء

(Abdominal wounds & Evisceration):

تسبب الطلقات النارية والشظايا والأدوات القاطعة، بإحداث جروح في جدار البطن، وقد يؤدي إلى خروج قسم من الأحشاء من الجرح، مع احتمال التسبب بنزيف داخلي.



العلامات والأعراض :

(signs and symptoms):

١. ألم في كل أنحاء البطن.
٢. نزيف.
٣. احتمال خروج قسم من الأحشاء.
٤. احتمال وجود أعراض وعلامات الصدمة كالشحوب وإصفرار الجسم وانخفاض ضغط الدم والذهيان.

يحتوي تجويف البطن على عدة أحشاء وأعضاء (الكبد، الطحال، الكليتين، المعدة، الأمعاء، القولون).

تصنيف إصابات البطن:

(Classification of Abdominal Injuries):

١. نافذة: (طلق ناري، طعن بأداة حادة، شظايا).
٢. غير نافذة: (السقوط، الإرتطام، الضغط الناجم عن الانفجار).

علامات إصابات البطن العامة:

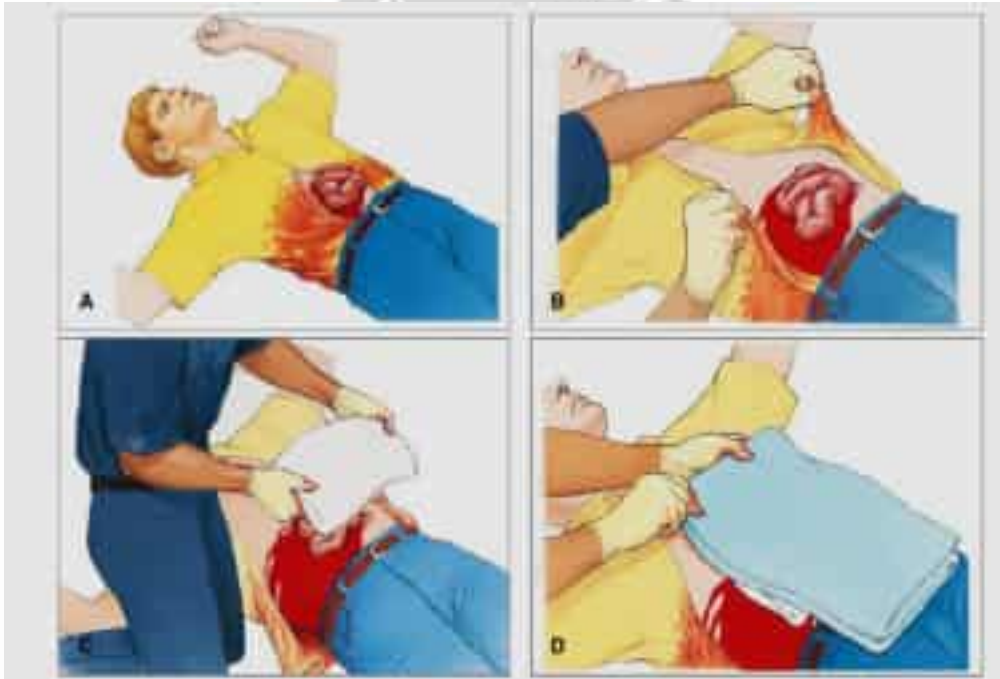
(Signs of Abdominal Injuries):

١. ألم شديد في كامل البطن وخاصة عند اللمس أو الحركة.
٢. تصلب عضلات جدار البطن.
٣. كدمات على جدار البطن (أحياناً).
٤. انتفاخ في البطن.
٥. عدم تحمل الطعام (غثيان وطرش).
٦. جروح نافذة، أو خروج الأمعاء.
٧. وجود آثار دم على فوهة القضيبة (إصابة الجهاز البولي أو كسور عظام الحوض).
٨. تغير لون البول إلى الأحمر أو لون الشاي.
٩. براز أسود اللون (إصابات الأمعاء).
١٠. تدهور العلامات الحيوية (علامات الصدمة).

(Emergency measures)

٩. لف بطن المصاب برباط ضاغط (شال، ملاية، قطعة من ثوب، معوز) عدة لفات غير مشدودة والهدف منها:
 - ✍ تثبيت البطن من الإهتزاز والحركة.
 - ✍ عدم السماح للأحشاء بالخروج مرة أخرى.
١٠. أعط المصاب إبرة مسكنة للتقلص وأخرى للألم وأخرى لوقف النزيف.
١١. حافظ على درجة حرارة المصاب.
١٢. إذا سعل المصاب أو طرش، أسند بطنه بالضغط بلطف على الضمادة فوق الإصابة مباشرة، وذلك للحيلولة دون بروز الأمعاء من الجرح.
١٣. حاول تهدئة المصاب وتطمينه، وأخبره أنه كلما حافظ على هدوئه، كلما خفت الأعراض والألم.
١٤. قم بنقل المصاب إلى أقرب مركز إسعافي.

١. طبق مبدأ الـ A,B,C. والفحص السريع.
٢. ضع المصاب في الوضعية الأكثر راحة مستلقياً على ظهره.
٣. قم بتأمين خطين وريدين، وأعط المصاب لتر محلول ملح.
٤. امنع المصاب من الأكل أو الشرب.
٥. نظف الجرح من الشوائب.
٦. لا تحاول رد الأشياء بيدك أبداً.
٧. قم بإحتواء ما خرج من الأمعاء بكيس بلاستيكي، أو كف جوتي مقلوب، وذلك كي تعزل الأمعاء عن الهواء وتجنبها التلف والتبيس.
٨. في حال لم تستطع رد الأمعاء ولم تجد كيس بلاستيكي، قم بلفها بشاش ومن ثم تبليها بمغذية الصوديوم كل ١٥ دقيقة حتى لا تجف الأمعاء وتتلف.



حوض المصاب بحيث يغطي كامل منطقة الحوض.



٧ أربط طرفي الشال أو المعوز بشكل مشدود فوق منطقة العانة.



٦. التحضير للنقل:

- أربط الرجلان فوق الكاحلين برباط عريض متصلب بشكل (٨).
- أربط الرجلان حول الركبتين برباط عريض.
- يراعى دائما أثناء عمليات النقل، احتمال وجود كسور أخرى مترافقة مع كسر الحوض، ككسر العمود الفقري أو عظم الفخذ، لذا يمنع تحريكه جانبياً.
- أدخل النقالة تحت المصاب، وثبته على النقالة بالأحزمة.
- أرسل المصاب إلى أقرب مركز إسعافي.

كسور الحوض (Pelvic fracture):

العلامات والأعراض:

(signs and symptoms):

١. ألم في الحوض عند الضغط عليه.
٢. عدم القدرة على الوقوف.
٣. ظهور كدمات وإزرقاق أسفل البطن فوق العانة.
٤. تدهور العلامات الحيوية.

الإجراء الإسعافي:

(Emergency measures):

١. طبق مبدأ الـ A,B,C. والفحص السريع.
٢. عدم تحريك المصاب.
٣. طبق القاعدة العامة للنزيف إن وجد.
٤. قم بإعطائه مسكن للألم، وتركيب كانيولا ومغذية رينجر أو ملح.
٥. تثبيت الجبيرة:
- ٧ ضع المصاب بوضعية مريحه (مستلقياً على ظهره).



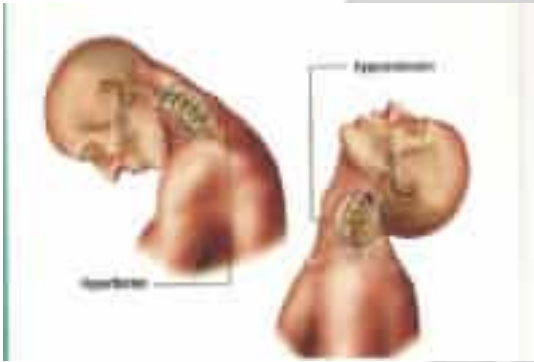
٧ أدخل شال أو معوز (مفروود) تحت

إصابات الرقبة والعمود الفقري (Neck and Vertebral Injuries)

فحص الرقبة والعمود الفقري:

Neck and Vertebral Examination

١. فك الملابس حول الرقبة.
٢. تحسس بأصابعك العمود الفقري من قاعدة الجمجمة إلى أقصى ما يمكن أن تصل إليه بين الكتفين بحثاً عن أي عدم إنتظام في الفقرات يمكن أن يدل على وجود كسر.
٣. إفحص الجزء السفلي منه، مرر يدك تحت تقعر الظهر دون تحريك المصاب من الأعلى بطول العمود الفقري إلى أدنى نقطة تصل إليها يدك.



الإسعاف الأولي عند الشك بوجود كسر في الرقبة والعمود الفقري:

١. طبق مبدأ الـ A, B, C. والفحص السريع.
٢. ثبت جبيرة للرقبة (طوق صلب) وفي حال عدم وجود الطوق الطبي قم بما يلي:
- ✗ خذ قارورة بلاستيك (صحة ماء) فارغة، وقم بإفراغها من الهواء، ثم أغلق غطاءها.
- ✗ لف القارورة بشال أو قطعة قماش.

- ✗ تتمثل خطورة كسور العمود الفقري في إصابة النخاع الشوكي، والتي قد تؤدي إلى الشلل الجزئي أو الكلي.
- ✗ كثيراً من الإصابات البسيطة تتحول إلى إصابات غير قابلة للشفاء، بسبب سوء التعامل مع المصاب وعدم نقله بطريقة صحيحة.



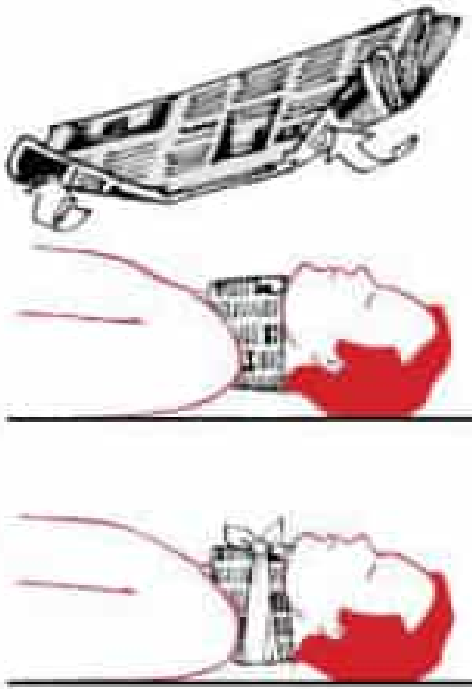
العلامات المبكرة لكسور الرقبة والعمود الفقري:

١. الألم: الذي قد يكون شديداً في مكان الإصابة وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.
٢. تورم: مكان الإصابة.
٣. تشوه: تشوه في إمتداد العمود الفقري.
٤. الشلل: يحدث عند وجود إصابة في النخاع الشوكي.
٥. تمل: وغالباً ما يكون في الأطراف.

شلل الطرفين السفليين تكون الإصابة في الظهر، وشلل الأطراف الأربعة تكون الإصابة في العنق.

لا يعطى المصاب الطعام أو الشراب لأي سبب كان.

أي مصاب يشكو من ألم شديد في العنق أو الظهر تعامل معه على أنه كسر في العمود الفقري حتى يثبت العكس.



جبيرة ورقية

٤. ضع القارورة في منطقة الرقبة.
٤. أدخل أحد طرفي الشال من تحت الرقبة بأطراف أصابعك من دون تحريكها أو رفعها.
٤. أربط طرفي الشال من الجانب، بحيث تصبح القارورة على شكل طوق حول الرقبة.
٣. حافظ على ثبات إستقامة الرأس والرقبة مع الجسم.
٤. وضعية المصاب: مستلقياً على ظهره بوضعية مريحه مع المحافظة على حرارة جسمه.
٥. أعط المصاب مسكن للألم ومغذية رينجر أو ملح.
٦. التحضير للنقل:
٤. ثبت المصاب على حماله مستخدماً أحزمة النقالة.
٤. لا تحرك المصاب إلا في حالة الضرورة القصوى.
٤. لا تثني الرأس أو الجسم ولا تحرك الأطراف ولا تدع المصاب يجلس أو يقف لأي سبب كان.
٤. يمكن عند الضرورة القصوى قلب المصاب على بطنه في حال كان فاقد الوعي، أو يطرش، مع مراعاة أن يكون جسمه على إستقامة واحدة.
٧. أنقل المصاب إلى أقرب مركز إسعافي.

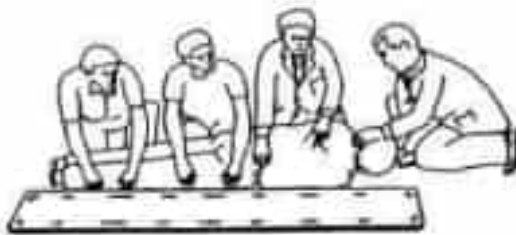




STEP 1



STEP 2



STEP 3



STEP 4



STEP 5

HM3P18443



BURNS

الحروق

11

٢. بخار الغازات المضغوطة على شكل سوائل مثل الغاز المنزلي والأكسجين السائل والنيتروجين السائل.

٥. الحروق الكيميائية:

(Chemical burns):

الأسباب (Causes):

١. الكيمائيات ذات الإستهلاك اليومي مثل أسيد البطاريات، والفلاش.
٢. الأسلحة الكيميائية.

٦. حروق الإشعاعات والمواد المشعة:

(Radiation burns & radioactive aterials):

الأسباب (Causes):

١. الإصابة بالفوسفور المشتعل.
٢. حروق الشمس- أسطح المعادن المجمدة.

طبقات الجلد (Skin layers):

كما ذكرنا سابقاً فإن الجلد يتكون من طبقتين:

١. البشرة:

وهي الطبقة الخارجية، وتحوي مواد دهنية تجعل الجلد غير نافذ للماء.

٢. الأدمة:

- وهي الطبقة الداخلية، وتحوي على أوعية دموية، أعصاب، غدد دهنية، غدد عرقية، وجذور الشعر.

- الأعصاب الحسية في هذه الطبقة مسؤولة عن إستشعار الحرارة والبرودة وحاسة اللمس والألم.

التعريف Defination:

هي تلف أو تخرب في طبقات الجلد السطحية وقد يشمل التلف الأنسجة الأخرى التي تحت الجلد وذلك نتيجة إصابتها بأحد أسباب الحروق.

أنواع الحروق وأسبابها:

(Types & Causes of the burn):

١. الحروق الجافة (Dry burns):

الأسباب (Causes):

١. ألسنة اللهب.
٢. الأسطح الساخنة.
٣. الاحتكاك (حروق الحبال).

٢. الحروق الرطبة (Moist burns):

الأسباب (Causes):

١. البخار.
٢. السوائل الحارة مثل: الشاهي، القهوة، الزيت الحار.

٣. الحروق الكهربائية:

(Electrical burns):

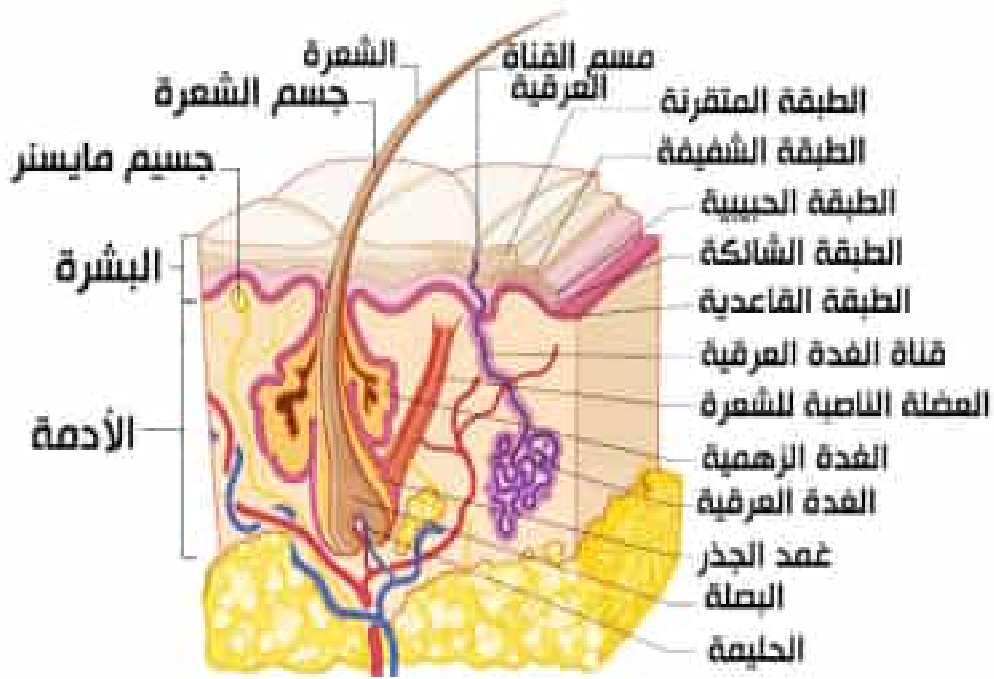
الأسباب (Causes):

١. الكهرباء المستخدمة في المنازل.
٢. كهرباء الضغط العالي.
٣. الصواعق.

٤. حروق البرد (Cold burns):

الأسباب (Causes):

١. أسطح المعادن المجمدة.



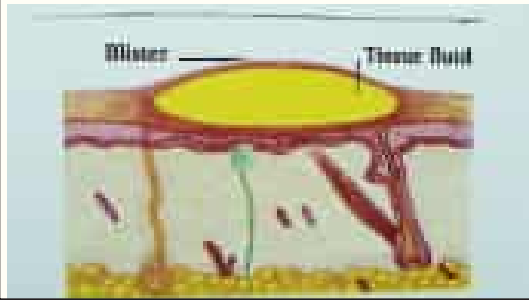
- يصبح الجلد أحمر اللون مع إنتفاخ بسيط.
- الألم الذي يزول بعد يومين أو ثلاثة تقريباً.
- تشفى هذه الحروق خلال ثلاثة إلى خمسة أيام تقريباً دون ندبات.

حروق الدرجة الثانية:

(Second degree burns):

عمق الإصابة (Injury Depth):

- تشمل الإصابة كامل الطبقة الأولى.
- إصابة جزء من الطبقة الثانية.



درجات الحروق:

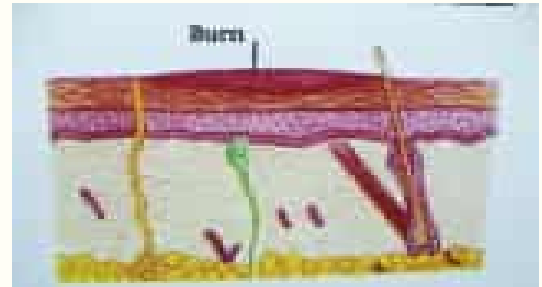
(degrees of the burn):

حروق الدرجة الأولى:

(First degree burns)

عمق الإصابة (Injury Depth):

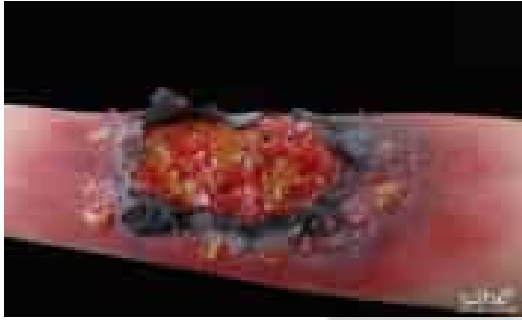
- تشمل إصابة الطبقة الأولى السطحية من الجلد (البشرة).



العلامات والأعراض:

(Signs & Symptoms):

- يتراوح منظر الجلد من الأبيض الميت إلى الأسود.
- ألم في أطراف الحرق كونه من الدرجة الأولى والثانية، أما حرق الدرجة الثالثة غير مؤلم في مكانه.
- يكون النزيف من الجلد المحترق شديداً، مما يؤدي في معظم الحالات إلى حدوث الصدمة.



الإجراء الإسعافي العام:

(General Emergency measure):

١. قبل معالجة الحروق فإنه من الأهمية معرفة التالي: مساحة الحرق، وعمق الحرق، وسبب الحريق.
٢. عادة تترافق الحروق مع الإختناق بالغازات الحارة والمنبعثة من الحريق، مما يؤدي إلى إنسداد وتضرر مجرى الهواء.
٣. مساحة الحريق: ستخبرك مدى إمكانية حدوث الصدمة، وتساعدك على حساب كمية السوائل المطلوبة.
٤. تعمل الحروق على تدمير الجلد، الذي يعتبر حاجزاً لمنع الجراثيم، فيؤدي ذلك إلى العدوى البكتيرية أو الفيروسية، وكلما كان الحريق عميقاً كان أكثر خطراً.

العلامات والأعراض:

(Signs & Symptoms):

- إحمرار الجلد.
- فقاعات جلدية.
- إفرازات (مصل) من الجلد المحترق.
- إنتفاخ وتورم الجلد.
- الألم الشديد.
- تشفى خلال عدة أسابيع، وتترك ندبات بسيطة إلى متوسطة.



حروق الدرجة الثالثة:

(Third degree burns) :

عمق الإصابة (Injury Depth):

- تشمل الإصابة كامل طبقات الجلد.
- إمكانية وصول الحرق إلى ما تحت الجلد.



العلامات والأعراض:

(Signs & Symptoms):

إسعاف حروق الدرجة الأولى:

(First aid of First degree burns):

١. صب مقداراً من الماء البارد على الجزء المصاب لمدة عشر دقائق إن أمكن.
٢. حاول أن تخلع الساعات، الأحزمة، والألبسة الضيقة من المنطقة المصابة، ولكن بلطف وحرص شديدين.
٣. لف المنطقة المصابة بضماد معقم أو أي قماش نظيف تحاشياً للإصابة بالبكتيريا ولا تشد إحكامها.
٤. لا تضع ضماداً لاصقاً مباشرة على المكان المحروق.
٥. لا تضع مراهم أو دهون أو معاجين فقد تضاعف الإصابة.

إسعاف حروق الدرجة الثانية والثالثة

(First aid of Second & third degree burns):

١. وضع المصاب بحيث تكون المنطقة المحروقة بعيدة عن الأرض.
٢. صب كميات كبيرة ومستمرة من الماء البارد لمدة لا تقل عن عشر دقائق إن

٣. أمكن.
٤. أثناء تبريدك حرق المصاب، لاحظ تنفسه وقم بإنعاشه عند الضرورة.
٥. أزل بلطف أي خاتم أو ساعة أو أحزمة أو حذاء أو لباس من المنطقة المتضررة قبل أن يحدث تورم.
٦. أزل بكل حرص الملابس المحترقة التي يمكن إزالتها ولم تلتصق بعد، أما الملتصقة فاتركها مكانها وقم بالقص حولها.
٧. غط الحرق بضماد أو بقماش نظيف ولا تشد لفه.
٨. قم بإعطائه مسكن للألام.
٩. قم بإعطائه مغذية صوديوم.
١٠. أرفع من معنويات المصاب وراقب علاماته الحيوية باستمرار.
١١. قم بنقله إلى أقرب مركز إسعافي.



EVACUATION

الإخلاء للمصابين

12

الإخلاء Evacuation

التعريف:

Defination:

هي عملية إخراج المصاب وتأمينه من مكان الإصابة إلى أقرب منطقة آمنة، ومحددة، ويمكن التعرف عليها بسهولة.

ك عادة يقوم بهذه المهمة المسعف المقاتل، ولكن قد تحدث متغيرات تلزمك أن تقوم بترك موقعك، والقيام بعملية الإخلاء.

الحالات التي تجبر مسعف الفصيل على القيام بعملية الإخلاء:

(Cases that force the platoon paramedic to carry out the evacuation):

١. إصابة المسعف المقاتل أو غيابه.
٢. عدد الإصابات الكبير.
٣. عدم وجود من ينقل المصاب إلى مسعف الفصيل.

إجراءات الإخلاء:

(Evacuation procedures):

A. الإجراءات التي يجب القيام بها قبل بدء عملية الإخلاء:

قبل ذهابك إلى الموقع لإخلاء المصاب، قم بإجراء ما يلي:

١. معرفة عدد المصابين.
٢. معرفة مكان الإصابة (الصدر، الرأس)، وسببها (قنص، قصف).
٣. معرفة أماكن المصاب أو المصابين.
٤. معرفة وضع الموقع المتجه إليه:

هل مازال المصاب في نفس المكان الذي أصيب فيه؟ أو أنه قد تم سحبه إلى مكان أمن؟

- هل المصاب في منطقة خطيرة (تحت مرمى العدو)؟
- هل العمليات العسكرية مازالت مستمرة؟
- هل العدو في تقدم أم تقهقر؟
- هل المجاهدين محاصرين؟
- ٥. خذ حقيبة الإسعاف وسلاحك، ووسيلة للإتصال، ونقالة إن أمكن.
- ٦. قم بإستدعاء فريق النقل.
- ٧. أبلغ مشرفك العسكري بالمهمة التي ستقوم بها.

B. الإجراءات المتبعة قبل وصولك إلى الموقع:

(Procedures befor arrival of the site):

١. إستخدم جهاز الاتصالات، وأبلغ مشرف الموقع مع المجاهدين بقدومك، بحيث لا تصاب بنيران صديقه، فقد يعتبرك المجاهدين عدو.
٢. حاول أن تعرف توزيع وتمترس المجاهدين، وحاول إعلامهم بتحركك.
٣. إذا كان الوقت ليلاً، لا تتحرك إلا مع دليل من الموقع، وإستخدم صوتك بكلمات متفق عليها سابقاً تدل على أنك المسعف (كلمة سر).

C. عملية الإخلاء:

(Evacuation process):

١. الحماية الشخصية وحماية المصاب:
أدرس الظروف المحيطة، وإمكانية وطريقة وصولك إلى المصاب، بحيث لا تصبح الإصابة إصابتين.
٢. إخلاء المصاب من أرض الميدان إلى نقطة الحماية الأولى:
- إن القاعدة العامة تقضي بعدم تحريك

في حال وجود ناقل واحد (One carry)

١. أسلوب رجل الإطفاء:

(Fireman style):

- من أكثر الأساليب سهولة في الحمل.
- لا يستخدم هذا الأسلوب إلا إذا كنت تعلم أن إصابته لن تتأثر في هذه الوضعية.
- تستخدم هذه الطريقة فقط عندما يكون المسعف وحيد، ومضطر لإخلاء المصاب الغير قادر على المشي من مكان خطر.



٢. الحمل بالذراع:

(Carried by the arm):

- تستخدم عندما يكون المصاب صغير الحجم، ومسافة النقل قصيرة.



المصاب من مكانه، وتقديم الإسعافات اللازمة في مكان تواجده، إلا أنه أحياناً يضطر المسعف إلى إخلاء المصاب من مكانه، وذلك لحمايته أو حماية المسعف نفسه وذلك على اعتبار أن هذا أهون الشرين للإبتعاد عن مصدر الخطر.

- الأولوية في تأمين المصاب بنقله إلى أقرب مكان آمن (من ٢ إلى ٢٠ متر) قبل البدء عملية الإسعاف.

٣. التصنيف (Classification):

٤. قم بتصنيف المصابين في حال تعدد الإصابات.

٤. في حال كان هناك مصاب في مرمى نيران العدو، ولا تستطيع الوصول إليه (قناصة مثلاً، قصف طيران، طيران مروحي) قم بما يلي:

- حاول أن تتواصل مع المصاب بصوتك.
- اسأله عن نوع ومكان إصابته، وقدم له التعليمات المناسبة، مثلاً هناك نزيف أخبره أن يقوم بالربط، أو هناك كسر في الساق، أخبره ألا يقف عليها ويقوم بتثبيتها.
- حاول تشجيعه على الزحف نحوك، مع تأمين غطاء ناري له.
- بإمكانك استخدام الحبال أو ما شابه لسحب المصاب.
- إذا تعذر إخلاء المصاب، أبلغ مشرف العملية بإتخاذ اللازم

٤. النقل (transportation):

بعد إخلاء المصابين وتقديم اللازم لهم، إطلب من فريق النقل نقلهم إلى المركز الإسعافي.

وسائل الإخلاء اليدوية:

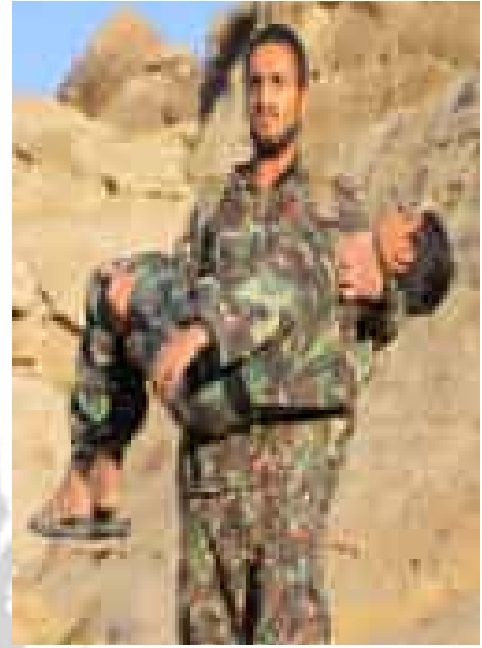
(Means of manual evacuation):



12



12



٣. الإسناد:

(Support):

- ✍ عندما يكون المصاب قادر على المشي أو على الأقل قادر على المشي بساق واحدة.
- ✍ يستخدم هذا الأسلوب بحسب قدرة المصاب على المشي.
- ✍ يمرر ساعد المصاب حول رقبة المسعف، وتحيط يد المسعف خصر المصاب، بحيث يمسك بمعصم المصاب، ويسيران معاً على أن يمسك المسعف بيده الحرة يد المصاب الملتفة حول رقبته.

٤. أسلوب القوقعة:

(The style of Alquqha):

- ✍ يستخدم هذا الأسلوب للمصاب الواعي فقط لأنه من الضروري أن يكون ممسكاً بعنق الحامل.



127

- قصير أو خلف آلية (سيارة).
- ✚ يربط المسعف معصمي المصاب مع بعضيهما برباط.
- ✚ يركع على ركبتيه فوق المصاب مستنداً على يديه وركبتيه.
- ✚ يمرر رأسه بين معصمي المصاب لتحيطا برقبته.



٩. أسلوب السحب من تحت الكتف:

The style of drag under the shoulder:



٥. أسلوب الحمل على الظهر:

(the method of carried on the back):

- ✚ إخلاء المصاب لمسافات متوسطة.
- ✚ بعد أن يصبح المصاب فوق الناقل، لا بد للناقل رفع ظهره قدر الإمكان لكيلا يتعب ويتعرض للآلام في الظهر.

٦. أسلوب الحمل بالحزام:

(Carried belt style):

- ✚ أفضل طريقة للإخلاء للمسافات الطويلة.
- ✚ المصاب يكون مربوطاً بحبل أو ما شابه من تحت كتفيه (شال، معوز، حزام).
- ✚ كالتا يدي الناقل حرة الحركة، والمصاب ثابت ومربوط بالحزام، كما أن كلتا يدي المصاب حرة أيضاً «إن كان واعي».
- ✚ بإمكان المصاب حمل السلاح أو أي أدوات.

٧. أسلوب السحب بالحزام:

(The style of pulling the belt):

- ✚ يستخدم للمسافات القصيرة.
- ✚ يستخدم في حال كان لا بد للمسعف والمصاب البقاء قريبين من الأرض (منبطحين) بسبب كثافة النيران.

٨. أسلوب إمساك العنق:

(Neck style):

- ✚ للمسافات القصيرة وفي حال كان لا بد من الإنبطاح أو التستر خلف ساتر



12

٣. أسلوب الحمل بالذراع:

(Carried style by arm):

✍ تستخدم للمسافات المتوسطة (٣٠ - ٥٠ متر).

✍ لتخفيف إنهاك (تعب) الذراعين قم برفع المصاب وارفعه بمستوى الصدر.



الإخلاء بنافلين:

(Evacuation with tow carriers) :

١. أسلوب الإسناد:

(Style of attribution) :

✍ تستخدم لنقل المصاب سواء كان واعي أو غير واعي.



٢. أسلوب الكرسي:

(Style of the chair) .



مقعداً شكله مربع.



✚ ينحنيان ليجلس المصاب على أيديهما (المقعد) ويضع يديه خلف كتفيهما ثم يحملانه ويسيران به.



٤. أسلوب الحمل من الخلف:

✚ تستخدم للمسافات الطويلة أكثر من ٣٠٠ م.



٥. أسلوب النياقي الأربعة:

(Style of the four hands):

✚ تستخدم فقط للمصاب الواعي، كونه يحتاج أن يضع يديه حول أكتاف الناقلين.

✚ جيدة في حال كانت الإصابة في الساق ولمسافات متوسطة (٥٠ - ٣٠٠ م).

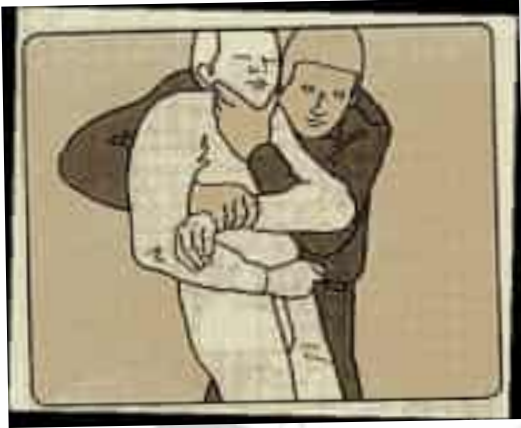
✚ يمسك كل منها ساعده الأيمن مثلاً بقبضة يده اليسرى ثم يمسك كل منهما بقبضته الفارغة ساعد الآخر بحيث تشكل الأيدي والسواعد مع بعضهما

الإسعاف الحربي

بإسناد الطرفين السفليين إثناء إخراج المصاب.

الطلب من المتواجدين وضع إشارات محددة لمكان الحادث أو تحويل السير.

يبتدع الناس عدة طرق للحمل والنقل، إلا أنه قد يقوم هؤلاء بحركات خاطئة أثناء النقل، وهذا يعود بالضرر على المصاب وعلى الناقل الذي يقوم بحمله على حد سواء.



طريقة إخراج المصاب من السيارة

(The way to remove the injured from the car):

تستخدم عند مصاب عالق في سيارة، ويوجد خطر على حياته، فهنا يضطر المسعف إلى إخراجهم رغم خطورة العملية، حيث يخشى من حدوث كسر في العمود الفقري لدى المصاب، لذلك يجب المحافظة على استقامة الرأس مع الجذع.

الطريقة (Method):

يمرر المسعف ساعده تحت إبط المصاب من ناحية باب السيارة ويسند ذقنه براحة يده، فيصبح رأس المصاب مقلوباً بعض الشيء إلى الوراء ومسنداً إلى كتف المسعف الأخرى.

يمرر المسعف ساعده الآخر تحت إبط المصاب التي من جهة السيارة الداخلية ويمسك بمعصم يد المصاب التي من جهة الباب.

يدير المصاب بحذر نحو الخارج منتبهاً إلى المحافظة على استقامة الرأس والرقبة والجذع.

يبتعد عن السيارة وهو يسند جسم المصاب ثم يمدده بسرعة وهو ما زال يتجنب أي تحريك يسبب التواء العمود الفقري.

في حال وجود مسعف آخر فانه يقوم

CARRYING & TRANSPORTING

الحمل والنقل

13

الحمل والنقل

Evacuation & Transporting

التعريف:

(Defination):

الحمل (Evacuation):

هو رفع المصاب من مكان تواجدته إلى وسيلة النقل، كنفالة، أو باب أو سرير.

النقل (Transporting):

هو السير بالمصاب من مكان تواجدته إلى مكان آخر، كسيارة الإسعاف أو على ظهر الحيوانات.

مبادئ تساعد في اختيار طريقة حمل المصاب وهي:

((Principles That help to method of evacuation injured) :

١. طبيعة الإصابة.
٢. عدد الناقلين.
٣. حجم وقوة الناقلين.
٤. طبيعة الأرض.
٥. المسافة المراد قطعها.
٦. وضع الجبهة.
٧. الإمكانات المتوفرة: نقالة، عكاز، ... الخ.

مبادئ متعلقة بالناقل:

((Principles relating to the carrier:

١. الوقاية من آلام الظهر وإصابة العضلات:
- إستقامة جسم الناقل (العمود الفقري) مع الرأس.

- الجسم المحمول أقل وزناً من الجسم الحامل.

٢. تأمين توازن الجسم:

- قاعدة عريضة للارتكاز (القدمين متباعدتين وقابلتان للحركة).

- الأتقال موزعة على جميع الناقلين وعلى سواعدهم.

- الإعتماد على المفاصل والعضلات.

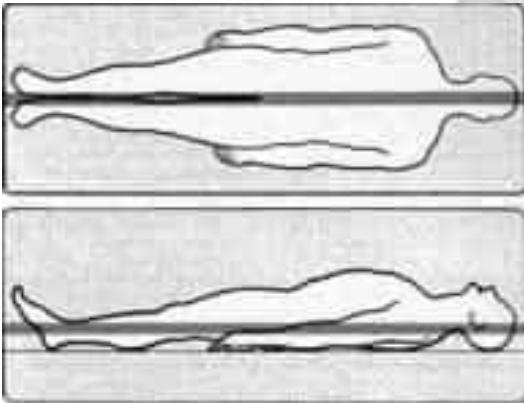
٣. تأمين سلامة الحمل:

- المقابض متينة: أي أيدي الناقل تمسك المصاب أو وسيلة الحمل بإحكام.
- الساعدان مشدودان جيداً.

مبادئ متعلقة بالمصاب:

((Principles relating to the injured :

١. الحفاظ على مجرى الهواء مفتوحاً.
٢. الحفاظ على إستقامة جسم المصاب.
٣. عدم تحريك المصاب حركات لا لزوم لها.





٢. النقلات المبتكرة:

(Innovative mobility):

- ✍ المسعف الذي لا تتوفر لديه نقالة جاهزة وهو مضطر لإجراء عملية الحمل والنقل، يقوم بصنع نقالة مبتكرة لأداء العملية، وهذا النقالة قد تكون عبارة عن سلم أو باب يوضع عليه المصاب، وقد تكون عصاتين طويلتين تلف عليها بطانية بشكل جيد، أو قد يكون أطرافها ملفوفة إلى الداخل، أو قد يكون مجموعة من الأربطة العريضة عقد كل اثنين منها مع بعضيهما.
- ✍ لا ننسى بعد وضع المصاب على النقالة أن نغطيه بالبطانية ونثبته بأحزمة النقالة أو بواسطة أربطة مبتكرة.
- ✍ يجب الحفاظ على نظافة وصلاحية النقالة لأي طارئ.



تحضير وسيلة النقل:

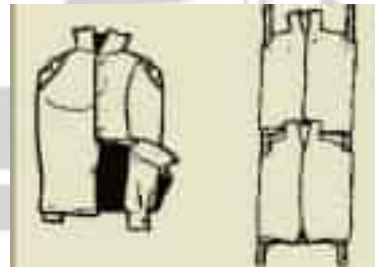
(preparation of the means of transport):

يجب أن يقوم الناقل بتحضير وسيلة النقل وتجهيزها قبل وضع المصاب عليها، وغالباً ما تتواجد النقلات ضمن الإعداد الإسعافي:

١. النقالة القابلة للعطف _الطي:

(Mobile devices):

توضع بطانية نظيفة عليه بشكل مائل بحيث تكون زاويتين متقابلتين منها داخل النقالة ثم تطوى الزاويتان الأخريان على بعضيهما، بحيث يترك قسم منها بارز إلى خارج النقالة لشده.



فحص ها قبل نقل المصاب:

(Check before moving the injured):

هو الإجراء الأخير للمصاب، تشمل عملية فحص شاملة وأخيرة، للتأكد من أن إجراءاتك الإسعافية صحيحة، ولم تغفل أو تنسى شيء، وذلك قبل إرساله إلى المركز الإسعافي. حيث تشمل عملية الفحص التالي:

١. الطرق التنفسية (Airway):

- هل الطرق التنفسية مفتوحة؟
- هل وضعية المصاب مريحة وملائمة لنوع الإصابة؟

٢. التنفس (Breathing):

- هل وضعية المصاب تسمح له بالتنفس المريح؟

٣. الدورة الدموية (Blood circulation):

- راجع أماكن النزيف الموجودة في جسمه وتأكد من الرباط الضاغط محكم ولاوجود لنزيف.

- تأكد من تدفئة المصاب بشكل جيد.
- هل قمت بتعويضه السوائل التي فقدتها؟

٤. وفي الأخير اسأل نفسك.. هل

هناك إجراءات أخرى تستطيع عملها؟

- هل أعطيت المصاب مسكن للألام؟
- هل تأكدت من عدم وجود أي جرح نازف لم تقم بربطه أو كسر لم تقم بتجبيره؟
- تفقد الوجه والعينين والظهر والحوض والإلية والفخذ والأطراف مرة أخرى؟

٥. التوجيهات الخاصة بالناقلين:

- إعلامهم بحالة المصاب والمخاطر المتوقع حدوثها أثناء عملية النقل (إختناق، آلام شديدة، نزيف، إستشهاد، إلخ).



وضعية المصاب على النقالة:

The position of the injured on the mobile:

- ✗ إذا كان واعياً ومستقياً على ظهره.
- ✗ إذا كان غير واعياً، فيوضع في وضعية الإستفاقة (وضعية الأمان) أو على بطنه وإمالة الرأس جانباً.
- ✗ في حالة كسور الأطراف السفلى: يكون مستلقي على ظهره، ويتم تثبيت الرجل المكسورة مع الأخرى.
- ✗ في حالة كسور الذراع: يكون مستلقي على ظهرة والذراع مثبت إلى الصدر.
- ✗ في حالة إصابات الصدر: على جنب مائلاً ناحية الجهة المصابة.
- ✗ في حالة إصابة العمود الفقري: مستقياً على ظهره، أو على بطنه (اضطراباً) في وجود إشكالات أخرى.

الإمكان.

قائد المجموعة:

- يتخذ وضعية القرفصاء عند رأس المصاب، مواجهاً للمسعفين الآخرين.
- يتأكد من أن رأس المصاب سيوضع على النقالة وليس خارجها.
- إحدى قدميه تسند طرف مقبض النقالة، أما القدم الأخرى فتكون بجانب كتف المصاب.
- توضع إحدى يديه تحت رقبة المصاب لتسند رأسه واليد الأخرى تدخل بين كتفي المصاب.

- المسعف الأول:

- يتخذ وضعية القرفصاء عند رجلي المصاب، قدمه تسند طرف مقبض النقالة بشكل مماثل لقدم قائد المجموعة أما قدمه الأخرى فتكون عند ساق المصاب.
- يقرب رجلي المصاب من بعضهما جيداً، يديه تدخل من تحت ركبتي المصاب، ثم يباعد يديه لتسمح له برفع قدمي المصاب بشكل جيد، ويكون عادةً المسعف الأقل قدرة على الحمل.

- المسعف الثاني:

- يتخذ وضعيته بعد أن يثبت قائد المجموعة والمسعف الأول النقالة بقدميهما.
- يكون عادة المسعف الأكثر قدرة على الحمل.
- إحدى قدميه خارج النقالة وقدمه الأخرى موضوعة على طرف النقالة، يدخل يديه تحت ظهر المصاب.

- لا بد من أن تخبر الناقلين بما يجب عليهم فعله خلال فترة النقل والإجراءات التي يجب إتخاذها مثل إرخاء ربطه الحنفيه مثلاً.

- خلال عملية النقل، يجب تفقد المصاب كل ربع ساعة.
- يجب على الناقلين التحدث إلى المصاب وتشجيعه.
- عليهم تفقد حرارة الجلد وتفقد الأطراف خاصة في حال وجود رباط الحنفيه.
- تفقد وضعية المصاب والتأكد من أنها مريحة.
- التأكد من تدفئة وحرارة المصاب، خاصة في حالة كان الطريق من مناطق حارة إلى مناطق باردة.

طرق حمل المصاب:

((Methods of carrying the injured :

توجد عدة طرق لحمل المصابين، وتتطلب تدريباً وتنسيقاً مشتركاً بين الحاملين الذين يقومون بعملية الحمل.

الحمل بثلاثة مسعفين - الجسر النزلندي:

(Carrying by three paramedics) :

الشروط:

- الأرض مستوية غير منحدر.
- يستعمل في جميع الإصابات عدا الحالات التي يشك فيها بوجود كسر في العمود الفقري.

الطريقة:

وجود قائد للمجموعة + مسعفين إثنين.

- يوزع قائد المجموعة الأفراد حسب قاعدة الوزن (القدرة على الحمل).
- النقالة يجب أن تكون محضرة بشكل جيد ، ويقرب من المصاب قدر



13

الحمل بأربعة مسعفين - الجسر العادي:

(Carrying by four paramedics):

الشروط:

- الأرض مستوية وغير وعرة حتى لا تعيق حركة النقالة.
- لا توجد مساحة جانبية كافية لوضع النقالة.

الطريقة:

- يأخذ المسعفون الثلاثة المكلفين بحمل المصاب نفس الوضعيات السابقة في طريقة الحمل بثلاثة مسعفين، مع الإنتباه إلى أن يباعدوا بين قدميه جيداً لتمرير النقالة بينهم.

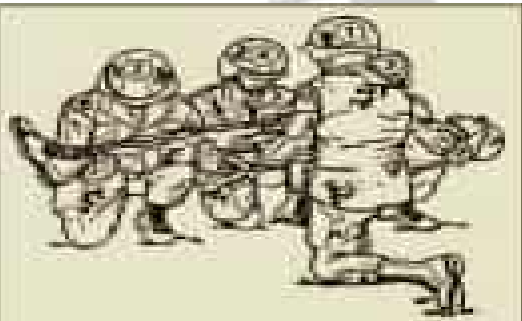
- قائد المجموعة هو المسعف الرابع الذي يمرر النقالة بين أقدام المسعفين، وعليه أن يتأكد من وضع رأس المصاب على النقالة وليس خارجه، ويقوم بإعطاء التعليمات للمجموعة كما سبق.



التعليمات:

- يقوم قائد المجموعة بإعطاء التعليمات وعلى الفريق الإسعافي التنفيذ بدقة وبوقت واحد.

قائد المجموعة	المسعف الأول	المسعف الثاني
إنتبه للاستعداد	مستعد	مستعد
إنتبه للرفع - ارفع	عند إعطاء إشارة الرفع ينهض المسعفون الثلاثة معاً محافظين على ظهرهم مسطحاً ويرفعون المصاب بمقدار خفيف مع الحفاظ على إستقامة محور رأس - رقبة - جذع المصاب.	
ارفع	يوضع المصاب على النقالة يغطى ويثبت جيداً بالنقالة ثم ينقل.	



المسعف الرابع	المسعف الثالث	المسعف الثاني	المسعف الأول	قائد المجموعة
مستعد	مستعد	مستعد	مستعد	انتبه للاستعداد
ينهض المسعفون الأربعة معاً محافظين على ظهرهم مسطحاً ويرفعون المصاب بمقدار خفيف مع الحفاظ على استقامة محور رأس - رقبة - جذع المصاب.				انتبه لارتفاع الرفع
				يمرر النقالة إلى تحت المصاب
يوضع المصاب على النقالة يغطي ويثبت جيداً بالنقالة ثم ينقل.				انتبه للوضع - ضع

حالة خاصة:

حمل مصاب بوضع الأمان الجانبي الجسر النرويجي

- قائد المجموعة: يمرر إحدى يديه تحت يد المصاب التي يستند عليها رأسه، واليد الأخرى تحت الكوعين.
- المسعف الأول: يمرر إحدى يديه تحت الركبة المثنية، واليد الأخرى تحت الساق الأخرى.
- المسعف الثاني: يمرر يديه تحت خصر المصاب ويشبكهما معاً.
- تعطى نفس التعليمات وبنفس الطريقة.

حمل مصاب لديه كسر في العמוד الفقري - الجسر المحسن:

الشروط:

- توفر أربعة أو خمسة مسعفين.
- الأرض مستوية.
- توفر مسافة كافية أمام المصاب.
- هي الطريقة المختارة لحمل مصاب لديه كسر في العמוד الفقري.

الطريقة:

- قائد المجموعة: يمرر النقالة بين أقدام المسعفين ويضعها تحت المصاب، ويعطي التعليمات.
- المسعف الأول: يقرص أمام وجانب رأس المصاب بحيث يبقى جانباً، ولا يدخل النقالة بين قدميه، ويقوم بتثبيت رأس المصاب من خلال إحاطة كفيه للرأس.
- المسعف الثاني: عند صدر المصاب ويمرر يديه تحت كتفيه.
- المسعف الثالث: عند جذع المصاب.
- المسعف الرابع: عند رجلي المصاب.



التعليمات:



13

المسعف الثاني، واليد الأخرى في منتصف ساق المصاب.

طرق الملعة:

طريقة الملعة العادية:

الشروط:

- عدم إمكانية تقريب النقالة من المصاب (وعورة الأرض)، بل يجب حمل المصاب والسير به إلى النقالة.
- توفر اثنان أو ثلاثة مسعفين.
- تستخدم عند مصاب ليس لديه كسر بالعمود الفقري.
- تستخدم لحمل مصاب من سرير إلى نقالة أو من نقالة إلى سيارة الإسعاف والعكس.

الطريقة:

(The method):

- يوزع قائد المجموعة الفريق حسب الطول، فالأطول من الرأس والذي يليه طويلاً يحمل الجذع والأقصر يحمل الرجلين، ويقف قائد المجموعة في المكان المناسب بالنسبة لطوله ويعطي التعليمات.
- يقف المسعفون بجانب المصاب على استقامة واحدة، ومقتربين منه قدر الإمكان، ينزل المسعفون على الأرض بشكل تستند فيه الركبة اليسرى على الأرض (وضعية الإستعداد) أما الساق اليمنى فهي عمودية على الأرض وتشكل زاوية قائمة مع الفخذ اليمنى.
- عند الرأس: يمرر المسعف الأول إحدى يديه تحت رقبة المصاب ليسند الرأس، واليد الأخرى تحت ظهره.
- عند الجذع: يمرر المسعف الثاني إحدى يديه تحت ظهر المصاب، بحيث تكون قريبة من يد المسعف الأول، وتمرر يده الأخرى تحت حوض المصاب.
- عند الرجلين: يمرر المسعف الثالث إحدى يديه تحت حوض المصاب مجاورة ليد

المسعف الثاني	المسعف الأول	قائد المجموعة
مستعد	مستعد	انتبه للاستعداد
هنا يرفع المصاب ويوضع على أفخاذ المسعفين.		انتبه للرفع- ارفع
يضم المسعفون المصاب إلى صدورهم.		ضم
يقف المسعفون والمصاب مازال إلى صدورهم.		قف
يبدأ المسعفون بالمسير بناءً على مقدار خطوة قائد المجموعة بحيث:		سر
- التعداد واحد يبعد المسعفون بين أقدامهم.		
- التعداد اثنين يقرب المسعفون بين أقدامهم.		
والسير يكون باتجاه رأس المصاب نحو النقالة.		
يقف المسعفون أمام النقالة على استقامة واحدة مقتربين منه قدر الإمكان.		قف للنقالة
ينزل المسعفون على أقدامهم وركبهم كما سبق.		انزل
يُنزل المسعفون المصاب على أفخاذهم.		يفك الضم
يوضع المصاب على النقالة يغطى ويثبت جيداً بالنقالة ثم ينقل.		أنتبه للوضع - ضع

فريق إسعافي (فريق النقل) متخصص ومدرب بشكل مشترك، لأن أداء هذه المهمة يتطلب تنسيقاً جيداً بين عناصر الفريق. - بعد وضع المصاب على النقالة يغطى بالبطانية المحضرة سابقاً على النقالة ويثبت جيداً بأحزمة النقالة أو بأربطة مرتجلة بحيث توضع هذه الأحزمة على الكاحلين والفخذين والوركين كما يراقب المصاب باستمرار.

٢. النقل بواسطة أربعة مسعفين:

(transportation by Four paramedics):

وضعية المسعفين:

- يقف المسعفون على زوايا النقالة الأربعة.
- يتخذ المسعفون وضعية القرفصاء بحيث يشكل فخذي المسعف زاوية قائمة مع بعضهما.
- يقف قائد الفريق إلى الخلف بالنسبة للمحمل وتكون مهمته:
- إدارة عملية النقل، التأكد من تجهيز النقالة جيداً ومن تركيز المصاب وثبتيته، كما أنه يراقب المصاب باستمرار خلال عملية النقل وهو من يعطي التعليمات.
- بعد أن يجلس المسعفون بطريقة القرفصاء يمكن قبضة النقالة بكلتا اليدين.



طرق نقل الرصايين:

(Methods of transporting infected persons):

١. النقل بواسطة المحمل - النقالة:

(transportation by mobile):

- إن نقل المصاب بالنقالة هو مهمة يؤديها



- يجب على قائد الفريق أن ينتبه إلى كيفية توزيع عناصر فريقه، فإذا كان هناك إختلاف في القدرة على الحمل أو إختلاف في أطوال المسعفين فيقف المسعفان الأقل قدرة على الحمل أو الأقصر في جهة واحدة، مع العلم أنه يفضل دائماً إنتقاء أفراد الفريق بحيث تكون أطوالهم وأحجامهم متناسبة، كما أنه يجب عليهم التدريب بشكل دائم على العمل المشترك.

٥. اجتياز العقبة :

(traversing the Aqaba):

أثناء مسير الفريق الإسعافي قد يواجهون عقبة ما (حفرة كبيرة أو جدار أو كومة أحجار) وهنا يصرخ أحد المسعفين الأماميين (قف عقبة) فيقف الفريق ويعطي القائد مكانه للمسعف المجاور له ويقوم بفحص العقبة وإختيار طريقة تجاوزها، مع العلم أن طريقة اجتياز العقبة ترجع إلى نوعية العقبة، وهنا توجد العديد والعديد من الطرق المرتجلة بحيث يلتزم المسعفون أثناء اجتياز العقبة بالحفاظ على النقالة مستقيماً قدر الإمكان وتوزيع الأثقال على كافة الأفراد بتساو قدر الإمكان أيضاً.



٣. النقل بواسطة خمسة مسعفين :

(transportation by Five paramedics):

هنا يكون قائد الفريق غير مشارك في عملية النقل وإنما يسير بجانب النقالة ليراقب عملية النقل وينبه المسعفين حين حدوث خلل ما، كما يراقب المصاب بدقة، وتعطى نفس التعليمات ونفس الوضعيات السابقة.

٤. النقل بواسطة مسعفين :

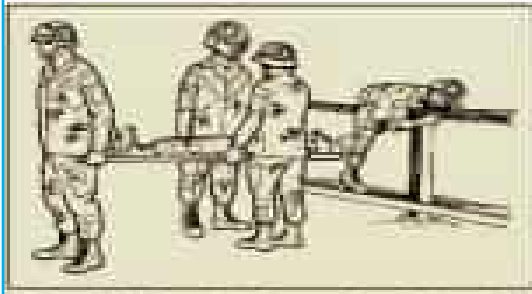
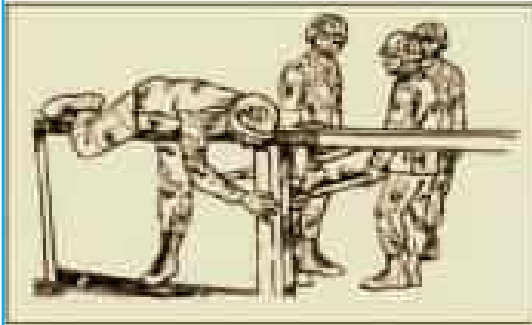
(transportation by paramedics):

- تستعمل هذه الحالة عندما يكون عدد المسعفين اثنين فقط، وهنا عملية النقل تكون متعبة لذا وجب أن يلتزم المسعفان بمبادئ الحمل بدقة، ويقف قائد الفريق خلف النقالة ويعطي التعليمات، وتعطى نفس التعليمات ونفس الوضعيات السابقة.

- في حال توفر ثلاثة مسعفين لتنفيذ عملية النقل، فهنا يقف المسعف الأقوى إلى الخلف من النقالة، أما المسعفان الآخران فيقفان إلى الأمام.

المسعف الرابع	المسعف الثالث	المسعف الثاني	المسعف الأول	قائد المجموعة
مستعد	مستعد	مستعد	مستعد	انتبه للاستعداد
بعد الرفع يتجه المسعفون إلى جهة المسير بحيث يسكون المقابض بأيديهم القريبة من النقالة ويمكن استعمال كلتا اليدين في حال نقل مصاب ثقيل الوزن.				انتبه للرفع - ارفع
يسير الفريق بشكل متناسق محافظين على بقاء النقالة مستقيمًا وعلى ثبات المصاب.				سر
يقف المسعفون جميعهم				قف
يوضع النقالة برفق على الأرض والركب منتشية بينما الظهر يكون مشدوداً.				انتبه للوضع ضع

موقعه، ثم يتابع الفريق سيره بانتظام.



٥ مثال: اجتياز عقبة قليلة الارتفاع (سور أو جدار):

- عند الوصول إلى العقبة يصرخ أحد المسعفين الأماميين (قف عقبة).
- يترك قائد الفريق (١) مكانه إلى المسعف المجاور (٣) له ليحمل عنه ويتقدم لفحص العقبة.
- يقوم المسعف (٢) بتجاوز العقبة.
- يرسل المسعفان الأماميان النقالة إلى المسعف (٢) الذي يتلقى النقالة وهو يتحرك للأمام.
- يتحرك المسعفان الأماميان باتجاه المسعف الخلفي وهما يسندان النقالة من جانبيه لتخفيف العبء على المسعف (٢) والمسعف الخلفي الذين يستمران في تحريك النقالة إلى الأمام.
- عندما يصل آخر النقالة إلى أعلى العقبة يمسك المسعفان الجانيان (الذين كانا في الأمام) المقبضين الخلفيين للنقالة، ليمررا فوق العقبة ويقوم المسعف الخلفي مباشرة بتجاوز العقبة واستلام مكانه.
- يعود المسعفان الجانيان إلى أول النقالة ليستلما مكانهما ويرجع قائد الفريق إلى الخلف ليأخذ

٧. اجتياز درج:

(Traverse a drawer):

❖ في حال واجه المسعفون أثناء عملية النقل درجاً ما، فإنهم يقومون باجتيازه ملتزمين قدر الإمكان بمبادئ الحمل والنقل، وكذلك الحفاظ على النقالة بوضعية مستقيمة دون أي ميلان، فعند صعود الدرج يقوم المسعفان الخلفيان برفع النقالة من الخلف للحفاظ على وضعيته المستقيمة (وضعية التكب).

❖ وعند نزول الدرج يقوم المسعفان الأماميان بالتكب.

٦. النقل بوضعية التكب (الجنازة):

❖ تنفذ وضعية التكب (الجنازة) عند قيام الفريق باجتياز عقبة، أو عند قيام الفريق بالمسير على درج، وهنا يقف المسعفون بشكل مواجه وكتفا يديهم تمسك بالمقبض، ثم يعطي القائد أمر «تتكب».

❖ هنا يرفع المسعفون بشكل منسجم النقالة وهم يتجهون باتجاه الحركة بحيث تصبح النقالة قريباً جداً من كتف كل مسعف، وتمسك يد واحدة بالمقبض ثم يسير الفريق.





13

MANAGEMENT OF EMERGENCY TASKS
إدارة المهام الإسعافية

14

إدارة المهام الإسعافية

Management of emergency tasks

١. إن عملية النقل تتطلب أفراد خاصه إلى جانبك لمساعدتك ولا يمكن القيام بها بمفردك ولا يمكن أن تترك موقعك من أجل نقل مصاب.
٢. توفير وسيلة إتصالات لك ولفريقك.
٣. تأمين وسيلة نقل مناسبة (سيارة إسعاف).
٤. تسهيل عملية الإستطلاع.

B. مرحلة دراسة المخاطر (الاستطلاع) (Risk study phase (Survey))

وهذه عبارة عن دراسة نظرية وميدانية للوصول إلى:

١. معرفة التشكيلات القتالية وتوزيعها على الأرض.
٢. معرفة أماكن العدو.
- معرفة طبيعة الأرض من حيث المساحة والاتجاهات، ومعرفة حدودك من حيث:
- الأماكن الآمنة.
- خطوط الإمداد والنقل.
- القرى وأماكن التجمعات السكانية.
- الأماكن الحارة والباردة.
- الأماكن التي يكثر فيها الأشجار، الجبال، الخنادق، الكهوف.
- المركز الإسعافي.
٣. الأسلحة التي قد يستخدمها العدو طيران، قنص، مشاة، زحف، تسلل.
٤. طبيعة المهمة الموكلة للمجاهدين جبهة هجومية، جبهة دفاعية، غزوة وإنسحاب.
٥. معرفة الأمراض والأوبئة المنتشرة في المنطقة مثل (جبهة حرض تنتشر الملاريا، جبهة نعرز تنتشر حمى الضنك).

مهام الإسعاف الأساسي:

(Basic Ambulance functions):

١. المهمة الأساسية للمسعف هي تقديم الخدمة الإسعافية المتقدمة للفصيل.
٢. متابعة إسعافي المجاميع، وفريق النقل، وتأهيلهم.
٣. تثقيف المجاهدين إسعافياً وصحياً.
٤. وضع التعليمات الإسعافية والصحية للمجاهدين.
٥. وضع الخطة الإسعافية (أين أنا، وما خلفي، وأين سأكون).
٦. رفع وشرح الخطة للمشرف العسكري، وإسعافي المجاميع.
٧. الاهتمام بالمقتنيات الإسعافية والمحافظة عليها.

الخطة الإسعافية:

(Emergency plan):

هي مجموعة التدابير والإجراءات التي يقوم بها مسعف الفصيل إستعداداً لمواجهة المخاطر المحتملة، ووضع الخطط اللازمة لمواجهة لما قد ينجم عنها من آثار على المجاهدين، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لتنفيذ هذه الخطط متى ما دعت الحاجة إلى تنفيذها.

مراحل الإعداد والتجهيز:

(Stages of preparation and processing):

A. التعريف بمهمتك للمشرف العسكري فور وصولك والتأكيد على:

(Defining the duties of the military supervisor):



14

٤. التأكد من جاهزية المركز الإسعافي وإعلامه والتنسيق معه.

F. تحديد الاحتياجات الصحية:

(Determination of health needs):

وهذه تتعلق بتحديد الاحتياجات الصحية للمصابين:

١. كم عدد الإصابات المتوقعة؟
٢. توزيع الأدوات الإسعافية على الإسعافيين.
٣. ما هي الأمراض المزمنة وما هي الأمراض الحادة وكم نسب إنتشارها في البلد الأصلي؟
٤. هل هناك أمراض متوطنه قابلة للتحويل إلى أوبئة عند إنتقالها؟

G. مرحلة ما قبل الاستقبال:

(Pre-reception stage):

١. تحديد موقع الأخلاء وضع مشرفين وموجهين عليها.
٢. إحضار وسائل النقل لنقل المصابين لأخذهم لمناطق الفرز والعلاج.

H. مشاركته الخطة مع الآخرين:

(Share the plan with others):

١. التنسيق مع القيادة العسكرية ومشرف الموقع
٢. رسم الخطة الإسعافية والموافقة عليها (أين أنا، وما خلفي، وأين سأكون).
٣. اطلاع المشرف على الخطة الإسعافية والاتفاق عليها.
٤. شرح الخطة لمسعفي المجاميع، للقيام بالعمل نيابة عنك في حال غيابك أو تأذيك لا سمح الله.

C. تحديد المواقع:

(Determine of site):

١. تحديد أنسب موقع للإخلاء، من خلال دراسة النواحي الجغرافية الدقيقة للخطة الميدانية على أن يؤخذ في الحسبان العلاقة السكانية في كل جزء من تلك الحدود وسخونة أو برودة تلك المنطقة وأهميتها الإستراتيجية والعسكرية (هل يمكن أن تتحول إلى نقطة صراع عسكري؟ أيمتد القصف إليها؟ وما هي نسبة الخطأ العسكري في وقوع قذائف عليها حتى لو كانت هذه المنطقة خارج مسرح العمليات.. الخ).
٢. تحديد المراكز الإسعافية التي تمثل الخلفية لك، وطرق الوصول إليها.
٣. تحديد أماكن المسعفين المقاتلين، والتواصل المستمر في حال تغيير المواقع.
٤. تحديد أنسب المواقع للإغاثة والنقل والإخلاء.

D. التخطيط للاتصالات:

(Planning Communications):

- وضع خطة متكاملة للاتصال قدر الإمكان، وكيفية وأسلوب تفعيل الخطة، والشفرات التصنيفية والسرية ... الخ.

E. التنسيق مع المراكز الخلفية والمدد:

(Coordination with back and extended centers):

١. تأمين الخط الإسعافي الخلفي.
٢. تأكد من وجود وسيلة النقل.
٣. التأكد من وجود فريق النقل.

٩. كن خذوها:

وقدم للمصاب الطعام والشراب إن كانت إصابته تسمح بذلك، ففي أغلب الإصابات يشعر المصاب بالعطش، ويطلب الماء، فأعطه قليلاً بين الحين والآخر، ووضح له خطورة كثرة شرب الماء، أما إذا كانت إصابته تمنعه من الشرب، فأخبره بمدى الخطورة على حياته، وأنه من غير المسموح له أن يشرب، ولكن يمكن أن تسمح له أن يبل ريقه برشفة (جفمة) ماء يحركها في فمه قليلاً ثم يبصقها.

١٠. إستشعر الوضعية الأنسب التي تريح المصاب:

وساعده في التحرك، أو تغيير وضعيته، وقد يكون لديه رأي أفضل يريحه، أو يطلبه، فساعده في ذلك.

١١. حافظ على أدوات المصاب:

وخلال عملية النقل، قم بإرسالها معه إلى المركز، وأكتب اسمه على سلاحه وضع أغراضه في كيس مكتوب عليه اسمه.

التعامل مع الأسرى:

قال تعالى (ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيمماً وأسيراً).

أ- فتش الأسير قبل أي إجراء إسعافي.
ب- طمئنه وأعلمه طبيعة عملك والغرض من وجودك.

ت- قم بعملك الإسعافي للأسير، مثله مثل المجاهد.
ث- في حال كانت الإصابة غير خطيره، أحكم وثاقه، ولا تعطيه ظهره.

ج- عند القيام بعملك، لا تترك سلاحك بالقرب منه، واجعل أحد المجاهدين بجانبك لحمايتك.

ح- لا تقم بضرب الأسير، ولا تدع أحد يضربه، قال الإمام علي عليه السلام (الناس صنفان، أخ لك في الدين ونظير لك في الخلق).

تعامل المسعف مع المصاب:

(The medic treats the injured person)

١. الإحسان:

كن محسناً وتجنب الغلظة مع جميع الناس، سواء جريح أو غيره، مجاهد أو أسير، فتعاملك يأتي من باب الإحسان ومن باب المسؤولية الملقاة على عاتقك.

٢. الصبر:

قال تعالى (إن الله مع الصابرين) : إن موقعك يتطلب منك أعلى درجات الصبر، فأنت الشخص الذي يحتوي آلام وآهات الآخرين.

٣. طهانة المصاب:

قال تعالى (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) : تذكر دائماً أن تطمئن المصاب في جميع الأحوال، فذلك سيهدئه أولاً ويساعدك على أداء عملك بالشكل المطلوب ثانياً.

٤. كن مهتسماً:

فالمصاب دائماً ينظر إلى وجهك ليعرف مدى خطورة إصابته، فكن حريص على أن تكون ملامح وجهك مطمئنه.

٥. لا تنفعل ولا تغضب أبداً على المصاب.

٦. لا تقم بإخبار المصاب أي أخبار محزنة:

قد تزيد من إحباطه، كأن تخبره أن مجموعته أستهدفت، أو أن صديق مقرب له قد أصيب بمكره لا قدر الله.

٧. عند فحصك للمصاب:

تجنب كشف عورته أمام الآخرين، وقم باللباسه بعد فحصك له، ولا تترك عورته مكشوفه حتى أمامك من دون سبب.

٨. المحافظة على سر المصاب :

يعتبرك المصاب أمين سره، فلا تقم بإخبار أي شخص بما يقول لك.

التعامل مع جثامين الشهداء

Dealing with dead bodies

إن وجد، وفي حال لم يتوفر ذلك، غطه بطانيه أو شرشف أو ملايه.

٦. سجل بيانات الشهيد (الإسم، الإسم الجهادي، المنطقة، المحافظة، الرقم العسكري، اسم المنطقة التي أستشهد فيها، تاريخ الإستشهاد).

٧. إجمع مقتنيات الشهيد وحافظ عليها، وسجل اسمه عليها، وأرسلها مع الجثمان.

٨. في حال تأخر نقل جثمان الشهيد، ضعه في المكان الأكثر بروده.

٩. إجمع ولملم الأشلء والأطراف المبتورة في حال كانت ممزقة.

١٠. في حال وجود نزييف، قم بحشو مكان النزييف، واربطه برباط ضاغط.

١١. يقوم فريق النقل بنقل جثمان الشهيد وأدواته إلى المركز الإسعافي.

إنَّ من الأدب والإحترام والإجلال عند وصول جثمان أحد المجاهدين ولا يوجد لديك مصابين، أن تقوم بالتعرف عليها وإزالة أي دم أو أتربة على وجهه أو جسد الشهيد، لأن الله سبحانه وتعالى قد كرم الشهيد ورفعته إليه، من الواجب القيام بعمل التالي:

١. ضع أيدي الشهيد على بطنه، وأربط إبهامي اليدين مع بعضهما بقطعه من الشاش.

٢. ضع رباط من تحت الفك السفلي إلى وسط الرأس، واربطه حتى يقفل فم الشهيد.

٣. أغلق جفني عين الشهيد، أو ضع لاصق عليهما.

٤. أربط إبهامي القدم مع بعضهما البعض بقطعه من الشاش.

٥. ضع الشهيد في الكيس المعد للجثامين



معوقات العمل الإسعافي

Obstacles to emergency work

- حاول التدريب دائماً على العمل في الظلام.
- إبحث عن مكان مقفل مثل كهف أو ما شابه واستخدم الإضاءة الخفيفة.

٢. إستعمال الإضاءة من قبل الآخرين:
أثناء نقل وإسعاف الحالات إليك مثل إضاءة السيارة أو الكشف فعليك دائماً تحذير الآخرين بإطفاء الأنوار قبل الوصول إلى موقعك.

٣. الإتصال (Communication):

عدم توفر وسيلة اتصال، حاول وفور وصولك إلى الجبهة أن توفر لنفسك ولرفيقتك وسيلة اتصال مباشرة، أو الاتفاق مع المشرف والباقيين على كيفية التواصل عند احتياجك لهم أو طلب مساعدتك.

٤. المسعف المقاتل:

(Combat physician):

(أ) غياب المسعف المقاتل: تأكد دائماً أن جميع الأرتاب وجميع المجاميع لديها مسعف مقاتل، فذلك يسهل عملك وفي حال عدم وجود مسعف في مجموعة ما، فقم بتأهيل أحد الأفراد في المجموعة كمسعف، ووفر له بعض التجهيزات البسيطة مثل الأربطة.
(ب) عدم كفاءة المسعف المقاتل: قد تصل إليك حالات حرجة للغاية وعلى وشك الوفاة نتيجة لسوء الإجراءات الإسعافية التي تلقاها المصاب من المسعف المقاتل، فكن حريصاً على تقييم أداء المسعفين المقاتلين وقم بإعادة تأهيل من رأيت عدم كفاءة في عمله.

من المعوقات التي قد تواجهك كالتالي:

١. المصاب (Injured):

(أ) المصاب الغير متعاون:

(The uncooperative patient):

قد تتفاجأ أحياناً بعدم تعاون المصاب معك، ومن أجل تجنب حدوث ذلك قم بتعريف المصاب من أنت وما طبيعية عملك أن يتعاون معك فيما تطلب منه، ومساعدتك للمحافظة على سلامته.

(ب) الصراخ:

(Screaming):

قد تواجه أحياناً مصاب يصرخ كثير وذلك نتيجة الألم الشديد، وقد يؤدي إلى:

- كشف موقعك في حال كنت في مكان قريب من العدو.
- قد يؤثر على راحة المصابين الآخرين.
- قد يؤثر أيضاً على أداء عملك.

ومن أجل تلافي ذلك بإمكانك القيام بما يلي:

- قم بإعطاء المصاب مسكن للألام.
- حاول إخلاء ونقله في أسرع وقت ممكن.

٢. الإضاءة (Lighting):

٢. إن من أكثر المعوقات التي تواجه المسعف هي عدم إمكانية إستخدام الإضاءة، وذلك بسبب قوانين الجبهة، ومن أجل تلافي هذا:



14

(Leave the place temporarily):

ومن الأسباب التي قد تجعلك تترك موقعك:

- عدم وجود فريق النقل:

من المفترض تواجد فريق النقل، وفي حال غيابه، فإنك لست المعني الوحيد بالنقل، عليك أن تشعر الآخرين بالتعاون في ذلك، وتوضيح مهمتك الأساسية كمسعف يجب تواجده في مكانه المحدد، وابتعاده عن مكانه في خطورة في حال وصول أي حالة وأنت مشغول بالنقل.

- عدم وجود المسعف المقاتل.

فكن حريصاً على أداء عملك الإسعافي ولا تترك موقعك لأن ذلك يعد من التفريط، وكن حريص على أن يكون فريق النقل متوفر دائماً وقم أيضاً بتأهيل مسعفين مقاتلين.

٩. حالات الطقس:

(Weather):

إن المشكلات التي قد تواجه المسعف الحر الشديد أو البرد الشديد، فهي تؤثر أولاً على المسعف نفسه، وتؤثر أيضاً على حالة المصابين وكن حريص على إختيار مكان مناسب وقم بطلب ما تحتاج من المدد مثل البطانيات، الجواكت، الملابس الصوفية، ... الخ.

٥. التدخل من قبل الآخرين:

(Interference by others):

قد تواجه من بعض مرافقي المصاب تدخل أو توجيه أوامر لك أو أوامر تخالف أوامرك فقم دائماً بإبعاد المرافقين أثناء أداء عملك.

٦. تعدد الإصابات:

(Multiple injuries):

قد توجهك حالات كثيرة في نفس اللحظة، عليك أن تكون هادئاً وواثقاً بالله سبحانه وتعالى من أنه سوف يعينك.

٧. التمزيع:

(Flattening):

كن حريصاً على البحث عن مكان مموه بشكل كامل، وابحث عن أماكن بديلة في حال تعرض موقعك الأساسي للإكشاف، ومن الأسباب التي قد تؤدي إلى كشف موقعك:

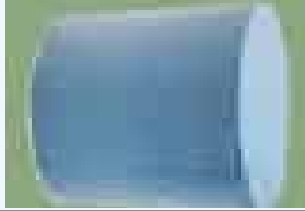
- كثرة الوافدين إليك فلا تدع أحد يكشف موقعك بدون داعي.
- القمامة ومخلفات الأكل وقوارير الشرب، فقم دائماً بدفنها.

٨. ترك موقعك بشكل مؤقت:



الحقيبة الإسعافية Emergency Bag

٣. قطن طبي.



٤. شاش لف (كبير، صغير).



٥. رباط ضاغط (كبير، صغير).



٦. جبائر (splinting):

الحقيبة الإسعافية:

(Emergency Bag)

إن الحقيبة الإسعافية تعتبر سلاحك الذي ومن خلالها تقهر بها أعداء الله، ومن الإعداد إستجابة لقوله سبحانه وتعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل). فكن حريصاً على الحفاظ عليها وأن تكون في أتم الجاهزية دائماً.

محتويات الحقيبة الإسعافية:

(Contents of the Emergency Bag):

أربطة وضادات:

(Bandages & dressing):

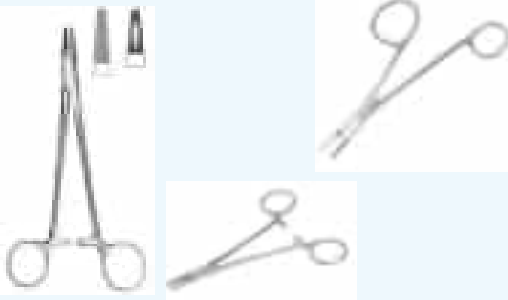
١. شاش (عادي، معقم) (Gauze).



٢. شاش ضاغط.



٤. حامل الأبره (نيدل هولدر).



٥. ملقاط (فور سيبس) (Forceps).



٦. خيوط جراحية (Surgical Sutures).



٧. مثبت عنق.



أدوات جراحية:

(Surgical instruments):

١. قفازات (جوني):



٢. مقص طبي (سيزر):



٣. مشارط جراحية (نايف):



٩. لصقة جراحية:



٧. براويز متعددة الأحجام:



١٠. مجاري هوائية (Airway):



٨. كانيولا متعددة الأحجام:



الهاليل والتهطرات:

(Solutions & disinfectants):

١. مغذية ملح (كلوريد الصوديوم):



14

154

٥. محلول الفورمالدهايد (الفورمالين):

Formaldehyde Solution- Formalin

بعض الأدوية الإسعافية:

(Some emergency drugs):

١. مسكنات: مثل: ديكلوفين أمبول، باراسيتامول
حبوب.



٢. مسكن نزلات البرد: مثل فلونيل حبوب، فلوتاب
حبوب:



٢. مغذية رينجر:



٣. أيودين:



٤. محلول الجلوترالديهايد (السايدكس) ٢٪ :

Glutaraldehyde solution -Cidex

٣. مضاد للمغص: مثل هيوسين:



٤. مواقف النزيف: مثل فيتامين k وديسبون.



أدوات أخرى:

(Other instruments):

١. نقالة.

٢. مقص ملابس.

٣. كرت بيان مصاب.

٤. دفتر وقلم.

٥. ترمومتر.

٦. مصباح ضوئي (كشاف).

٧. حبل.

٨. مشمعات بلاستيكية.



الإسعاف الحربي

جمادى الأولى

